

**E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE**

Identificación Interna: 900042103

Cód. Habilitación: 130010178101

Dirección: Zaragoza, Calle 29 N C2 BA 50-50 Teléfono: 6517190

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de Impresión: 07/09/2026 15:21

Centro de atención: Z01 - Zaragoza

Paciente: CC 45430103 - SOL BEATRIZ GARCIA MARQUEZ

Fecha de Nacimiento: 14/05/1955

Religión:

Régimen: 2 - Subsidiado

Dirección: BARRIO LA CANDELARIA SECTOR OMIRA SANCHEZ

Teléfono: 3015579674

Ocupación: 999: PERSONAS QUE NO HAN DECLARADO

OCUPACION

Grupo Poblacional:

Acompañante: YOELIDA GARCIA

Teléfono Acomp.: 3044001674

Dirección Acomp.:

Responsable:

Teléfono Resp.:

Dirección Resp.:

Médico Tratante: JUAN PABLO ORTIZ SALAZAR

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Fecha de Atención: 15/04/2022 22:36

Admisión: AD715724

Edad: 66 año(s), 11 mes(es) 1 día(s)

Creencia:

Nivel: 1

Lugar: Cartagena Bolívar

Raza:

Parentesco Acomp.:

Parentesco Resp.: HIJA

Especialidad: CUIDADO DEL PACIENTE EN ESTADO CRITICO

Impreso por: Pinvestigacion

Sexo: F

Estado Civil: Unión Libre

Carnet:

Etnia:

Tipo Vinculación: Beneficiario

EPICRISIS**DATOS DE LA CONSULTA**

Historia Clínica: Registro clínico de urgencias

Fecha de Ingreso: 18/02/2022 21:50

Cama: Cama2

Motivo de la Consulta:

ESTA APRETADA

ANTECEDENTES:

hipertension arterial cronica. diabetes mellitus tipo ii. enfermedad renal cronica (dializada). epoc. gastritis. falla cardiaca descompensada.

Síntesis de la Enfermedad:

PACIENTE CON ANTECEDENTES DE DM TIPO II, HTA IRC EN HEMODIALISIS PERITONIAL, CON ESQUEMA DE VACUACION DOS DOSIS CON AZTRAZENACA, QUIEN INGRESA AL SERVICIO MANIFESTANDO LOS FAMILIARES QUE DESDE HACE DOS DIAS HA ESTADO PRESENTANDO DIFICULTAD RESPIRATORIA EL CUAL DICE QUE SE LE AGUDIZO EL DIA DE AYER, POR LO QUE REQUIRIO MANEJO MEDICO EN PRIMER NIVEL DE ATENCION PRESENTANDO LEVE MEJORIA CLINICA POR LO QUE CONSIDERARON DAR SALIDA, PERO DICE QUE EL DIA DE HOY SE LE AGUDIZO EL PROCESO DE DIFICULTAD RESPIRATORIA INGRESANDO A ESTA INSTITUCION SOLICITANDO VALORACION Y MANEJO MEDICO

Paciente en unidad de cuidados intensivos, bajo soporte ventilatorio mecanico a traves de traqueostomia, gastrostomia funcional. Sin presentar cambios en su condicion cronica, pendiente traslado al hospital para continuar manejo, se encuentra con ventilador de transporte, bien acoplada.

Revisión Por Sistema:

RESPIRATORIO

EXAMEN FISICO:**Apariencia a su llegada:**

PACIENTE EN REGULAR ESTADO

Cabeza, cara y órganos de los sentidos:

NORMOCEFALO MUCOSAS SEMI HUMEDAS PUPILAS ISOREACTIVAS A LA LUZ CUELLO MOVIL SIN MASAS NI ADENOPATIAS SIN INGURGITACION YUGULAR

Tórax:

SIMETRICO EXPANSIBLE CON LEVE TIRAJE INTERCOSTALES RUIDOS CARDIACOS RITMICOS PULMONES CON DISMINUCION DEL MURMULLO VESICULAR DE HEMITORAX DERECHO Y CON SIBILANTE Y CREPITOS FINOS DEL HEMITORAX IZQUIERDO

Abdomen:

BLANDO DEPRESIBLE NO MASAS NO MEGALIAS PERISTASIS PRESENTE

Piel y faneras:

NORMAL

Genito-Urinario:

NO EXPLORADOS

Extremidades:

EUTROFICAS SIMETRICO EXPANSIBLE RUIDOS CARDIACOS RITMICOS PULMONES CLAROS

Sistema nervioso central:

GLASGOW 15/15

Análisis:

PACIENTE CON ANTECEDENTES DE DM TIPO II, HTA IRC EN HEMODIALISIS PERITONIAL, CON ESQUEMA DE VACUACION DOS DOSIS CON AZTRAZENACA, QUIEN INGRESA AL SERVICIO MANIFESTANDO LOS FAMILIARES QUE DESDE HACE DOS DIAS HA ESTADO PRESENTANDO DIFICULTAD RESPIRATORIA EL CUAL DICE QUE SE LE AGUDIZO EL DIA DE AYER, POR LO QUE REQUIRIO MANEJO MEDICO EN PRIMER NIVEL DE ATENCION PRESENTANDO LEVE MEJORIA CLINICA POR LO QUE CONSIDERARON DAR SALIDA, PERO DICE QUE EL DIA DE HOY SE LE AGUDIZO EL PROCESO DE DIFICULTAD RESPIRATORIA INGRESANDO A ESTA INSTITUCION SOLICITANDO VALORACION Y MANEJO MEDICO

PACIENTE QUE SE INGRESA AL SERVICIO BAJO EL CONTEXTO DE SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, CRISIS ASMATICA MODERADA NO DESCARTANDO UNA INSUFICIENCIA CARDIACA DESCOMPENSADA EDEMA PULMONAR, SE ORDENA MANEJO MEDICO REALIZACION DE PARACLINICOS DE

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:20:11 p. m.

Admisión: AD715724

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: SOL BEATRIZ GARCIA MARQUEZ

EPICRISIS

INGRESO Y REVALORAR

DIAGNÓSTICOS DE ENTRADA:

Diagnóstico Principal: J22X : INFECCION AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES

Diagnóstico Relacionado 1: U071 : COVID-19 (virus identificado)

EVOLUCIONES:

Fecha: 19/02/2022: 09:06:46, Historia: Notas de Urgencia, Prestador: ESTEFANY ARAQUE VERGARA, Especialidad: MEDICINA GENERAL

Asunto: NOTA EVOLUCION

Descripción: PACIENTE FEMEENINA QUIEN SWE REVALORA ENCONTRANDOSE ESTABLE ,A FEBRIL, REPORTE DE PARACLINICOS :FERRITNA :124 ALT:13 BUN:42 CRET:10.33 GLUC:155NE:135 BILIRRU 0.2 DIRCT IND:0.1 TOT:0.10 TP:12.0 TPP:26.2HEMOGRAMA: HB:11.0 HTO:36.7 LEUC:8.72 N:77.1 PLAQ :420SARS COV:NEGATIVOTAC DE TORAX : EVIDENCIA DERRAME PLEURAL EN AREA PULMONAR DERECHASE ORDENA VALORACION POR ESPECIALIDAD

Fecha: 20/02/2022: 01:32:38, Historia: Evolucion Clinica UCI, Prestador: GUSTAVO ADOLFO BUELVAS PIÑERES, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE 66 AÑOS DE EDAD, CON ANTECEDENTES DE HIPERTENSION ARTERIAL, DIABETES TIPO 2 INSULINODEPENDIENTE, ENFERMEDAD RENAL CRONICA EN TRR TIPO DIALISIS PERITONEAL Y EPOC SIN DIAGNOSTICO ESPIROMETRICO, QUIEN INGRESA A UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS EN CONTEXTO DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA SECUNDARIA A DERRAME PLEURAL DERECHO MASIVO DE ETIOLOGIA A ESTABLECER PARANEOPLASICO VS PARANEUMONICO.

RECIBO PACIENTE CONSCIENTE, ALERTA, ORIENTADA, AFEBRIL, HEMODINAMICAMENTE COMPENSADA, CIFRAS TENSIONALES EN METAS, SIN REQUERIMIENTO DE SOPORTE VASOACTIVO, EUCARDICA, RITMO SINUSAL, VENTILATORIAMENTE EUPNEICA, SIN USO DE MUSCULOS RESPIRATORIOS ACCESORIOS, SATURACIÓN O2 EN METAS CON REQUERIMIENTO DE OXIGENO SUPLEMENTARIO POR CANULA NASAL A 3 LT/MINUTO, TOLERANDO VIA ORAL CON DIETA HIPOSODICA E HIPOGLUCIDA, BUEN CONTROL METABOLICO, DIURESIS CONSERVADA.

PACIENTE CON INSUFICIENCIA RESPIRATORIA SECUNDARIA A DERRAME PLEURAL DERECHO MASIVO DE ETIOLOGIA A ESTABLECER, DOCUMENTADO EN TAC DE TORAX, QUIEN SE ENCUENTRA A LA ESPERA DE REALIZACION DE TORACENTESIS DERECHA POR CIRUGIA GENERAL PARA DRENAJE Y ESTUDIOS DE LIQUIDO PLEURAL QUE NOS PERMITA FILIAR CAUSA Y AJUSTAR MANEJO SEGUN HALLAZGOS. POR EL MOMENTO SE REALIZA CONCILIACIÓN FARMACOLOGICA PARA MANEJO DE PATOLOGÍAS DE BASE, SE SOLICITAN PARACLÍNICOS DE CONTROL. SE EXPLICA CONDUCTA MEDICA A PACIENTE Y FAMILIAR QUIENES REFIEREN ENTENDER Y ACEPTAR.

SE SOLICITA VALORACIÓN POR LOS SERVICIOS DE TERAPIA FÍSICA CUATRO VECES AL DÍA, TERAPIA OCUPACIONAL, FONOAUDIOLOGÍA PARA REHABILITACIÓN TEMPRANA Y PRECOZ DE PACIENTE, TERAPIA RESPIRATORIA INTEGRAL, PSICOLOGÍA CRÍTICA Y TRABAJO SOCIAL PARA REINTEGRO AL MEDIO Y NUCLEO FAMILIAR. SOPORTE NUTRICIONAL Y METABÓLICO CRÍTICO

PACIENTE CON ALTO RIESGO DE FALLA VENTILATORIA E INESTABILIDAD HEMODINAMICA Y REQUERIMIENTO DE SOPORTE VENTILATORIO INVASIVO QUE CONDICIONA NECESIDAD DE MONITORIZACION CONTINUA Y VIGILANCIA Estricta DE PARAMETROS VENTILATORIOS, NEUROLOGICOS, HEMODINAMICOS Y METABOLICOS.

Fecha: 20/02/2022: 11:29:51, Historia: Evolucion Clinica UCI, Prestador: WILLIAM YAMITH CASTRO MENDOZA, Especialidad: CIRUGIA GENERAL

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE 66 AÑOS DE EDAD, CON ANTECEDENTES DE HIPERTENSION ARTERIAL, DIABETES TIPO 2 INSULINODEPENDIENTE, ENFERMEDAD RENAL CRONICA EN TRR TIPO DIALISIS PERITONEAL Y EPOC SIN DIAGNOSTICO ESPIROMETRICO, QUIEN SE ENCUENTRA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS EN CONTEXTO DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA SECUNDARIA A DERRAME PLEURAL DERECHO MASIVO DE ETIOLOGIA A ESTABLECER: PARANEOPLASICO VS PARANEUMONICO.

RECIBO PACIENTE CONSCIENTE, ALERTA, ORIENTADA, AFEBRIL, HEMODINAMICAMENTE COMPENSADA, CIFRAS TENSIONALES EN METAS, SIN REQUERIMIENTO DE SOPORTE VASOACTIVO, EUCARDICA, RITMO SINUSAL, VENTILATORIAMENTE EUPNEICA, SIN USO DE MUSCULOS RESPIRATORIOS ACCESORIOS, SATURACIÓN O2 EN METAS CON REQUERIMIENTO DE OXIGENO SUPLEMENTARIO POR CANULA NASAL A 3 LT/MINUTO, TOLERANDO VIA ORAL CON DIETA HIPOSODICA E HIPOGLUCIDA, BUEN CONTROL METABOLICO (GLUCOMETRIA 95 MG/DL), DIURESIS CONSERVADA.

PARACLÍNICOS DEL DIA EVIDENCIAN HEMOGRAMA CON ANEMIA LEVE DE VOLUMENES NORMALES, SIN ALTERACIÓN EN SERIE BLANCA NI PLAQUETAS, FUNCIÓN RENAL CON HIPERAZEMIA CRÓNICA EN ASCENSO RESPECTO A CONTROL PREVIO, IONOGRAMA SIN TRASTORNOS HIDROELECTROLÍTICOS.

PACIENTE CON INSUFICIENCIA RESPIRATORIA SECUNDARIA A DERRAME PLEURAL DERECHO MASIVO DE ETIOLOGIA A ESTABLECER, DOCUMENTADO EN TAC DE TORAX INSTITUCIONAL QUE REPORTA DERRAME PLEURAL SEVERO DERECHO DISPOSICIÓN LIBRE, CON SEPARACIÓN PLEURAL AP DE 75 MM, ATELECTASIAS PASIVAS EN LÓBULO INFERIOR DERECHO Y EN EL SEGMENTO POSTERIOR DE LÓBULO SUPERIOR DERECHO, PARÉNQUIMA PULMONAR SIN IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DE CONSOLIDACIÓN NEUMÓNICA, ATELECTASIAS, MASAS O CAVITACIONES; SE ENCUENTRA A LA ESPERA DE REALIZACION DE TORACENTESIS DERECHA POR CIRUGIA GENERAL PARA DRENAJE Y ESTUDIOS DE LIQUIDO PLEURAL QUE NOS PERMITA FILIAR CAUSA Y AJUSTAR MANEJO SEGUN HALLAZGOS, DICHO PROCEDIMIENTO SE LLEVARA A CABO PREVIA REALIZACIÓN DE ECOGRAFIA PLEURAL CON MARCAJE INDICADA POR CIRUGIA GENERAL, POR EL MOMENTO CONTINUA MANEJO MEDICO SIN CAMBIOS. SE EXPLICA CONDUCTA MEDICA A PACIENTE Y FAMILIAR QUIENES REFIEREN ENTENDER Y ACEPTAR.

PENDIENTE VALORACIÓN POR LOS SERVICIOS DE TERAPIA FÍSICA CUATRO VECES AL DÍA, TERAPIA OCUPACIONAL, FONOAUDIOLOGÍA PARA REHABILITACIÓN TEMPRANA Y PRECOZ DE PACIENTE, TERAPIA RESPIRATORIA INTEGRAL, PSICOLOGÍA CRÍTICA Y TRABAJO SOCIAL PARA REINTEGRO AL MEDIO Y NUCLEO FAMILIAR. SOPORTE NUTRICIONAL Y METABÓLICO CRÍTICO

PACIENTE CON ALTO RIESGO DE FALLA VENTILATORIA E INESTABILIDAD HEMODINAMICA Y REQUERIMIENTO DE SOPORTE VENTILATORIO INVASIVO QUE CONDICIONA NECESIDAD DE MONITORIZACION CONTINUA Y VIGILANCIA Estricta DE PARAMETROS VENTILATORIOS, NEUROLOGICOS, HEMODINAMICOS Y METABOLICOS.

Fecha: 20/02/2022: 16:05:18, Historia: Evolucion Clinica UCI, Prestador: WILLIAM YAMITH CASTRO MENDOZA, Especialidad: CIRUGIA GENERAL

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE 66 AÑOS DE EDAD, CON ANTECEDENTES DE HIPERTENSION ARTERIAL, DIABETES TIPO 2 INSULINODEPENDIENTE, ENFERMEDAD RENAL CRONICA EN TRR TIPO DIALISIS PERITONEAL Y EPOC SIN DIAGNOSTICO ESPIROMETRICO, QUIEN SE ENCUENTRA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS EN CONTEXTO DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA SECUNDARIA A DERRAME PLEURAL DERECHO MASIVO DE ETIOLOGIA A ESTABLECER: PARANEOPLASICO VS PARANEUMONICO.

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:20:11 p. m.

Admisión: AD715724

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: SOL BEATRIZ GARCIA MARQUEZ

EPICRISIS

RECIBO PACIENTE CONSCIENTE, ALERTA, ORIENTADA, AFEBRIL, HEMODINAMICAMENTE COMPENSADA, CIFRAS TENSIONALES EN METAS, SIN REQUERIMIENTO DE SOPORTE VASOACTIVO, EUCARDICA, RITMO SINUSAL, VENTILATORIAMENTE EUPNEICA, SIN USO DE MUSCULOS RESPIRATORIOS ACCESORIOS, SATURACIÓN O2 EN METAS CON REQUERIMIENTO DE OXIGENO SUPLEMENTARIO POR CANULA NASAL A 3 LT/MNUTO, TOLERANDO VIA ORAL CON DIETA HIPOSODICA E HIPOGLUCIDA, MAL CONTROL METABOLICO (GLUCOMETRIA 307 MG/DL), DIURESIS CONSERVADA.

PACIENTE CON INSUFICIENCIA RESPIRATORIA SECUNDARIA A DERRAME PLEURAL DERECHO MASIVO DE ETIOLOGIA A ESTABLECER, DOCUMENTADO EN TAC DE TORAX INSTITUCIONAL QUE REPORTA DERRAME PLEURAL SEVERO DERECHO DISPOSICIÓN LIBRE, CON SEPARACIÓN PLEURAL AP DE 75 MM, ATELECTASIAS PASIVAS EN LÓBULO INFERIOR DERECHO Y EN EL SEGMENTO POSTERIOR DE LÓBULO SUPERIOR DERECHO, PARÉNQUIMA PULMONAR SIN IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DE CONSOLIDACIÓN NEUMÓNICA ATELECTASIAS, MASAS O CAVITACIONES; SE ENCUENTRA A LA ESPERA DE REALIZACIÓN DE TORACENTESIS DERECHA POR CIRUGÍA GENERAL PARA DRENAJE Y ESTUDIOS DE LIQUIDO PLEURAL QUE NOS PERMITA FILIAR CAUSA Y AJUSTAR MANEJO SEGUN HALLAZGOS, DICHO PROCEDIMIENTO SE LLEVARA A CABO PREVIA REALIZACIÓN DE ECOGRAFIA PLEURAL CON MARCAJE INDICADA POR CIRUGIA GNERAL, POR EL MOMENTO CONTINUA MANEJO MEDICO SIN CAMBIOS.

SEGUIMIENTO POR LOS SERVICIOS DE TERAPIA FÍSICA CUATRO VECES AL DÍA, TERAPIA OCUPACIONAL, FONOAUDIOLOGÍA PARA REHABILITACIÓN TEMPRANA Y PRECOZ DE PACIENTE, TERAPIA RESPIRATORIA INTEGRAL, PSICOLOGÍA CRÍTICA Y TRABAJO SOCIAL PARA REINTEGRO AL MEDIO Y NUCLEO FAMILIAR. SOPORTE NUTRICIONAL Y METABÓLICO CRÍTICO

PACIENTE CON ALTO RIESGO DE FALLA VENTILATORIA E INESTABILIDAD HEMODINAMICA Y REQUERIMIENTO DE SOPORTE VENTILATORIO INVASIVO QUE CONDICIONA NECESIDAD DE MONITORIZACION CONTINUA Y VIGILANCIA ESTRUCTA DE PARAMETROS VENTILATORIOS, NEUROLOGICOS, HEMODINAMICOS Y METABOLICOS.

Fecha: 20/02/2022: 20:50:27, Historia: Evolucion Clinica UCI, Prestador: GUSTAVO ADOLFO BUELVAS PIÑERES, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE 66 AÑOS DE EDAD, CON ANTECEDENTES DE HIPERTENSION ARTERIAL, DIABETES TIPO 2 INSULINODEPENDIENTE, ENFERMEDAD RENAL CRONICA EN TRR TIPO DIALISIS PERITONEAL Y EPOC SIN DIAGNOSTICO ESPIROMETRICO, QUIEN SE ENCUENTRA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS EN CONTEXTO DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA SECUNDARIA A DERRAME PLEURAL DERECHO MASIVO DE ETIOLOGIA A ESTABLECER: PARANEOPLASICO VS PARANEUMONICO.

ACTUALMENTE PACIENTE CONSCIENTE, ALERTA, ORIENTADA, AFEBRIL, HEMODINAMICAMENTE COMPENSADA, CIFRAS TENSIONALES EN METAS, SIN REQUERIMIENTO DE SOPORTE VASOACTIVO, EUCARDICA, RITMO SINUSAL, VENTILATORIAMENTE EUPNEICA, SIN USO DE MUSCULOS RESPIRATORIOS ACCESORIOS, SATURACIÓN O2 EN METAS CON REQUERIMIENTO DE OXIGENO SUPLEMENTARIO POR CANULA NASAL A 3 LT/MNUTO, TOLERANDO VIA ORAL CON DIETA HIPOSODICA E HIPOGLUCIDA, MAL CONTROL METABOLICO (GLUCOMETRIA 307 MG/DL), DIURESIS CONSERVADA.

PACIENTE CON INSUFICIENCIA RESPIRATORIA SECUNDARIA A DERRAME PLEURAL DERECHO MASIVO DE ETIOLOGIA A ESTABLECER, DOCUMENTADO EN TAC DE TORAX INSTITUCIONAL QUE REPORTA DERRAME PLEURAL SEVERO DERECHO DISPOSICIÓN LIBRE, CON SEPARACIÓN PLEURAL AP DE 75 MM, ATELECTASIAS PASIVAS EN LÓBULO INFERIOR DERECHO Y EN EL SEGMENTO POSTERIOR DE LÓBULO SUPERIOR DERECHO, PARÉNQUIMA PULMONAR SIN IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DE CONSOLIDACIÓN NEUMÓNICA ATELECTASIAS, MASAS O CAVITACIONES; SE ENCUENTRA A LA ESPERA DE REALIZACIÓN DE TORACENTESIS DERECHA POR CIRUGÍA GENERAL PARA DRENAJE Y ESTUDIOS DE LIQUIDO PLEURAL QUE NOS PERMITA FILIAR CAUSA Y AJUSTAR MANEJO SEGUN HALLAZGOS, DICHO PROCEDIMIENTO SE LLEVARA A CABO PREVIA REALIZACIÓN DE ECOGRAFIA PLEURAL CON MARCAJE INDICADA POR CIRUGIA GNERAL, POR EL MOMENTO CONTINUA MANEJO MEDICO SIN CAMBIOS.

SEGUIMIENTO POR LOS SERVICIOS DE TERAPIA FÍSICA CUATRO VECES AL DÍA, TERAPIA OCUPACIONAL, FONOAUDIOLOGÍA PARA REHABILITACIÓN TEMPRANA Y PRECOZ DE PACIENTE, TERAPIA RESPIRATORIA INTEGRAL, PSICOLOGÍA CRÍTICA Y TRABAJO SOCIAL PARA REINTEGRO AL MEDIO Y NUCLEO FAMILIAR. SOPORTE NUTRICIONAL Y METABÓLICO CRÍTICO

PACIENTE CON ALTO RIESGO DE FALLA VENTILATORIA E INESTABILIDAD HEMODINAMICA Y REQUERIMIENTO DE SOPORTE VENTILATORIO INVASIVO QUE CONDICIONA NECESIDAD DE MONITORIZACION CONTINUA Y VIGILANCIA ESTRUCTA DE PARAMETROS VENTILATORIOS, NEUROLOGICOS, HEMODINAMICOS Y METABOLICOS.

Fecha: 21/02/2022: 10:54:21, Historia: Notas, Prestador: SONIA LOURDES CARRILLO BELTRAN, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Asunto: NEFROLOGIA- DR PUELLO

Descripción: FEMENINA 66 AÑOS, DE EDAD, ANTECEDENTES DE: HTA, DBT2, ERC5 D EN CAPD, INTERNADA EN UCI CON DX: DERRAME PELURAL E/E, NO SINTOMAS DE UREMIA, NO OBRECARGA HIDRICA, PACIENTE ANURIACA. ULTIMA DIALISIS HACE 48 HORAS. CREAtinina: 11 mg/dl. SE SUGIERE ROTAR TERAPIA ACPD, MIENTRAS ESTE HOSPITALIZADA, LUEGO CONTINUAUR MODALIDAD CAPD. PRESCRIPCION DE TRR. MODALIDAD: ACPD; TIEMPO: 12 HORAS, VOLUMEN TOTOAL: 10 LITROS, VOLUMEN DE INFUCION: 2 LITROS, DIANEAL: 2.5%;

Fecha: 21/02/2022: 10:56:14, Historia: Notas, Prestador: SONIA LOURDES CARRILLO BELTRAN, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Asunto: NEFROLOGIA- DR PUELLO

Descripción: FEMENINA 66 AÑOS, DE EDAD, ANTECEDENTES DE: HTA, DBT2, ERC5 D EN CAPD, INTERNADA EN UCI CON DX: DERRAME PELURAL E/E, NO SINTOMAS DE UREMIA, NO OBRECARGA HIDRICA, PACIENTE ANURIACA. ULTIMA DIALISIS HACE 48 HORAS. CREAtinina: 11 mg/dl. SE SUGIERE ROTAR TERAPIA ACPD, MIENTRAS ESTE HOSPITALIZADA, LUEGO CONTINUAUR MODALIDAD CAPD. PRESCRIPCION DE TRR. MODALIDAD: ACPD; TIEMPO: 12 HORAS, VOLUMEN TOTOAL: 10 LITROS, VOLUMEN DE INFUCION: 2 LITROS, DIANEAL: 2.5%; DR: LUIS PUELLO INTERNISTA- NEFROLOGO RM7921698

Fecha: 21/02/2022: 11:44:27, Historia: Evolucion Clinica UCI, Prestador: JAIME SARMIENTO CALDERON, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE 66 AÑOS DE EDAD, CON ANTECEDENTES DE EXTABAQUISMO PESADO, HIPERTENSION ARTERIAL, DIABETES TIPO 2 INSULINODEPENDIENTE, ENFERMEDAD RENAL CRONICA EN TRR TIPO DIALISIS PERITONEAL Y EPOC SIN DIAGNOSTICO ESPIROMETRICO, QUIEN SE ENCUENTRA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS EN CONTEXTO DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA SECUNDARIA A DERRAME PLEURAL DERECHO MASIVO DE ETIOLOGIA A ESTABLECER: PARANEOPLASICO VS PARANEUMONICO.

RECIBO PACIENTE CONSCIENTE, ALERTA, ORIENTADA, AFEBRIL, HEMODINAMICAMENTE COMPENSADA, CIFRAS TENSIONALES EN METAS, SIN REQUERIMIENTO DE SOPORTE VASOACTIVO, EUCARDICA, RITMO SINUSAL, VENTILATORIAMENTE EUPNEICA, CON MODERADO USO DE MUSCULOS RESPIRATORIOS ACCESORIOS, SATURACIÓN O2 EN METAS CON REQUERIMIENTO DE OXIGENO SUPLEMENTARIO POR CANULA NASAL A 3 LT/MNUTO, TOLERANDO VIA ORAL CON DIETA HIPOSODICA E HIPOGLUCIDA LIQUIDA, BUEN CONTROL METABOLICO (GLUCOMETRIA 120 MG/DL), ANURICA.

PARACLÍNICOS DEL DIA EVIDENCIAN HEMOGRAMA CON ANEMIA LEVE DE VOLUMENES NORMALES, SIN ALTERACIÓN EN SERIE BLANCA NI PLAQUETAS, FUNCIÓN RENAL CON HIPERAOZEMIA CRÓNICA EN ASCENSO RESPECTO A CONTROL PREVIO, IONOGRAMA CON HIPONATREMIA LEVE, SIN OTROS

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:20:11 p. m.

Admisión: AD715724

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: SOL BEATRIZ GARCIA MARQUEZ

EPICRISIS

TRASTORNOS HIDROELECTROLÍTICOS.

PACIENTE CON INSUFICIENCIA RESPIRATORIA SECUNDARIA A DERRAME PLEURAL DERECHO MASIVO DE ETIOLOGÍA A ESTABLECER, DOCUMENTADO EN TAC DE TORAX INSTITUCIONAL QUE REPORTA DERRAME PLEURAL SEVERO DERECHO DISPOSICIÓN LIBRE, CON SEPARACIÓN PLEURAL AP DE 75 MM, ATELECTASIAS PASIVAS EN LÓBULO INFERIOR DERECHO Y EN EL SEGMENTO POSTERIOR DE LÓBULO SUPERIOR DERECHO, PARÉNQUIMA PULMONAR SIN IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DE CONSOLIDACIÓN NEUMÓNICA, ATELECTASIAS, MASAS O CAVITACIONES; SE ENCUENTRA A LA ESPERA DE REALIZACIÓN DE TORACENTESIS DERECHA POR CIRUGÍA GENERAL PARA DRENAJE Y ESTUDIOS DE LIQUIDO PLEURAL QUE NOS PERMITA FILIAR CAUSA Y AJUSTAR MANEJO SEGUN HALLAZGOS, DICHO PROCEDIMIENTO SE LLEVARA A CABO PREVIA REALIZACIÓN DE ECOGRAFIA PLEURAL CON MARCAJE INDICADA POR CIRUGIA GENERAL. POR OTRA PARTE, PACIENTE MANIFIESTA QUE NO SE HA REALIZADO DIALISIS PERITONEAL HACE 3 DÍAS, LO CUAL EXPLICA ELEVACIÓN SOSTENIDA DE AZOADOS, FUE VALORADA POR NEFROLOGÍA QUIEN INDICA ROTAR TERAPIA AAPD, POR EL MOMENTO CONTINUA RESTO MANEJO MEDICO SIN CAMBIOS. SE EXPLICA CONDUCTA MEDICA A PACIENTE Y FAMILIAR QUIENES REFIEREN ENTENDER Y ACEPTAR.

PENDIENTE VALORACIÓN POR LOS SERVICIOS DE TERAPIA FÍSICA CUATRO VECES AL DÍA, TERAPIA OCUPACIONAL, FONOAUDIOLOGÍA PARA REHABILITACIÓN TEMPRANA Y PRECOZ DE PACIENTE, TERAPIA RESPIRATORIA INTEGRAL, PSICOLOGÍA CRÍTICA Y TRABAJO SOCIAL PARA REINTEGRO AL MEDIO Y NUCLEO FAMILIAR. SOPORTE NUTRICIONAL Y METABÓLICO CRÍTICO

PACIENTE CON ALTO RIESGO DE FALLA VENTILATORIA E INESTABILIDAD HEMODINAMICA Y REQUERIMIENTO DE SOPORTE VENTILATORIO INVASIVO QUE CONDICIONA NECESIDAD DE MONITORIZACION CONTINUA Y VIGILANCIA Estricta DE PARAMETROS VENTILATORIOS, NEUROLOGICOS, HEMODINAMICOS Y METABOLICOS.

Fecha: 21/02/2022: 18:47:44, Historia: Evolucion Clinica UCI, Prestador: SAID CLARETE DE LA ROSA, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE 66 AÑOS DE EDAD, CON ANTECEDENTES DE EXTABAQUISMO PESADO, HIPERTENSION ARTERIAL, DIABETES TIPO 2 INSULINODEPENDIENTE, ENFERMEDAD RENAL CRONICA EN TRR TIPO DIALISIS PERITONEAL Y EPOC SIN DIAGNOSTICO ESPIROMETRICO, QUIEN SE ENCUENTRA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS EN CONTEXTO DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA SECUNDARIA A DERRAME PLEURAL DERECHO MASIVO DE ETIOLOGÍA A ESTABLECER: PARANEOPLASICO VS PARANEUMONICO.

ACTUALMENTE PACIENTE CONSCIENTE, ALERTA, ORIENTADA, AFEBRIL, HEMODINAMICAMENTE COMPENSADA, CIFRAS TENSIONALES EN METAS, SIN REQUERIMIENTO DE SOPORTE VASOACTIVO, EUCARDICA, RITMO SINUSAL, VENTILATORIAMENTE EUPNEICA, CON MODERADO USO DE MUSCULOS RESPIRATORIOS ACCESORIOS, SATURACIÓN O2 EN METAS CON REQUERIMIENTO DE OXIGENO SUPLEMENTARIO POR CANULA NASAL A 3 LT/MINUTO, TOLERANDO VIA ORAL CON DIETA HIPOSODICA E HIPOGLUCIDA LIQUIDA, BUEN CONTROL METABOLICO (11-88, 17-132), ANURICA

PACIENTE CON INSUFICIENCIA RESPIRATORIA SECUNDARIA A DERRAME PLEURAL DERECHO MASIVO DE ETIOLOGÍA A ESTABLECER, DOCUMENTADO EN TAC DE TORAX INSTITUCIONAL QUE REPORTA DERRAME PLEURAL SEVERO DERECHO DISPOSICIÓN LIBRE, CON SEPARACIÓN PLEURAL AP DE 75 MM, ATELECTASIAS PASIVAS EN LÓBULO INFERIOR DERECHO Y EN EL SEGMENTO POSTERIOR DE LÓBULO SUPERIOR DERECHO, PARÉNQUIMA PULMONAR SIN IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DE CONSOLIDACIÓN NEUMÓNICA, ATELECTASIAS, MASAS O CAVITACIONES; SE ENCUENTRA A LA ESPERA DE REALIZACIÓN DE TORACENTESIS DERECHA POR CIRUGÍA GENERAL PARA DRENAJE Y ESTUDIOS DE LIQUIDO PLEURAL QUE NOS PERMITA FILIAR CAUSA Y AJUSTAR MANEJO SEGUN HALLAZGOS, DICHO PROCEDIMIENTO SE LLEVARA A CABO PREVIA REALIZACIÓN DE ECOGRAFIA PLEURAL CON MARCAJE INDICADA POR CIRUGIA GENERAL, POR OTRA PARTE, PACIENTE MANIFIESTA QUE NO SE HA REALIZADO DIALISIS PERITONEAL HACE 3 DÍAS, LO CUAL EXPLICA ELEVACIÓN SOSTENIDA DE AZOADOS, FUE VALORADA POR NEFROLOGÍA QUIEN INDICA ROTAR TERAPIA AAPD, POR EL MOMENTO CONTINUA RESTO MANEJO MEDICO SIN CAMBIOS. SE EXPLICA CONDUCTA MEDICA A PACIENTE Y FAMILIAR QUIENES REFIEREN ENTENDER Y ACEPTAR.

PENDIENTE VALORACIÓN POR LOS SERVICIOS DE TERAPIA FÍSICA CUATRO VECES AL DÍA, TERAPIA OCUPACIONAL, FONOAUDIOLOGÍA PARA REHABILITACIÓN TEMPRANA Y PRECOZ DE PACIENTE, TERAPIA RESPIRATORIA INTEGRAL, PSICOLOGÍA CRÍTICA Y TRABAJO SOCIAL PARA REINTEGRO AL MEDIO Y NUCLEO FAMILIAR. SOPORTE NUTRICIONAL Y METABÓLICO CRÍTICO

PACIENTE CON ALTO RIESGO DE FALLA VENTILATORIA E INESTABILIDAD HEMODINAMICA Y REQUERIMIENTO DE SOPORTE VENTILATORIO INVASIVO QUE CONDICIONA NECESIDAD DE MONITORIZACION CONTINUA Y VIGILANCIA Estricta DE PARAMETROS VENTILATORIOS, NEUROLOGICOS, HEMODINAMICOS Y METABOLICOS.

Fecha: 21/02/2022: 22:49:17, Historia: Evolucion Clinica UCI, Prestador: WILLIAM YAMITH CASTRO MENDOZA, Especialidad: CIRUGIA GENERAL

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE 66 AÑOS DE EDAD, CON ANTECEDENTES DE EXTABAQUISMO PESADO, HIPERTENSION ARTERIAL, DIABETES TIPO 2 INSULINODEPENDIENTE, ENFERMEDAD RENAL CRONICA EN TRR TIPO DIALISIS PERITONEAL Y EPOC SIN DIAGNOSTICO ESPIROMETRICO, QUIEN SE ENCUENTRA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS EN CONTEXTO DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA SECUNDARIA A DERRAME PLEURAL DERECHO MASIVO DE ETIOLOGÍA A ESTABLECER: PARANEOPLASICO VS PARANEUMONICO.

SE REVISAA PACIENTE CON PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (EPP) SEGÚN RECOMENDACIONES OMS, CONSENSO COLOMBIANO, CON AISLAMIENTO PARA GOTAS Y AEROSOL DESCRITO PARA PACIENTE COVID19, MASCARILLA N95, BATA QUIRURGICA, DOBLE GUANTE, PROTECCIÓN OCULAR, LAVADO DE MANOS 5 MOMENTOS

DURANTE RONDA MEDICA DE LA NOCHE PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, AFEBRIL, HIDRATADA NEUROLOGICAMENTE CONSCIENTE, ALERTA, ORIENTADA EN LAS TRE ESFERAS, HEMODINAMICAMENTE ECUCARDICA EN RITMO SINUSAL, CON CIFRAS TENSIONALES EN METAS SIN REQUERIMIENTO DE SOPORTE VASOACTIVO, BUEN PATRÓN RESPIRATORIO, CON ÍNDICES DE SATURACIÓN EN META AL VISOSCOPIO, OXIGENO SUPLEMENTARIO POR CANULA NASAL A 3 LT/MINUTO, TOLERANDO DIETA HIPOSODICA E HIPOGLUCIDA CON ACEPTABLE CONTROL GLICÉMICO, ANURICA

PACIENTE CON INSUFICIENCIA RESPIRATORIA SECUNDARIA A DERRAME PLEURAL DERECHO MASIVO DE ETIOLOGÍA A ESTABLECER, DOCUMENTADO EN TAC DE TORAX INSTITUCIONAL QUE REPORTA DERRAME PLEURAL SEVERO DERECHO DISPOSICIÓN LIBRE, CON SEPARACIÓN PLEURAL AP DE 75 MM, ATELECTASIAS PASIVAS EN LÓBULO INFERIOR DERECHO Y EN EL SEGMENTO POSTERIOR DE LÓBULO SUPERIOR DERECHO, PARÉNQUIMA PULMONAR SIN IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DE CONSOLIDACIÓN NEUMÓNICA, ATELECTASIAS, MASAS O CAVITACIONES; AGUARDA REALIZACIÓN DE TORACENTESIS DERECHA POR CIRUGÍA GENERAL PARA DRENAJE Y ESTUDIOS DE LIQUIDO PLEURAL QUE NOS PERMITA FILIAR CAUSA Y AJUSTAR MANEJO SEGUN HALLAZGOS, DICHO PROCEDIMIENTO SE LLEVARA A CABO PREVIA REALIZACIÓN DE ECOGRAFIA PLEURAL CON MARCAJE INDICADA

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:20:11 p. m.

Admisión: AD715724

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: SOL BEATRIZ GARCIA MARQUEZ

EPICRISIS

POR CIRUGIA GENERAL, POR OTRA PARTE, PACIENTE MANIFIESTA QUE NO SE HA REALIZADO DIALISIS PERITONEAL HACE 3 DÍAS, LO CUAL EXPLICA ELEVACIÓN SOSTENIDA DE AZOADOS, FUE VALORADA POR NEFROLOGÍA QUIEN INDICA ROTAR TERAPIA AAPD, DURANTE EL TURNO DE LA NOCHE PACIENTE SE MANTIENE CON PARAMETROS HEMODINAMICOS ESTABLES, SIN SIGNOS DE HIPOPERFUSION, QUIEN DEBE CONTINUAR PLAN DE MANEJO MEDICO PREVAMENTE INSTAURADO. SE EXPLICA CONDUCTA MEDICA A PACIENTE Y FAMILIAR QUIENES REFIEREN ENTENDER Y ACEPTAR.

PENDIENTE VALORACIÓN POR LOS SERVICIOS DE TERAPIA FÍSICA CUATRO VECES AL DÍA, TERAPIA OCUPACIONAL, FONOAUDIOLOGÍA PARA REHABILITACIÓN TEMPRANA Y PRECOZ DE PACIENTE, TERAPIA RESPIRATORIA INTEGRAL, PSICOLOGÍA CRÍTICA Y TRABAJO SOCIAL PARA REINTEGRO AL MEDIO Y NÚCLEO FAMILIAR. SOPORTE NUTRICIONAL Y METABÓLICO CRÍTICO

PACIENTE CON ALTO RIESGO DE FALLA VENTILATORIA E INESTABILIDAD HEMODINAMICA Y REQUERIMIENTO DE SOPORTE VENTILATORIO INVASIVO QUE CONDICIONA NECESIDAD DE MONITORIZACION CONTINUA Y VIGILANCIA Estricta DE PARAMETROS VENTILATORIOS, NEUROLÓGICOS, HEMODINAMICOS Y METABOLICOS.

Fecha: 22/02/2022: 10:59:04, Historia: Evolucion Clinica UCI, Prestador: JAIME SARMIENTO CALDERON, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE 66 AÑOS DE EDAD, CON ANTECEDENTES DE EXTABAQUISMO PESADO, HIPERTENSION ARTERIAL, DIABETES TIPO 2 INSULINODEPENDIENTE, ENFERMEDAD RENAL CRONICA EN TRR TIPO DIALISIS PERITONEAL Y EPOC SIN DIAGNOSTICO ESPIROMETRICO, QUIEN SE ENCUENTRA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS EN CONTEXTO DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA SECUNDARIA A DERRAME PLEURAL DERECHO MASIVO DE ETIOLOGIA A ESTABLECER: PARANEOPLASICO VS PARANEUMONICO.

RECIBO PACIENTE CONSCIENTE, ALERTA, ORIENTADA, AFEBRIL, HEMODINAMICAMENTE COMPENSADA, CIFRAS TENSIONALES EN METAS, SIN REQUERIMIENTO DE SOPORTE VASOACTIVO, EUCARDICA, RITMO SINUSAL, VENTILATORIAMENTE EUPNEICA, CON MODERADO USO DE MUSCULOS RESPIRATORIOS ACCESORIOS, SATURACIÓN O₂ EN METAS CON REQUERIMIENTO DE OXIGENO SUPLEMENTARIO POR CANULA NASAL A 3 LT/MINUTO, TOLERANDO VIA ORAL CON DIETA HIPOSODICA E HIPOGLUCIDA BLANDA, BUEN CONTROL METABOLICO (GLUCOMETRIA 119 MG/DL), ANURICA, EN DIALISIS PERITONEAL ADAPTADA

PARACLÍNICOS DEL DIA EVIDENCIAN HEMOGRAMA CON ANEMIA LEVE DE VOLUMENES NORMALES, SIN ALTERACIÓN EN SERIE BLANCA NI PLAQUETAS, FUNCIÓN RENAL CON HIPERAZEMIA CRÓNICA EN ASCENSO RESPECTO A CONTROL PREVIO, IONOGRAMA CON HIPONATREMIA LEVE, SIN OTROS TRASTORNOS HIDROELECTROLÍTICOS.

PACIENTE CON INSUFICIENCIA RESPIRATORIA SECUNDARIA A DERRAME PLEURAL DERECHO MASIVO DE ETIOLOGIA A ESTABLECER, DOCUMENTADO EN TAC DE TORAX INSTITUCIONAL QUE REPORTA DERRAME PLEURAL SEVERO DERECHO DISPOSICIÓN LIBRE, CON SEPARACIÓN PLEURAL AP DE 75 MM, ATELECTASIAS PASIVAS EN LÓBULO INFERIOR DERECHO Y EN EL SEGMENTO POSTERIOR DE LÓBULO SUPERIOR DERECHO, PARÉNQUIMA PULMONAR SIN IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DE CONSOLIDACIÓN NEUMÓNICA, ATELECTASIAS, MASAS O CAVITACIONES; SE ENCUENTRA A LA ESPERA DE REALIZACIÓN DE TORACENTESIS DERECHA POR CIRUGÍA GENERAL PARA DRENAJE Y ESTUDIOS DE LIQUIDO PLEURAL QUE NOS PERMITA FILIAR CAUSA Y AJUSTAR MANEJO SEGUN HALLAZGOS, DICHO PROCEDIMIENTO SE LLEVARA A CABO PREVIA REALIZACIÓN DE ECOGRAFIA PLEURAL CON MARCAJE INDICADA POR CIRUGIA GENERAL. POR EL MOMENTO SE SOLICITA CULTIVO DE LIQUIDO PERITONEAL DADO QUE DURANTE RONDA MEDICA SE OBJETIVA COLORACIÓN TURBIA DEL MISMO DURANTE DIALISIS PERITONEAL, CONTINUA RESTO MANEJO MEDICO SIN CAMBIOS. SE EXPLICA CONDUCTA MEDICA A PACIENTE Y FAMILIAR QUIENES REFIEREN ENTENDER Y ACEPTAR.

PENDIENTE VALORACIÓN POR LOS SERVICIOS DE TERAPIA FÍSICA CUATRO VECES AL DÍA, TERAPIA OCUPACIONAL, FONOAUDIOLOGÍA PARA REHABILITACIÓN TEMPRANA Y PRECOZ DE PACIENTE, TERAPIA RESPIRATORIA INTEGRAL, PSICOLOGÍA CRÍTICA Y TRABAJO SOCIAL PARA REINTEGRO AL MEDIO Y NÚCLEO FAMILIAR. SOPORTE NUTRICIONAL Y METABÓLICO CRÍTICO

PACIENTE CON ALTO RIESGO DE FALLA VENTILATORIA E INESTABILIDAD HEMODINAMICA Y REQUERIMIENTO DE SOPORTE VENTILATORIO INVASIVO QUE CONDICIONA NECESIDAD DE MONITORIZACION CONTINUA Y VIGILANCIA Estricta DE PARAMETROS VENTILATORIOS, NEUROLÓGICOS, HEMODINAMICOS Y METABOLICOS.

Fecha: 22/02/2022: 19:20:27, Historia: Evolucion Clinica UCI, Prestador: CHRISTIAN ORLANDO BUELVAS ALVIS, Especialidad: CUIDADO DEL PACIENTE EN ESTADO CRITICO

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE 66 AÑOS DE EDAD, CON ANTECEDENTES DE EXTABAQUISMO PESADO, HIPERTENSION ARTERIAL, DIABETES TIPO 2 INSULINODEPENDIENTE, ENFERMEDAD RENAL CRONICA EN TRR TIPO DIALISIS PERITONEAL Y EPOC SIN DIAGNOSTICO ESPIROMETRICO, QUIEN SE ENCUENTRA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS EN CONTEXTO DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA SECUNDARIA A DERRAME PLEURAL DERECHO MASIVO DE ETIOLOGIA A ESTABLECER: PARANEOPLASICO VS PARANEUMONICO.

RECIBO PACIENTE CONSCIENTE, ALERTA, ORIENTADA, AFEBRIL, HEMODINAMICAMENTE COMPENSADA, CIFRAS TENSIONALES EN METAS, SIN REQUERIMIENTO DE SOPORTE VASOACTIVO, EUCARDICA, RITMO SINUSAL, VENTILATORIAMENTE EUPNEICA, CON MODERADO USO DE MUSCULOS RESPIRATORIOS ACCESORIOS, SATURACIÓN O₂ EN METAS CON REQUERIMIENTO DE OXIGENO SUPLEMENTARIO POR CANULA NASAL A 3 LT/MINUTO, TOLERANDO VIA ORAL CON DIETA HIPOSODICA E HIPOGLUCIDA BLANDA, BUEN CONTROL METABOLICO (MG/DL), ANURICA, EN DIALISIS PERITONEAL ADAPTADA

PACIENTE CON INSUFICIENCIA RESPIRATORIA SECUNDARIA A DERRAME PLEURAL DERECHO MASIVO DE ETIOLOGIA A ESTABLECER, DOCUMENTADO EN TAC DE TORAX INSTITUCIONAL QUE REPORTA DERRAME PLEURAL SEVERO DERECHO DISPOSICIÓN LIBRE, CON SEPARACIÓN PLEURAL AP DE 75 MM, ATELECTASIAS PASIVAS EN LÓBULO INFERIOR DERECHO Y EN EL SEGMENTO POSTERIOR DE LÓBULO SUPERIOR DERECHO, PARÉNQUIMA PULMONAR SIN IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DE CONSOLIDACIÓN NEUMÓNICA, ATELECTASIAS, MASAS O CAVITACIONES; EN LA TARDE DE HOY SE REALIZA TORACENTECIS DIAGNOSTICADA DADO OBJETIVIZACION DE COLORACIÓN TURBIA DE LIQUIDO PERITONEAL DURANTE DURANTE DIALISIS SE SOLICITA CULTIVO DEL MISMO, CONTINUA RESTO MANEJO MEDICO SIN CAMBIOS, ATENTOS A EVOLUCION CLINICA

PENDIENTE VALORACIÓN POR LOS SERVICIOS DE TERAPIA FÍSICA CUATRO VECES AL DÍA, TERAPIA OCUPACIONAL, FONOAUDIOLOGÍA PARA REHABILITACIÓN TEMPRANA Y PRECOZ DE PACIENTE, TERAPIA RESPIRATORIA INTEGRAL, PSICOLOGÍA CRÍTICA Y TRABAJO SOCIAL PARA REINTEGRO AL MEDIO Y NÚCLEO FAMILIAR. SOPORTE NUTRICIONAL Y METABÓLICO CRÍTICO

PACIENTE CON ALTO RIESGO DE FALLA VENTILATORIA E INESTABILIDAD HEMODINAMICA Y REQUERIMIENTO DE SOPORTE VENTILATORIO INVASIVO QUE CONDICIONA NECESIDAD DE MONITORIZACION CONTINUA Y VIGILANCIA Estricta DE PARAMETROS VENTILATORIOS, NEUROLÓGICOS, HEMODINAMICOS Y METABOLICOS.

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:20:11 p. m.

Admisión: AD715724

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: SOL BEATRIZ GARCIA MARQUEZ

EPICRISIS

.....NOTA TORACENTESIS

PREVIA ASEPSIA Y ANTISEPSIA, SE IDENTIFICA EL SITIO DE PUNCIÓN, PREVIAMENTE MARCADO EN ECOGRAFÍA PLEURAL, A NIVEL DEL QUINTO ESPACIO INTERCOSTAL, LÍNEA MEDIO ESCAPULAR DERECHA SE INFILTRA SITIO DE PUNCIÓN CON LIDOCÁINA, SE INCIDE SOBRE EL BORDE SUPERIOR DE LA COSTILLA INFERIOR CON INTRACATH Nº 186/16, HASTA LLEGAR A ESPACIO PLEURAL, CON SALIDA DE LIQUIDO COLOR AMBAR, SE TOMAN MUESTRA PARA 3 TUBOS, CON SALIDA DE APROXIMADAMENTE 150 CC EN TOTAL, SE CUBRE ZONA CON APOSITO ESTERIL. PACIENTE TOLERA PROCEDIMIENTO SIN COMPLICACIONES.

Fecha: 22/02/2022: 21:57:14, Historia: Evolucion Clinica UCI, Prestador: GUSTAVO ADOLFO BUELVAS PIÑERES, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE 66 AÑOS DE EDAD, CON ANTECEDENTES DE EXTABAQUISMO PESADO, HIPERTENSION ARTERIAL, DIABETES TIPO 2 INSULINODEPENDIENTE, ENFERMEDAD RENAL CRONICA EN TRR TIPO DIALISIS PERITONEAL Y EPOC SIN DIAGNOSTICO ESPIROMETRICO, QUIEN SE ENCUENTRA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS EN CONTEXTO DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA SECUNDARIA A DERRAME PLEURAL DERECHO MASIVO DE ETIOLOGIA A ESTABLECER: PARANEOPLASICO VS PARANEUMONICO.

ACTUALMENTE PACIENTE CONSCIENTE, ALERTA, ORIENTADA, AFEBRIL, HEMODINAMICAMENTE COMPENSADA, CIFRAS TENSIONALES EN METAS, SIN REQUERIMIENTO DE SOPORTE VASOACTIVO, EUCARDICA, RITMO SINUSAL, VENTILATORIA EUPNEICA, CON MODERADO USO DE MUSCULOS RESPIRATORIOS ACCESORIOS, SATURACIÓN O2 EN METAS CON REQUERIMIENTO DE OXIGENO SUPLEMENTARIO POR CANULA NASAL A 3 LT/MINUTO, TOLERANDO VIA ORAL CON DIETA HIPOSODICA E HIPOGLUCIDA BLANDA, BUEN CONTROL METABOLICO, ANURICA, EN DIALISIS PERITONEAL ADAPTADA.

PACIENTE QUE EVOLUCIONA EN MARCO DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA SECUNDARIA A DERRAME PLEURAL DERECHO MASIVO DE ETIOLOGIA A ESTABLECER, DOCUMENTADO EN TAC DE TORAX INSTITUCIONAL QUE REPORTA DERRAME PLEURAL SEVERO DERECHO DISPOSICIÓN LIBRE, CON SEPARACIÓN PLEURAL AP DE 75 MM, ATELECTASIAS PASIVAS EN LÓBULO INFERIOR DERECHO Y EN EL SEGMENTO POSTERIOR DE LÓBULO SUPERIOR DERECHO, PARÉNQUIMA PULMONAR SIN IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DE CONSOLIDACIÓN NEUMÓNICA, ATELECTASIAS, MASAS O CAVITACIONES; EL DIA DE HOY SE REALIZO TORACENTESIS DIAGNOSTICA, NOS ENCONTRAMOS A LA ESPERA DE ESTUDIO MICROBIOLÓGICO DE LIQUIDO PLEURAL, DADO OBJETIVACIÓN DE COLORACIÓN TURBIA DE LIQUIDO PERITONEAL DURANTE DURANTE DIALISIS SE ENCUENTRA PENDIENTE CULTIVO DEL MISMO, POR EL MOMENTO SIN CAMBIOS ADICIONALES EN EL MANEJO MEDICO INSTAURADO, CON PRONOSTICO Y CONDUCTA MODIFICABLES SEGUN EVOLUCION CLINICA DE LA PACIENTE.

PENDIENTE VALORACIÓN POR LOS SERVICIOS DE TERAPIA FÍSICA CUATRO VECES AL DÍA, TERAPIA OCUPACIONAL, FONOAUDIOLOGÍA PARA REHABILITACIÓN TEMPRANA Y PRECOZ DE PACIENTE, TERAPIA RESPIRATORIA INTEGRAL, PSICOLOGÍA CRÍTICA Y TRABAJO SOCIAL PARA REINTEGRO AL MEDIO Y NUCLEO FAMILIAR. SOPORTE NUTRICIONAL Y METABÓLICO CRÍTICO

PACIENTE CON ALTO RIESGO DE FALLA VENTILATORIA E INESTABILIDAD HEMODINAMICA Y REQUERIMIENTO DE SOPORTE VENTILATORIO INVASIVO QUE CONDICIONA NECESIDAD DE MONITORIZACION CONTINUA Y VIGILANCIA Estricta DE PARAMETROS VENTILATORIOS, NEUROLOGICOS, HEMODINAMICOS Y METABOLICOS.

Fecha: 23/02/2022: 10:20:43, Historia: Evolucion Clinica UCI, Prestador: JAIME SARMIENTO CALDERON, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE 66 AÑOS DE EDAD, CON ANTECEDENTES DE EXTABAQUISMO PESADO, HIPERTENSION ARTERIAL, DIABETES TIPO 2 INSULINODEPENDIENTE, ENFERMEDAD RENAL CRONICA EN TRR TIPO DIALISIS PERITONEAL Y EPOC SIN DIAGNOSTICO ESPIROMETRICO, QUIEN SE ENCUENTRA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS EN CONTEXTO DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA SECUNDARIA A DERRAME PLEURAL DERECHO MASIVO DE ETIOLOGIA A ESTABLECER, CON ALTA SOSPECHA DE TUBERCULOSIS PLEURAL.

RECIBO PACIENTE CONSCIENTE, ALERTA, ORIENTADA, AFEBRIL, HEMODINAMICAMENTE COMPENSADA, CIFRAS TENSIONALES EN METAS, SIN REQUERIMIENTO DE SOPORTE VASOACTIVO, EUCARDICA, RITMO SINUSAL, VENTILATORIA EUPNEICA CON LEVE USO DE MUSCULOS RESPIRATORIOS ACCESORIOS, SATURACIÓN O2 EN METAS CON REQUERIMIENTO DE OXIGENO SUPLEMENTARIO POR CANULA NASAL A 3 LT/MINUTO, TOLERANDO VIA ORAL CON DIETA HIPOSODICA E HIPOGLUCIDA BLANDA, BUEN CONTROL METABOLICO (GLUCOMETRIA 167 MG/DL), ANURICA, EN DIALISIS PERITONEAL ADAPTADA.

PARACLÍNICOS DEL DIA EVIDENCIAN HEMOGRAMA CON ANEMIA LEVE DE VOLUMENES NORMALES, SIN ALTERACIÓN EN SERIE BLANCA NI PLAQUETAS, FUNCIÓN RENAL CON HIPERAQUEZEMIA CRÓNICA EN DESCENSO RESPECTO A CONTROL PREVIO, IONOGRAMA SIN TRASTORNOS HIDROELECTROLÍTICOS.

PACIENTE CON INSUFICIENCIA RESPIRATORIA SECUNDARIA A DERRAME PLEURAL DERECHO MASIVO DE ETIOLOGIA A ESTABLECER, DOCUMENTADO EN TAC DE TORAX INSTITUCIONAL QUE REPORTA DERRAME PLEURAL SEVERO DERECHO DISPOSICIÓN LIBRE, CON SEPARACIÓN PLEURAL AP DE 75 MM, ATELECTASIAS PASIVAS EN LÓBULO INFERIOR DERECHO Y EN EL SEGMENTO POSTERIOR DE LÓBULO SUPERIOR DERECHO, PARÉNQUIMA PULMONAR SIN IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DE CONSOLIDACIÓN NEUMÓNICA, ATELECTASIAS, MASAS O CAVITACIONES; SE LE REALIZO TORACENTESIS DERECHA DIAGNOSTICA Y TERAPEUTICA, CON ADA POSITIVO, RESTO DE ESTUDIOS NEGATIVOS (KOH, BACILOSCOPIA, GRAM), POR LO CUAL EN CONJUNTO CON INFECTOLOGIA CRITICA SE DECIDE SOLICITAR VALORACIÓN POR CIRUGIA DE TORAX PARA TOMA DE BIOPSIA POR TORACOSCOPIA QUE NOS PERMITA CONFIRMAR TB PLEURAL E INICIAR TERAPIA ANTIFIMICA DE ACUERDO A RESULTADOS. POR EL MOMENTO CONTINUA RESTO MANEJO MEDICO SIN CAMBIOS, PENDIENTE RESULTADO DE LDH Y PROTEINAS TOTALES EN SUERO PARA CALCULO DE CRITERIOS DE LIGTH. SE EXPLICA CONDUCTA MEDICA A PACIENTE Y FAMILIAR QUIENES REFIEREN ENTENDER Y ACEPTAR.

PENDIENTE VALORACIÓN POR LOS SERVICIOS DE TERAPIA FÍSICA CUATRO VECES AL DÍA, TERAPIA OCUPACIONAL, FONOAUDIOLOGÍA PARA REHABILITACIÓN TEMPRANA Y PRECOZ DE PACIENTE, TERAPIA RESPIRATORIA INTEGRAL, PSICOLOGÍA CRÍTICA Y TRABAJO SOCIAL PARA REINTEGRO AL MEDIO Y NUCLEO FAMILIAR. SOPORTE NUTRICIONAL Y METABÓLICO CRÍTICO

PACIENTE CON ALTO RIESGO DE FALLA VENTILATORIA E INESTABILIDAD HEMODINAMICA Y REQUERIMIENTO DE SOPORTE VENTILATORIO INVASIVO QUE CONDICIONA NECESIDAD DE MONITORIZACION CONTINUA Y VIGILANCIA Estricta DE PARAMETROS VENTILATORIOS, NEUROLOGICOS, HEMODINAMICOS Y METABOLICOS.

Fecha: 23/02/2022: 18:07:31, Historia: Evolucion Clinica UCI, Prestador: SAID CLARETE DE LA ROSA, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE 66 AÑOS DE EDAD, CON ANTECEDENTES DE EXTABAQUISMO PESADO, HIPERTENSION ARTERIAL, DIABETES TIPO 2

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:20:11 p. m.

Admisión: AD715724

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: SOL BEATRIZ GARCIA MARQUEZ

EPICRISIS

INSULINODEPENDIENTE, ENFERMEDAD RENAL CRONICA EN TRR TIPO DIALISIS PERITONEAL Y EPOC SIN DIAGNOSTICO ESPIROMETRICO, QUIEN SE ENCUENTRA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS EN CONTEXTO DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA SECUNDARIA A DERRAME PLEURAL DERECHO MASIVO DE ETIOLOGIA A ESTABLECER, CON ALTA SOSPECHA DE TUBERCULOSIS PLEURAL.

ACTUALMENTE PACIENTE CONSCIENTE, ALERTA, ORIENTADA, AFEBRIL, HEMODINAMICAMENTE COMPENSADA, CIFRAS TENSIONALES EN METAS, SIN REQUERIMIENTO DE SOPORTE VASOACTIVO, EUCARDICA, RITMO SINUSAL, VENTILATORIAMENTE EUPNEICA, CON LEVE USO DE MUSCULOS RESPIRATORIOS ACCESORIOS, SATURACIÓN O2 EN METAS CON REQUERIMIENTO DE OXIGENO SUPLEMENTARIO POR CANULA NASAL A 3 LT/MINUTO, TOLERANDO VIA ORAL CON DIETA HIPOSODICA E HIPOGLUCIDA BLANDA, BUEN CONTROL METABOLICO (11-151,16-173 MG/DL), ANURICA, EN DIALISIS PERITONEAL ADAPTADA

PACIENTE CON INSUFICIENCIA RESPIRATORIA SECUNDARIA A DERRAME PLEURAL DERECHO MASIVO DE ETIOLOGIA A ESTABLECER, DOCUMENTADO EN TAC DE TORAX INSTITUCIONAL QUE REPORTA DERRAME PLEURAL SEVERO DERECHO DISPOSICIÓN LIBRE, CON SEPARACIÓN PLEURAL AP DE 75 MM, ATELECTASIAS PASIVAS EN LÓBULO INFERIOR DERECHO Y EN EL SEGMENTO POSTERIOR DE LÓBULO SUPERIOR DERECHO, PARÉNQUIMA PULMONAR SIN IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DE CONSOLIDACIÓN NEUMÓNICA ATELECTASIAS, MASAS O CAMTACIONES; SE LE REALIZO TORACENTESIS DERECHA DIAGNOSTICA Y TERAPEUTICA, CON ADA POSITIVO LIQUIDO PLEURAL CON CARACTERISTICAS DE EXUDADO LINFOCITARIO, RESTO DE ESTUDIOS NEGATIVOS (KOH, BACILOSCOPIA, GRAM), POR LO CUAL EN CONJUNTO CON INFECTOLOGIA CRITICA SE DECIDIO SOLICITAR VALORACIÓN POR CIRUGIA DE TORAX PARA TOMA DE BIOPSIA POR TORACOSCOPIA QUE NOS PERMITA CONFIRMAR TB PLEURAL E INICIAR TERAPIA ANTIFIMICA DE ACUERDO A RESULTADOS. POR EL MOMENTO CONTINUA MANEJO MEDICO SIN CAMBIOS, ATENTOS A EVOLUCION CLINICA

PENDIENTE VALORACIÓN POR LOS SERVICIOS DE TERAPIA FÍSICA CUATRO VECES AL DÍA, TERAPIA OCUPACIONAL, FONOAUDIOLOGÍA PARA REHABILITACIÓN TEMPRANA Y PRECOZ DE PACIENTE, TERAPIA RESPIRATORIA INTEGRAL, PSICOLOGÍA CRÍTICA Y TRABAJO SOCIAL PARA REINTEGRO AL MEDIO Y NUCLEO FAMILIAR. SOPORTE NUTRICIONAL Y METABÓLICO CRÍTICO

PACIENTE CON ALTO RIESGO DE FALLA VENTILATORIA E INESTABILIDAD HEMODINAMICA Y REQUERIMIENTO DE SOPORTE VENTILATORIO INVASIVO QUE CONDICIONA NECESIDAD DE MONITORIZACION CONTINUA Y VIGILANCIA ESTRUCTA DE PARAMETROS VENTILATORIOS, NEUROLOGICOS, HEMODINAMICOS Y METABOLICOS.

Fecha: 24/02/2022: 01:56:23, Historia: Evolucion Clinica UCI, Prestador: FABIO ESTEBAN PEREZ BENABIDES, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE 66 AÑOS DE EDAD, CON ANTECEDENTES DE EXTABAQUISMO PESADO, HIPERTENSION ARTERIAL, DIABETES TIPO 2 INSULINODEPENDIENTE, ENFERMEDAD RENAL CRONICA EN TRR TIPO DIALISIS PERITONEAL Y EPOC SIN DIAGNOSTICO ESPIROMETRICO, QUIEN SE ENCUENTRA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS EN CONTEXTO DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA SECUNDARIA A DERRAME PLEURAL DERECHO MASIVO DE ETIOLOGIA A ESTABLECER, CON ALTA SOSPECHA DE TUBERCULOSIS PLEURAL.

DURANTE RONDA MÉDICA DE LA NOCHE ENCUENTRO PACIENTE CONSCIENTE, ALERTA, ORIENTADA, AFEBRIL, HEMODINAMICAMENTE COMPENSADA, CIFRAS TENSIONALES EN METAS, SIN REQUERIMIENTO DE SOPORTE VASOACTIVO, EUCARDICA, RITMO SINUSAL, VENTILATORIAMENTE EUPNEICA, CON LEVE USO DE MUSCULOS RESPIRATORIOS ACCESORIOS, SATURACIÓN O2 EN METAS CON REQUERIMIENTO DE OXIGENO SUPLEMENTARIO POR CANULA NASAL A 3 LT/MINUTO, TOLERANDO VIA ORAL CON DIETA HIPOSODICA E HIPOGLUCIDA BLANDA, BUEN CONTROL METABOLICO, ANURICA, EN DIALISIS PERITONEAL ADAPTADA

PACIENTE CON INSUFICIENCIA RESPIRATORIA SECUNDARIA A DERRAME PLEURAL DERECHO MASIVO DE ETIOLOGIA A ESTABLECER, DOCUMENTADO EN TAC DE TORAX INSTITUCIONAL QUE REPORTA DERRAME PLEURAL SEVERO DERECHO DISPOSICIÓN LIBRE, CON SEPARACIÓN PLEURAL AP DE 75 MM, ATELECTASIAS PASIVAS EN LÓBULO INFERIOR DERECHO Y EN EL SEGMENTO POSTERIOR DE LÓBULO SUPERIOR DERECHO, PARÉNQUIMA PULMONAR SIN IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DE CONSOLIDACIÓN NEUMÓNICA ATELECTASIAS, MASAS O CAMTACIONES; SE LE REALIZO TORACENTESIS DERECHA DIAGNOSTICA Y TERAPEUTICA, CON ADA POSITIVO LIQUIDO PLEURAL CON CARACTERISTICAS DE EXUDADO LINFOCITARIO, RESTO DE ESTUDIOS NEGATIVOS (KOH, BACILOSCOPIA, GRAM), POR LO CUAL EN CONJUNTO CON INFECTOLOGIA CRITICA SE DECIDIO SOLICITAR VALORACIÓN POR CIRUGIA DE TORAX PARA TOMA DE BIOPSIA POR TORACOSCOPIA QUE NOS PERMITA CONFIRMAR TB PLEURAL E INICIAR TERAPIA ANTIFIMICA DE ACUERDO A RESULTADOS. INDICO CONTINUAR MANEJO MÉDICO ESTABLECIDO. SOLICITO PARA CLÍNICOS DE CONTROL. ATENTOS A EVOLUCION CLINICA

PENDIENTE VALORACIÓN POR LOS SERVICIOS DE TERAPIA FÍSICA CUATRO VECES AL DÍA, TERAPIA OCUPACIONAL, FONOAUDIOLOGÍA PARA REHABILITACIÓN TEMPRANA Y PRECOZ DE PACIENTE, TERAPIA RESPIRATORIA INTEGRAL, PSICOLOGÍA CRÍTICA Y TRABAJO SOCIAL PARA REINTEGRO AL MEDIO Y NUCLEO FAMILIAR. SOPORTE NUTRICIONAL Y METABÓLICO CRÍTICO

PACIENTE CON ALTO RIESGO DE FALLA VENTILATORIA E INESTABILIDAD HEMODINAMICA Y REQUERIMIENTO DE SOPORTE VENTILATORIO INVASIVO QUE CONDICIONA NECESIDAD DE MONITORIZACION CONTINUA Y VIGILANCIA ESTRUCTA DE PARAMETROS VENTILATORIOS, NEUROLOGICOS, HEMODINAMICOS Y METABOLICOS.

Fecha: 24/02/2022: 11:04:13, Historia: Evolucion Clinica UCI, Prestador: HECTOR ROLANDO ROMERO RIVERA, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE 66 AÑOS DE EDAD, CON ANTECEDENTES DE EXTABAQUISMO PESADO, HIPERTENSION ARTERIAL, DIABETES TIPO 2 INSULINODEPENDIENTE, ENFERMEDAD RENAL CRONICA EN TRR TIPO DIALISIS PERITONEAL Y EPOC SIN DIAGNOSTICO ESPIROMETRICO, QUIEN SE ENCUENTRA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS EN CONTEXTO DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA SECUNDARIA A DERRAME PLEURAL DERECHO MASIVO DE ETIOLOGIA A ESTABLECER, CON ALTA SOSPECHA DE TUBERCULOSIS PLEURAL.

ACTUALMENTE PACIENTE CONSCIENTE, ALERTA, ORIENTADA, AFEBRIL, HEMODINAMICAMENTE COMPENSADA, CIFRAS TENSIONALES EN METAS, SIN REQUERIMIENTO DE SOPORTE VASOACTIVO, EUCARDICA, RITMO SINUSAL, VENTILATORIAMENTE EUPNEICA, CON LEVE USO DE MUSCULOS RESPIRATORIOS ACCESORIOS, SATURACIÓN O2 EN METAS CON REQUERIMIENTO DE OXIGENO SUPLEMENTARIO POR CANULA NASAL A 3 LT/MINUTO, TOLERANDO VIA ORAL CON DIETA HIPOSODICA E HIPOGLUCIDA BLANDA, BUEN CONTROL METABOLICO (GLUCOMETRIA 86 MG/DL), ANURICA, EN DIALISIS PERITONEAL ADAPTADA

PARACLÍNICOS DEL DIA EVIDENCIAN HEMOGRAMA CON ANEMIA LEVE DE VOLUMENES NORMALES, SIN ALTERACIÓN EN SERIE BLANCA NI PLAQUETAS, FUNCIÓN RENAL CON HIPERAOZEMIA CRÓNICA, IONOGRAMA CON HIPONATREMIA LEVE ASINTOMATICA

PACIENTE CON INSUFICIENCIA RESPIRATORIA SECUNDARIA A DERRAME PLEURAL DERECHO MASIVO DE ETIOLOGIA A ESTABLECER, CUENTA CON TAC DE TORAX INSTITUCIONAL QUE REPORTA DERRAME PLEURAL SEVERO DERECHO DISPOSICIÓN LIBRE, CON SEPARACIÓN PLEURAL AP DE 75 MM, ATELECTASIAS PASIVAS EN LÓBULO INFERIOR DERECHO Y EN EL SEGMENTO POSTERIOR DE LÓBULO SUPERIOR DERECHO, PARÉNQUIMA PULMONAR

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:20:11 p. m.

Admisión: AD715724

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: SOL BEATRIZ GARCIA MARQUEZ

EPICRISIS

SIN IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DE CONSOLIDACIÓN NEUMÓNICA, ATELECTASIAS, MASAS O CAVITACIONES; SE LE REALIZO TORACENTESIS DERECHA DIAGNOSTICA Y TERAPEUTICA, CON ADA POSITIVO EN LIQUIDO PLEURAL CON CARACTERISTICAS DE EXUDADO LINFOCITARIO SEGUN CRITERIOS DE LIGTH, RESTO DE ESTUDIOS NEGATIVOS (KOH, BACILOSCOPIA, GRAM), POR LO CUAL EN CONJUNTO CON INFECTOLOGIA CRITICA SE DECIDIO SOLICITAR VALORACIÓN POR CIRUGIA DE TORAX PARA TOMA DE BIOPSIA POR TORACOSCOPIA QUE NOS PERMITA CONFIRMAR TB PLEURAL E INICIAR TERAPIA ANTIFIMICA DE ACUERDO A RESULTADOS, PENDIENTE REALIZACIÓN DE LA MISMA POR EL MOMENTO CONTINUA MANEJO MEDICO SIN CAMBIOS, ATENTOS A EVOLUCION CLINICA

SEGUIMIENTO VALORACIÓN POR LOS SERVICIOS DE TERAPIA FÍSICA CUATRO VECES AL DÍA, TERAPIA OCUPACIONAL, FONOAUDIOLOGÍA PARA REHABILITACIÓN TEMPRANA Y PRECOZ DE PACIENTE, TERAPIA RESPIRATORIA INTEGRAL, PSICOLOGÍA CRÍTICA Y TRABAJO SOCIAL PARA REINTEGRO AL MEDIO Y NUCLEO FAMILIAR. SOPORTE NUTRICIONAL Y METABÓLICO CRÍTICO

PACIENTE CON ALTO RIESGO DE FALLA VENTILATORIA E INESTABILIDAD HEMODINAMICA Y REQUERIMIENTO DE SOPORTE VENTILATORIO INVASIVO QUE CONDICIONA NECESIDAD DE MONITORIZACION CONTINUA Y VIGILANCIA Estricta DE PARAMETROS VENTILATORIOS, NEUROLOGICOS, HEMODINAMICOS Y METABOLICOS.

Fecha: 24/02/2022: 19:13:34, Historia: Evolucion Clinica UCI, Prestador: JUAN PABLO ORTIZ SALAZAR, Especialidad: CUIDADO DEL PACIENTE EN ESTADO CRITICO

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE 66 AÑOS DE EDAD, CON ANTECEDENTES DE EXTABAQUISMO PESADO, HIPERTENSION ARTERIAL, DIABETES TIPO 2 INSULINODEPENDIENTE, ENFERMEDAD RENAL CRONICA EN TRR TIPO DIALISIS PERITONEAL Y EPOC SIN DIAGNOSTICO ESPIROMETRICO, QUIEN SE ENCUENTRA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS EN CONTEXTO DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA SECUNDARIA A DERRAME PLEURAL DERECHO MASIVO DE ETIOLOGIA A ESTABLECER, CON ALTA SOSPECHA DE TUBERCULOSIS PLEURAL.

ACTUALMENTE PACIENTE CONSCIENTE, ALERTA, ORIENTADA, AFEBRIL, HEMODINAMICAMENTE COMPENSADA, CIFRAS TENSIONALES EN METAS, SIN REQUERIMIENTO DE SOPORTE VASOACTIVO, EUCARDICA, RITMO SINUSAL, VENTILATORIAMENTE EUPNEICA, CON LEVE USO DE MUSCULOS RESPIRATORIOS ACCESORIOS, SATURACIÓN O2 EN METAS CON REQUERIMIENTO DE OXIGENO SUPLEMENTARIO POR CANULA NASAL A 3 LT/MINUTO, TOLERANDO VIA ORAL CON DIETA HIPOSODICA E HIPOGLUCIDA BLANDA, BUEN CONTROL METABOLICO (GLUCOMETRIA 86 MG/DL), ANURICA, EN DIALISIS PERITONEAL ADAPTADA

PACIENTE CON INSUFICIENCIA RESPIRATORIA SECUNDARIA A DERRAME PLEURAL DERECHO MASIVO DE ETIOLOGIA A ESTABLECER, CUENTA CON TAC DE TORAX INSTITUCIONAL QUE REPORTA DERRAME PLEURAL SEVERO DERECHO DISPOSICIÓN LIBRE, CON SEPARACIÓN PLEURAL AP DE 75 MM, ATELECTASIAS PASIVAS EN LÓBULO INFERIOR DERECHO Y EN EL SEGMENTO POSTERIOR DE LÓBULO SUPERIOR DERECHO, PARÉNQUIMA PULMONAR SIN IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DE CONSOLIDACIÓN NEUMÓNICA, ATELECTASIAS, MASAS O CAVITACIONES; SE LE REALIZO TORACENTESIS DERECHA DIAGNOSTICA Y TERAPEUTICA, CON ADA POSITIVO EN LIQUIDO PLEURAL CON CARACTERISTICAS DE EXUDADO LINFOCITARIO SEGUN CRITERIOS DE LIGTH, RESTO DE ESTUDIOS NEGATIVOS (KOH, BACILOSCOPIA, GRAM), POR LO CUAL EN CONJUNTO CON INFECTOLOGIA CRITICA SE DECIDIO SOLICITAR VALORACIÓN POR CIRUGIA DE TORAX PARA TOMA DE BIOPSIA POR TORACOSCOPIA QUE NOS PERMITA CONFIRMAR TB PLEURAL E INICIAR TERAPIA ANTIFIMICA DE ACUERDO A RESULTADOS, PENDIENTE REALIZACIÓN DE LA MISMA POR EL MOMENTO CONTINUA MANEJO MEDICO SIN CAMBIOS, ATENTOS A EVOLUCION CLINICA

SEGUIMIENTO VALORACIÓN POR LOS SERVICIOS DE TERAPIA FÍSICA CUATRO VECES AL DÍA, TERAPIA OCUPACIONAL, FONOAUDIOLOGÍA PARA REHABILITACIÓN TEMPRANA Y PRECOZ DE PACIENTE, TERAPIA RESPIRATORIA INTEGRAL, PSICOLOGÍA CRÍTICA Y TRABAJO SOCIAL PARA REINTEGRO AL MEDIO Y NUCLEO FAMILIAR. SOPORTE NUTRICIONAL Y METABÓLICO CRÍTICO

PACIENTE CON ALTO RIESGO DE FALLA VENTILATORIA E INESTABILIDAD HEMODINAMICA Y REQUERIMIENTO DE SOPORTE VENTILATORIO INVASIVO QUE CONDICIONA NECESIDAD DE MONITORIZACION CONTINUA Y VIGILANCIA Estricta DE PARAMETROS VENTILATORIOS, NEUROLOGICOS, HEMODINAMICOS Y METABOLICOS.

Fecha: 25/02/2022: 00:18:44, Historia: Evolucion Clinica UCI, Prestador: ANA MARIA SANTOS ARRIETA, Especialidad: CIRUGIA GENERAL

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE 66 AÑOS DE EDAD, CON ANTECEDENTES DE EXTABAQUISMO PESADO, HIPERTENSION ARTERIAL, DIABETES TIPO 2 INSULINODEPENDIENTE, ENFERMEDAD RENAL CRONICA EN TRR TIPO DIALISIS PERITONEAL Y EPOC SIN DIAGNOSTICO ESPIROMETRICO, QUIEN SE ENCUENTRA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS EN CONTEXTO DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA SECUNDARIA A DERRAME PLEURAL DERECHO MASIVO DE ETIOLOGIA A ESTABLECER, CON ALTA SOSPECHA DE TUBERCULOSIS PLEURAL.

PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, ESTADO NEUROLOGICO SATISFACTORIO PERMANECIENDO ALERTA, CONSCIENTE, ORIENTADA, AFEBRIL, HEMODINAMICAMENTE COMPENSADA, CIFRAS TENSIONALES EN METAS, SIN REQUERIMIENTO DE SOPORTE VASOACTIVO, EUCARDICA, RITMO SINUSAL, VENTILATORIAMENTE EUPNEICA, CON LEVE USO DE MUSCULOS RESPIRATORIOS ACCESORIOS, SATURACIÓN O2 EN METAS CON REQUERIMIENTO DE OXIGENO SUPLEMENTARIO POR CANULA NASAL A 3 LT/MINUTO, TOLERANDO VIA ORAL CON DIETA HIPOSODICA E HIPOGLUCIDA BLANDA, BUEN CONTROL METABOLICO, ANURICA, EN DIALISIS PERITONEAL ADAPTADA

PACIENTE CON INSUFICIENCIA RESPIRATORIA SECUNDARIA A DERRAME PLEURAL DERECHO MASIVO DE ETIOLOGIA A ESTABLECER, CUENTA CON TAC DE TORAX INSTITUCIONAL QUE REPORTA DERRAME PLEURAL SEVERO DERECHO DISPOSICIÓN LIBRE, CON SEPARACIÓN PLEURAL AP DE 75 MM, ATELECTASIAS PASIVAS EN LÓBULO INFERIOR DERECHO Y EN EL SEGMENTO POSTERIOR DE LÓBULO SUPERIOR DERECHO, PARÉNQUIMA PULMONAR SIN IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DE CONSOLIDACIÓN NEUMÓNICA, ATELECTASIAS, MASAS O CAVITACIONES; SE LE REALIZO TORACENTESIS DERECHA DIAGNOSTICA Y TERAPEUTICA, CON ADA POSITIVO EN LIQUIDO PLEURAL CON CARACTERISTICAS DE EXUDADO LINFOCITARIO SEGUN CRITERIOS DE LIGHT, RESTO DE ESTUDIOS NEGATIVOS (KOH, BACILOSCOPIA, GRAM), POR LO CUAL EN CONJUNTO CON INFECTOLOGIA CRITICA SE DECIDIO SOLICITAR VALORACIÓN POR CIRUGIA DE TORAX PARA TOMA DE BIOPSIA POR TORACOSCOPIA QUE NOS PERMITA CONFIRMAR TB PLEURAL QUIENES INDICAN ESPERAR CULTIVOS PARA DETERMINAR TOMA DE CONDUCTAS. POR EL MOMENTO CONTINUA MANEJO MEDICO SIN CAMBIOS, ATENTOS A EVOLUCION CLINICA

SEGUIMIENTO VALORACIÓN POR LOS SERVICIOS DE TERAPIA FÍSICA CUATRO VECES AL DÍA, TERAPIA OCUPACIONAL, FONOAUDIOLOGÍA PARA REHABILITACIÓN TEMPRANA Y PRECOZ DE PACIENTE, TERAPIA RESPIRATORIA INTEGRAL, PSICOLOGÍA CRÍTICA Y TRABAJO SOCIAL PARA REINTEGRO AL MEDIO Y NUCLEO FAMILIAR. SOPORTE NUTRICIONAL Y METABÓLICO CRÍTICO

PACIENTE CON ALTO RIESGO DE FALLA VENTILATORIA E INESTABILIDAD HEMODINAMICA Y REQUERIMIENTO DE SOPORTE VENTILATORIO INVASIVO QUE CONDICIONA NECESIDAD DE MONITORIZACION CONTINUA Y VIGILANCIA Estricta DE PARAMETROS VENTILATORIOS, NEUROLOGICOS,

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:20:11 p. m.

Admisión: AD715724

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: SOL BEATRIZ GARCIA MARQUEZ

EPICRISIS

HEMODINAMICOS Y METABOLICOS.

Fecha: 25/02/2022: 10:03:46, Historia: Evolucion Clinica UCI, Prestador: ALVARO ALFONSO FRIAS SALAZAR, Especialidad: CUIDADO DEL PACIENTE EN ESTADO CRITICO

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE 66 AÑOS DE EDAD, CON ANTECEDENTES DE EXTABAQUISMO PESADO, HIPERTENSION ARTERIAL, DIABETES TIPO 2 INSULINODEPENDIENTE, ENFERMEDAD RENAL CRONICA EN TRR TIPO DIALISIS PERITONEAL Y EPOC SIN DIAGNOSTICO ESPIROMETRICO, QUIEN SE ENCUENTRA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS EN CONTEXTO DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA SECUNDARIA A DERRAME PLEURAL DERECHO MASIVO DE ETIOLOGIA A ESTABLECER, CON ALTA SOSPECHA DE TUBERCULOSIS PLEURAL A CONFIRMAR.

ACTUALMENTE PACIENTE CONSCIENTE, ALERTA, ORIENTADA, AFEBRIL, HEMODINAMICAMENTE COMPENSADA, CIFRAS TENSIONALES EN METAS, SIN REQUERIMIENTO DE SOPORTE VASOACTIVO, EUCARDICA, RITMO SINUSAL, VENTILATORIAMENTE EUPNEICA, SIN USO DE MUSCULOS RESPIRATORIOS ACCESORIOS, SATURACIÓN O2 EN METAS CON REQUERIMIENTO DE OXIGENO SUPLEMENTARIO POR CANULA NASAL A 2 LT/MINUTO, TOLERANDO VIA ORAL CON DIETA HIPOSODICA E HIPOGLUCIDA BLANDA, BUEN CONTROL METABOLICO (GLUCOMETRIA 118 MG/DL), ANURICA, EN DIALISIS PERITONEAL ADAPTADA.

PARACLÍNICOS DEL DIA EVIDENCIAN HEMOGRAMA CON ANEMIA LEVE DE VOLUMENES NORMALES, SIN ALTERACIÓN EN SERIE BLANCA NI PLAQUETAS, FUNCIÓN RENAL CON HIPERAZOEMIA CRÓNICA, IONOGRAMA CON POTASIO EN LIMITE SUPERIOR DE NORMALIDAD.

PACIENTE CON INSUFICIENCIA RESPIRATORIA SECUNDARIA A DERRAME PLEURAL DERECHO MASIVO DE ETIOLOGIA A ESTABLECER, CUENTA CON TAC DE TORAX INSTITUCIONAL QUE REPORTA DERRAME PLEURAL SEVERO DERECHO DISPOSICIÓN LIBRE, CON SEPARACIÓN PLEURAL AP DE 75 MM, ATELECTASIAS PASIVAS EN LÓBULO INFERIOR DERECHO Y EN EL SEGMENTO POSTERIOR DE LÓBULO SUPERIOR DERECHO, PARÉNQUIMA PULMONAR SIN IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DE CONSOLIDACIÓN NEUMÓNICA, ATELECTASIAS, MASAS O CAVITACIONES; SE LE REALIZO TORACENTESIS DERECHA DIAGNOSTICA Y TERAPEUTICA, CON ADA POSITIVO EN LIQUIDO PLEURAL CON CARACTERISTICAS DE EXUDADO LINFOCITARIO SEGUN CRITERIOS DE LIGHT, RESTO DE ESTUDIOS NEGATIVOS (KOH, BACILOSCOPIA, GRAM), POR LO CUAL EN CONJUNTO CON INFECTOLOGIA CRITICA SE DECIDIO SOLICITAR VALORACIÓN POR CIRUGIA DE TORAX PARA TOMA DE BIOPSIA POR TORACOSCOPIA QUE NOS PERMITA CONFIRMAR TB PLEURAL E INICIAR TERAPIA ANTIFIMICA DE ACUERDO A RESULTADOS, SIN EMBARGO, DICHA ESPECIALIDAD CONSIDERA ESPERAR RESULTADO DE CULTIVO PARA MYCOBACTERIUM TBC ANTES DE DECIDIR CONDUCTAS ADICIONALES. PRESENTA REPORTE DE CULTIVO DE LIQUIDO PLEURAL NEGATIVO. POR EL MOMENTO CONTINUA MANEJO MEDICO SIN CAMBIOS, SE INDICA TRASLADO A SALA DE HOSPITALIZACION GENERAL PARA CONTINUAR SEGUIMIENTO Y MANEJO POR MEDICINA INTERNA, INFECTOLOGIA Y CIRUGIA DE TORAX. SE DA INFORME MEDICO A PACIENTE Y FAMILIAR QUIENES REFIEREN ENTENDER Y ACEPTAR CONDUCTA.

SEGUIMIENTO VALORACIÓN POR LOS SERVICIOS DE TERAPIA FÍSICA CUATRO VECES AL DÍA, TERAPIA OCUPACIONAL, FONOAUDIOLOGÍA PARA REHABILITACIÓN TEMPRANA Y PRECOZ DE PACIENTE, TERAPIA RESPIRATORIA INTEGRAL, PSICOLOGÍA CRÍTICA Y TRABAJO SOCIAL PARA REINTEGRO AL MEDIO Y NUCLEO FAMILIAR. SOPORTE NUTRICIONAL Y METABÓLICO CRÍTICO

Fecha: 25/02/2022: 16:30:16, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: EDGARD EDUARDO GUTIERREZ PUENTE, Especialidad: CIRUGIA DEL TORAX

Problema:

Cirugia de Torax

1. Tb pleural.

Subjetivo:

Paciente refiere sentirse en mejores condiciones generales, con disminucion de la disnea.

Objetivo:

EF:

Paciente en regulares condiciones generales, taquipneica, con sopor de o2 por canula nasal, hidratado, hemodinamicamente estable.

Cuello simetrico, movil sin adenopatias regionales.

Murmulo vesicular disminuido en ambos campos pulmonares, sin sobreagregados.

Abdomen globoso, sin masas palpaes, cateter de dialisis implantado.

Análisis:

Paciente con derrame pleural derecho con ADA positivo y exudado linfocito, altamente sugestivo, pero sin diagnostico aun. Por lo anterior, consideramos llevar paciente a toracoscopia para toma de biopsia. Se explica. Solicito val anestesico. Se explica.

Fecha: 25/02/2022: 18:22:49, Historia: Evolucion Clinica UCI, Prestador: ALVARO JESUS GONZALEZ FERNANDEZ, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE 66 AÑOS DE EDAD, CON ANTECEDENTES DE EXTABAQUISMO PESADO, HIPERTENSION ARTERIAL, DIABETES TIPO 2 INSULINODEPENDIENTE, ENFERMEDAD RENAL CRONICA EN TRR TIPO DIALISIS PERITONEAL Y EPOC SIN DIAGNOSTICO ESPIROMETRICO, QUIEN SE ENCUENTRA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS EN CONTEXTO DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA SECUNDARIA A DERRAME PLEURAL DERECHO MASIVO DE ETIOLOGIA A ESTABLECER, CON ALTA SOSPECHA DE TUBERCULOSIS PLEURAL A CONFIRMAR.

ACTUALMENTE PACIENTE CONSCIENTE, ALERTA, ORIENTADA, AFEBRIL, HEMODINAMICAMENTE COMPENSADA, CIFRAS TENSIONALES EN METAS, SIN REQUERIMIENTO DE SOPORTE VASOACTIVO, EUCARDICA, RITMO SINUSAL, VENTILATORIAMENTE EUPNEICA, SIN USO DE MUSCULOS RESPIRATORIOS ACCESORIOS, SATURACIÓN O2 EN METAS CON REQUERIMIENTO DE OXIGENO SUPLEMENTARIO POR CANULA NASAL A 2 LT/MINUTO, TOLERANDO VIA ORAL CON DIETA HIPOSODICA E HIPOGLUCIDA BLANDA, BUEN CONTROL METABOLICO, ANURICA, EN DIALISIS PERITONEAL ADAPTADA.

PACIENTE CON INSUFICIENCIA RESPIRATORIA SECUNDARIA A DERRAME PLEURAL DERECHO MASIVO DE ETIOLOGIA A ESTABLECER, CUENTA CON TAC DE TORAX INSTITUCIONAL QUE REPORTA DERRAME PLEURAL SEVERO DERECHO DISPOSICIÓN LIBRE, CON SEPARACIÓN PLEURAL AP DE 75 MM, ATELECTASIAS PASIVAS EN LÓBULO INFERIOR DERECHO Y EN EL SEGMENTO POSTERIOR DE LÓBULO SUPERIOR DERECHO, PARÉNQUIMA PULMONAR SIN IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DE CONSOLIDACIÓN NEUMÓNICA, ATELECTASIAS, MASAS O CAVITACIONES; SE LE REALIZO TORACENTESIS DERECHA DIAGNOSTICA Y TERAPEUTICA, CON ADA POSITIVO EN LIQUIDO PLEURAL CON CARACTERISTICAS DE EXUDADO LINFOCITARIO SEGUN CRITERIOS DE LIGHT, RESTO DE ESTUDIOS NEGATIVOS (KOH, BACILOSCOPIA, GRAM), POR LO CUAL EN CONJUNTO CON INFECTOLOGIA CRITICA SE DECIDIO SOLICITAR VALORACIÓN POR CIRUGIA DE TORAX, QUIEN CONSIDERO LLEVAR A PACIENTE A toracoscopia para toma de biopsia POR EL MOMENTO CONTINUA MANEJO MEDICO SIN CAMBIOS, PENDIENTE TRASLADO A SALA DE HOSPITALIZACION GENERAL CON HABITACION INDIVIDUAL PARA CONTINUAR SEGUIMIENTO Y MANEJO POR MEDICINA INTERNA, INFECTOLOGIA Y CIRUGIA DE TORAX. SE DA INFORME MEDICO A PACIENTE Y FAMILIAR QUIENES REFIEREN ENTENDER Y ACEPTAR CONDUCTA.

SEGUIMIENTO VALORACIÓN POR LOS SERVICIOS DE TERAPIA FÍSICA CUATRO VECES AL DÍA, TERAPIA OCUPACIONAL, FONOAUDIOLOGÍA PARA REHABILITACIÓN TEMPRANA Y PRECOZ DE PACIENTE, TERAPIA RESPIRATORIA INTEGRAL, PSICOLOGÍA CRÍTICA Y TRABAJO SOCIAL PARA REINTEGRO AL

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:20:11 p. m.

Admisión: AD715724

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: SOL BEATRIZ GARCIA MARQUEZ

EPICRISIS

MEDIO Y NUCLEO FAMILIAR. SOPORTE NUTRICIONAL Y METABÓLICO CRÍTICO

Fecha: 25/02/2022: 22:31:09, Historia: Evolucion Clinica UCI, Prestador: WILLIAM YAMITH CASTRO MENDOZA, Especialidad: CIRUGIA GENERAL

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE 66 AÑOS DE EDAD, CON ANTECEDENTES DE EXTABAQUISMO PESADO, HIPERTENSION ARTERIAL, DIABETES TIPO 2 INSULINODEPENDIENTE, ENFERMEDAD RENAL CRONICA EN TRR TIPO DIALISIS PERITONEAL Y EPOC SIN DIAGNOSTICO ESPIROMETRICO, QUIEN SE ENCUENTRA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS EN CONTEXTO DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA SECUNDARIA A DERRAME PLEURAL DERECHO MASIVO DE ETIOLOGIA A ESTABLECER, CON ALTA SOSPECHA DE TUBERCULOSIS PLEURAL A CONFIRMAR.

DURANTE RONDA MEDICA DE LA NOCHE SE ENCUENTRA PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, NEUROLOGICAMENTE CONSCIENTE, ALERTA, ORIENTADA, AFEBRIL, HEMODINAMICAMENTE COMPENSADA, CIFRAS TENSIONALES EN METAS, SIN REQUERIMIENTO DE SOPORTE VASOACTIVO, EUCARDICA, RITMO SINUSAL, VENTILATORIAMENTE EUPNEICA SIN USO DE MUSCULOS RESPIRATORIOS ACCESORIOS, SATURACIÓN O2 EN METAS CON REQUERIMIENTO DE OXIGENO SUPLEMENTARIO POR CANULA NASAL A 2 L/TMNUO, TOLERANDO VIA ORAL CON DIETA HIPOSODICA E HIPOGLUCIDA BLANDA, BUEN CONTROL METABOLICO, ANURICA, EN DIALISIS PERITONEAL ADAPTADA

PACIENTE QUE EVOLUCIONA EN MARCO DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA SECUNDARIA A DERRAME PLEURAL DERECHO MASIVO DE ETIOLOGIA A ESTABLECER, CUENTA CON TAC DE TORAX INSTITUCIONAL QUE REPORTA DERRAME PLEURAL SEVERO DERECHO DISPOSICIÓN LIBRE, CON SEPARACIÓN PLEURAL AP DE 75 MM, ATELECTASIAS PASIVAS EN LÓBULO INFERIOR DERECHO Y EN EL SEGMENTO POSTERIOR DE LÓBULO SUPERIOR DERECHO, PARÉNQUIMA PULMONAR SIN IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DE CONSOLIDACIÓN NEUMÓNICA ATELECTASIAS, MASAS O CAMTACIONES; SE LE REALIZO TORACENTESIS DERECHA DIAGNOSTICA Y TERAPEUTICA, CON ADA POSITIVO EN LIQUIDO PLEURAL CON CARACTERISTICAS DE EXUDADO LINFOCITARIO SEGUN CRITERIOS DE LIGTH, RESTO DE ESTUDIOS NEGATIVOS (KOH, BACILOSCOPIA, GRAM), POR LO CUAL EN CONJUNTO CON INFECTOLOGIA CRITICA, SE DECIDIO SOLICITAR VALORACIÓN POR CIRUGIA DE TORAX QUIEN INDICA REALIZACION DE TOMA DE BIOPSIA POR TORACOSCOPIA POR EL MOMENTO SIN CAMBIOS ADICIONALES EN EL MANEJO MEDICO INSTAURADO, CON PRONOSTICO Y CONDUCTA MODIFICABLES SEGUN EVOLUCION CLINICA DE LA PACIENTE. SEGUIMOS ATENTOS A SU EVOLUCION SEGUN LA CUAL SE DEFINIRA DESESCALONAMIENTO DE UNIDAD.

SEGUIMIENTO VALORACIÓN POR LOS SERVICIOS DE TERAPIA FÍSICA CUATRO VECES AL DÍA, TERAPIA OCUPACIONAL, FONOAUDIOLOGÍA PARA REHABILITACIÓN TEMPRANA Y PRECOZ DE PACIENTE, TERAPIA RESPIRATORIA INTEGRAL, PSICOLOGÍA CRÍTICA Y TRABAJO SOCIAL PARA REINTEGRO AL MEDIO Y NUCLEO FAMILIAR. SOPORTE NUTRICIONAL Y METABÓLICO CRÍTICO

Fecha: 26/02/2022: 11:13:56, Historia: Evolucion Clinica UCI, Prestador: FABIO ESTEBAN PEREZ BENABIDES, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Análisis:

PARACLINICOS

26-02-2022 LEU 5.14 NEU 68.5% LINF 21.9% HB 9.9 PLAQ 390.000 BUN 55 CR 11.74 NA 133 K 4.8 CL 98

PACIENTE FEMENINA DE 66 AÑOS DE EDAD, CON ANTECEDENTES DE EXTABAQUISMO PESADO, HIPERTENSION ARTERIAL, DIABETES TIPO 2 INSULINODEPENDIENTE, ENFERMEDAD RENAL CRONICA EN TRR TIPO DIALISIS PERITONEAL Y EPOC SIN DIAGNOSTICO ESPIROMETRICO, QUIEN SE ENCUENTRA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS EN CONTEXTO DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA SECUNDARIA A DERRAME PLEURAL DERECHO MASIVO DE ETIOLOGIA A ESTABLECER, CON ALTA SOSPECHA DE TUBERCULOSIS PLEURAL A CONFIRMAR.

DURANTE RONDA MEDICA DE LA MAÑANA SE ENCUENTRA PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, NEUROLOGICAMENTE CONSCIENTE, ALERTA, ORIENTADA, AFEBRIL, HEMODINAMICAMENTE COMPENSADA, CIFRAS TENSIONALES EN METAS, SIN REQUERIMIENTO DE SOPORTE VASOACTIVO, EUCARDICA, RITMO SINUSAL, VENTILATORIAMENTE EUPNEICA SIN USO DE MUSCULOS RESPIRATORIOS ACCESORIOS, SATURACIÓN O2 EN METAS CON REQUERIMIENTO DE OXIGENO SUPLEMENTARIO POR CANULA NASAL A 2 L/TMNUO, TOLERANDO VIA ORAL CON DIETA HIPOSODICA E HIPOGLUCIDA BLANDA, BUEN CONTROL METABOLICO, ANURICA, EN DIALISIS PERITONEAL ADAPTADA

PARACLINICOS DEL DIA DE HOY SIN LEUCOCITOSIS, ANEMIA MODERADA, HIPERAZOEMIA EN MARCO DE ENFERMEDAD RENAL CRONICA, HIPONATREMIA LEVE, SIN OTRAS ALTERACIONES ELECTROLITICAS OBJETIVIZADAS.

PACIENTE QUE EVOLUCIONA EN MARCO DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA SECUNDARIA A DERRAME PLEURAL DERECHO MASIVO DE ETIOLOGIA A ESTABLECER, CUENTA CON TAC DE TORAX INSTITUCIONAL QUE REPORTA DERRAME PLEURAL SEVERO DERECHO DISPOSICIÓN LIBRE, CON SEPARACIÓN PLEURAL AP DE 75 MM, ATELECTASIAS PASIVAS EN LÓBULO INFERIOR DERECHO Y EN EL SEGMENTO POSTERIOR DE LÓBULO SUPERIOR DERECHO, PARÉNQUIMA PULMONAR SIN IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DE CONSOLIDACIÓN NEUMÓNICA ATELECTASIAS, MASAS O CAMTACIONES; SE LE REALIZO TORACENTESIS DERECHA DIAGNOSTICA Y TERAPEUTICA, CON ADA POSITIVO EN LIQUIDO PLEURAL CON CARACTERISTICAS DE EXUDADO LINFOCITARIO SEGUN CRITERIOS DE LIGHT, RESTO DE ESTUDIOS NEGATIVOS (KOH, BACILOSCOPIA, GRAM), FUE VALORADA POR CIRUGIA DE TORAX QUIEN INDICA REALIZACION DE TOMA DE BIOPSIA POR TORACOSCOPIA EL DIA DE HOY SE SOLICITA RX DE TORAX PARA EVALUAR PROGRESION DE DERRAME PLEURAL Y DEFINIR NECESIDAD DE TORACENTESIS EVACUATORIA POR EL MOMENTO SIN CAMBIOS ADICIONALES EN EL MANEJO MEDICO ESTABLECIDO, CON PRONOSTICO Y CONDUCTA MODIFICABLES SEGUN EVOLUCION CLINICA DE LA PACIENTE.

SEGUIMIENTO VALORACIÓN POR LOS SERVICIOS DE TERAPIA FÍSICA CUATRO VECES AL DÍA, TERAPIA OCUPACIONAL, FONOAUDIOLOGÍA PARA REHABILITACIÓN TEMPRANA Y PRECOZ DE PACIENTE, TERAPIA RESPIRATORIA INTEGRAL, PSICOLOGÍA CRÍTICA Y TRABAJO SOCIAL PARA REINTEGRO AL MEDIO Y NUCLEO FAMILIAR. SOPORTE NUTRICIONAL Y METABÓLICO CRÍTICO

Fecha: 26/02/2022: 15:05:37, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: EDGARD EDUARDO GUTIERREZ PUENTE, Especialidad: CIRUGIA DEL TORAX

Problema:

Cirugia de Torax 1. Tb pleural.

Subjetivo:

Paciente refiere sentirse en mejores condiciones genrales, con disminucion de la disnea.

Objetivo:

EF: Paciente en regulares condiciones generales, taquipneica, con sopor de o2 por canula nasal, hidratad,a, hemodinamciamente estbale. Cuello simetrico, móvil sin adenopatias regionales. Murmullo vesicular disminuido en ambos campos pulmonares, sin sobreagregados. Abdomen globoso, sin masas palpales, cateter de dialisis implantado.

Análisis:

Paciente con derrame pleural derecho con ADA positivo y exudado linfocito, altamente sugestivo, pero sin diagnostico aun. Por lo anterior, consideramos llevar paciente a toracosopia para toma de biopsia. Se explica. Pendiente val anestésico. Se explica.

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:20:11 p. m.

Admisión: AD715724

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: SOL BEATRIZ GARCIA MARQUEZ

EPICRISIS

Fecha: 26/02/2022: 18:11:02, Historia: Evolucion Clinica UCI, Prestador: FABIO ESTEBAN PEREZ BENABIDES, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE 66 AÑOS DE EDAD, CON ANTECEDENTES DE EXTABAQUISMO PESADO, HIPERTENSION ARTERIAL, DIABETES TIPO 2 INSULINODEPENDIENTE, ENFERMEDAD RENAL CRONICA EN TRR TIPO DIALISIS PERITONEAL Y EPOC SIN DIAGNOSTICO ESPIROMETRICO, QUIEN SE ENCUENTRA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS EN CONTEXTO DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA SECUNDARIA A DERRAME PLEURAL DERECHO MASIVO DE ETIOLOGIA A ESTABLECER, CON ALTA SOSPECHA DE TUBERCULOSIS PLEURAL A CONFIRMAR.

REGULARES CONDICIONES GENERALES, NEUROLOGICAMENTE CONSCIENTE, ALERTA, ORIENTADA, AFEBRIL, HEMODINAMICAMENTE COMPENSADA, CIFRAS TENSIONALES EN METAS, SIN REQUERIMIENTO DE SOPORTE VASOACTIVO, EUCARDICA, RITMO SINUSAL, VENTILATORIAMENTE EUPNEICA, SIN USO DE MUSCULOS RESPIRATORIOS ACCESORIOS, SATURACIÓN O₂ EN METAS CON REQUERIMIENTO DE OXIGENO SUPLEMENTARIO POR CANULA NASAL A 2 LT/MINUTO, TOLERANDO VIA ORAL CON DIETA HIPOSODICA E HIPOGLUCIDA BLANDA, BUEN CONTROL METABOLICO, ANURICA, EN DIALISIS PERITONEAL ADAPTADA.

EVOLUCIONA EN MARCO DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA SECUNDARIA A DERRAME PLEURAL DERECHO MASIVO DE ETIOLOGIA A ESTABLECER, CON ALTO INDICE DE SOSPECHA DE TUBERCULOSIS PLEURAL POR EXUDADO LINFOCITARIO EN ESTUDIO, EN PLAN DE BIOPSIA POR TORACOSCOPIA POR CIRUGIA DE TORAX EN ESPERA DE PROGRAMACION PREVIO AVAL POR ANESTESIOLOGIA. RADIOGRAFIA DE TORAX CONTROL CON AMPLIO DERRAME PLEURAL DERECHO PERSISTENTE, NO SE DESCARTA DERRAME COMPLICADO CON TRABECULACION POR ESCASO DRENAJE DURANTE TORASCENTESIS PREVIA, CONSERVA ESTABILIDAD CLINICA EN RONDA MEDICA DE LA TARDE, POR EL MOMENTO SIN CAMBIOS ADICIONALES EN EL MANEJO MEDICO ESTABLECIDO, CON PRONOSTICO Y CONDUCTA MODIFICABLES SEGUN EVOLUCION CLINICA DE LA PACIENTE.

SEGUIMIENTO VALORACIÓN POR LOS SERVICIOS DE TERAPIA FÍSICA CUATRO VECES AL DÍA, TERAPIA OCUPACIONAL, FONOAUDIOLOGÍA PARA REHABILITACIÓN TEMPRANA Y PRECOZ DE PACIENTE, TERAPIA RESPIRATORIA INTEGRAL, PSICOLOGÍA CRÍTICA Y TRABAJO SOCIAL PARA REINTEGRO AL MEDIO Y NUCLEO FAMILIAR. SOPORTE NUTRICIONAL Y METABÓLICO CRÍTICO.

Fecha: 26/02/2022: 23:32:56, Historia: Evolucion Clinica UCI, Prestador: ANA MARIA SANTOS ARRIETA, Especialidad: CIRUGIA GENERAL

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE 66 AÑOS DE EDAD, CON ANTECEDENTES DE EXTABAQUISMO PESADO, HIPERTENSION ARTERIAL, DIABETES TIPO 2 INSULINODEPENDIENTE, ENFERMEDAD RENAL CRONICA EN TRR TIPO DIALISIS PERITONEAL Y EPOC SIN DIAGNOSTICO ESPIROMETRICO, QUIEN SE ENCUENTRA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS EN CONTEXTO DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA SECUNDARIA A DERRAME PLEURAL DERECHO MASIVO DE ETIOLOGIA A ESTABLECER, CON ALTA SOSPECHA DE TUBERCULOSIS PLEURAL A CONFIRMAR.

DURANTE RONDA MEDICA DE LA NOCHE ENCUENTRO PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, NEUROLOGICAMENTE CONSCIENTE, ALERTA, ORIENTADA, AFEBRIL, HEMODINAMICAMENTE COMPENSADA, CIFRAS TENSIONALES CON TENDENCIA A LA HIPERTENSION SIN ESTAR EN RANGO DE CRISIS, BAJO TERAPIA ANTIHIPERTENSIVA ORAL, EUCARDICA, RITMO SINUSAL, VENTILATORIAMENTE EUPNEICA, SIN USO DE MUSCULOS RESPIRATORIOS ACCESORIOS, SATURACIÓN O₂ EN METAS CON REQUERIMIENTO DE OXIGENO SUPLEMENTARIO POR CANULA NASAL A 2 LT/MINUTO, TOLERANDO VIA ORAL CON DIETA HIPOSODICA E HIPOGLUCIDA BLANDA, BUEN CONTROL METABOLICO, ANURICA, EN DIALISIS PERITONEAL ADAPTADA.

EVOLUCIONA EN MARCO DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA SECUNDARIA A DERRAME PLEURAL DERECHO MASIVO DE ETIOLOGIA A ESTABLECER, CON ALTO INDICE DE SOSPECHA DE TUBERCULOSIS PLEURAL POR EXUDADO LINFOCITARIO EN ESTUDIO, EN PLAN DE BIOPSIA POR TORACOSCOPIA POR CIRUGIA DE TORAX EN ESPERA DE PROGRAMACION PREVIO AVAL POR ANESTESIOLOGIA. RADIOGRAFIA DE TORAX CONTROL CON AMPLIO DERRAME PLEURAL DERECHO PERSISTENTE, NO SE DESCARTA DERRAME COMPLICADO CON TRABECULACION POR ESCASO DRENAJE DURANTE TORASCENTESIS PREVIA, CONSERVA ESTABILIDAD CLINICA EN RONDA MEDICA DE LA NOCHE, PENDIENTE TRASLADO A SALA GENERAL SGUN DISPONIBILIDAD DE CAMA, POR EL MOMENTO SIN CAMBIOS ADICIONALES EN EL MANEJO MEDICO ESTABLECIDO, CON PRONOSTICO Y CONDUCTA MODIFICABLES SEGUN EVOLUCION CLINICA DE LA PACIENTE.

SEGUIMIENTO VALORACIÓN POR LOS SERVICIOS DE TERAPIA FÍSICA CUATRO VECES AL DÍA, TERAPIA OCUPACIONAL, FONOAUDIOLOGÍA PARA REHABILITACIÓN TEMPRANA Y PRECOZ DE PACIENTE, TERAPIA RESPIRATORIA INTEGRAL, PSICOLOGÍA CRÍTICA Y TRABAJO SOCIAL PARA REINTEGRO AL MEDIO Y NUCLEO FAMILIAR. SOPORTE NUTRICIONAL Y METABÓLICO CRÍTICO.

Fecha: 27/02/2022: 11:06:43, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: ORLANDO SANGUINO OMAÑA, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

1. INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA SECUNDARIA A
 - 1.1 DERRAME PLEURAL DERECHO MASIVO
 - 1.1.1 TUBERCULOSIS PLEURAL A CONFIRMAR
2. ENFERMEDAD RENAL CRONICA EN TRR (DIALISIS PERITONEAL)
3. DIABETES MELLITUS TIPO 2 NO INSULINOREQUIRIENTE
4. HIPERTENSIÓN ARTERIAL CRONICA
5. EPOC SIN DX ESPIROMETRICO
6. DNT CRONICA MODERADA
7. EXTABAQUISTA PESADA

Subjetivo:

PACIENTE QUE EN EL DIA DE HOY REFIERE QUE SE SIENTE AHOGANDO, NIEGA OTRA SINTOMATOLOGIA

Objetivo:

NORMOCEFALO, ISOCORIA NORMORREACTIVA A LA LUZ, MUCOSA ORAL HUMEDA, SIN LESIONES, CUELLO MOVIL SIMETRICO SIN ADENOPATIAS. TORAX SIMETRICO NORMOEXPANSIBLE, SE OBSERVAN TIRAJES INTERCOSTALES Y SUPRACLAVICULARES, DISMINUCION GLOBAL DEL MURMULLO VESICULAR EN HEMOTORAX DERECHO, NO CREPITOS, NO S3 NI SOPLOS. ABDOMEN CON MODERADO PANICULO ADIPOSEO, CATETER DE DIALISIS PERITONEAL EN BUEN ESTADO SIN SIGNOS DE INFECCIÓN, BLANDO, DEPRESIBLE, NO DISTENDIDO, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN NI PROFUNDA NI SUPERFICIAL, SIN SIGNOS DE IRRITACION PERITONEAL. EXTREMIDADES SIMETRICAS, EUTROFICAS, NO EDEMATIZADAS, PULSOS DISTALES PRESENTES, LLENADO CAPILAR. PACIENTE CON DIAGNOSTICOS ANOTADOS, EN PLAN DE TRAQUEOSTOMIA, SE HACE CAMBIO DE NUMERO DE CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DADO A QUE EN EL MOMENTO, LA INSTITUCION NO CUENTA CON CANULA SOLICITADA PARA PACIENTE, LO QUE DIFICULTADO LA PROGRAMACION DEL PROCEDIMIENTO.

Fecha: 25/03/2022: 20:32:07, Historia: Evolucion Clinica UCI, Prestador: JUAN PABLO ORTIZ SALAZAR, Especialidad: CUIDADO DEL PACIENTE EN ESTADO CRITICO

Análisis:

Se trata de femenina en la séptima década de la vida con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, extabaquista; con estancia en la unidad de cuidados crítico en marco de insuficiencia respiratoria con requerimiento de reintubación en plan de realización de traqueostomía; en paciente en contexto de tuberculosis pleural por biopsia recibiendo esquema ripe; con intervención por servicio de cirugía de

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:20:11 p. m.

Admisión: AD715724

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: SOL BEATRIZ GARCIA MARQUEZ

EPICRISIS

tórax decorticación pulmonar, pleurectomía parietal con pleurodesis por toracoscopia.

Desde el punto de vista cardiovascular cursó con síndrome coronario tipo infarto agudo al miocardio con elevación de biomarcadores, con ecocardiograma que reportó remodelado concéntrico con FEV conservada 69%, disfunción diastólica tipo I, dilatación auricular izquierda leve, TAPSE 20 mm, sin intervención adicional.

Paciente renal crónica en diálisis peritoneal, con agudización de la misma; valorado por servicio de nefrología quien considera debe continuar con diálisis peritoneales diarias.

Desde el punto de vista infeccioso con bacteriemia por *Serratia Marcescens* con reporte de hemocultivo control negativo. Recibiendo cubrimiento antimicrobiano con carbapenémico tipo meropenem; cultivo de secreción orotraqueal con crecimiento de *Enterobacter Cloacae* en cultivo previo y *Pseudomona Aeruginosa* en el nuevo.

Continua recibiendo sedanalgesia con derivado opiáceo y dexmedetomidina; bajo soporte ventilatorio invasivo modo aisto controlado por volumen, con adecuados índices de oxigenación al visoscopio, acoplada; taquicárdica, con cifras tensionales con tendencia a la alta, anúrica en paciente renal crónica; recibiendo soporte nutricional enteral con alimento con propósitos médicos especiales tipo pulmocar.

Considero paciente con patologías críticas crónicas, en plan de realización de traqueostomía por servicio de otorrinolaringología, programado para el día lunes 28/03/2022.

Seguimiento por los servicios de terapia física crítica, terapia ocupacional, fonoaudiología para rehabilitación temprana y precoz de paciente, terapia respiratoria integral, psicología crítica y trabajo social para reintegro al medio y núcleo familiar, soporte nutricional y metabólico críticos.

Debe permanecer en la unidad de cuidados intensivos por tratarse con requerimiento de ventilación mecánica invasiva, en riesgo de arritmias malignas, muerte súbita; además de necesidad de monitoreo continuo, vigilancia estricta de parámetros hemodinámicos, ventilatorios, neurológicos y metabólicos.

Fecha: 26/03/2022: 14:29:31, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: EDGARD EDUARDO GUTIERREZ PUENTE, Especialidad: CIRUGIA DEL TORAX

Problema:

1. Tb pleural.

Subjetivo:

Pte. bajo IOT y soporte

Objetivo:

Paciente en malas condiciones generales, Bajo IOT y sedoanalgesia RASS 0, hidratada, sin soporte vasoactivo. Cuello simétrico, móvil sin adenopatías regionales. Murmullo vesicular disminuido en ambos campos pulmonares, sin sobreagregados. Abdomen globoso, sin masas palpables, catéter de diálisis implantado sin signos de infección y funcional. PATOLOGIA Necrosis compatible con TBC

Análisis:

Paciente en regulares condiciones generales, con fallo de extubación, con plan de extubación pero por somnolencia no ha sido posible. En el momento por nuestra especialidad, Se retiro toracostomia sin complicaciones. Continuamos seguimiento hasta lograr estabilización por parte de cuidado de critico. Por ahora sin requerimiento de intervención quirúrgica por nuestra especialidad.

Fecha: 26/03/2022: 16:53:44, Historia: Evolucion Clinica UCI, Prestador: JUAN PABLO ORTIZ SALAZAR, Especialidad: CUIDADO DEL PACIENTE EN ESTADO CRITICO

Análisis:

Femenina en la séptima década de la vida con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, extirpación, enfermedad renal crónica en terapia de remplazo renal a través de cateter peritoneal; que ingresa inicialmente a la unidad debido a falla ventilatoria aguda que ameritó aseguramiento de la vía aérea en relación a derrame pleural masivo, con estudio de liquido pleural con reporte de exudado linfocitario con ada positivo, por lo que ante alta posibilidad de tuberculosis pleural recibe terapia antifimica, con toma de biopsia por toracoscopia por servicio de cirugía de tórax, la cual se llevó a cabo el día 09/03/22 específicamente realizaron decorticación pulmonar + pleurectomía parietal + pleurodesis por toracoscopia, con hallazgos intraoperatorios de lesiones tipo membranas en pleura parietal, con reporte de biopsia de decorticación que evidencia tejido fibroconectivo comprometido por proceso inflamatorio agudo y crónico, zonas de necrosis y de pleura parietal que evidencia compromiso de proceso granulomatoso crónico necrotizante compatible con tuberculosis. Durante su curso en la unidad, su proceso se ve entorpecido por detrimento neurologico marcado en relación a uremia producto de agudización de enfermedad renal, que ameritó reintubación y ajuste de TRR peritoneal diarias, ademas cursó con síndrome coronario agudo tipo infarto agudo al miocardio sin elevación del ST, concomitante con choque séptico requiriente de soporte vasoactivo, ya destetado. Actualmente con estancia en la Unidad de Cuidado crítico en contexto de bacteriemia por *Serratia Marcescens* multisensible tratada, con hemocultivo control negativo y foco pulmonar *Enterobacter Cloacae* multisensible/ actualmente *Pseudomonas auruginosa*, recibiendo cubrimiento antimicrobiano con carbapenémico.

Actualmente se encuentra en regulares condiciones generales bajo sedoanalgesia con derivado del opiáceo tipo fentanyl + dexmedetomidina, RASS -2, acoplada a ventilación mecánica invasiva modo AC/V, conservando adecuados índices de oxigenación al visoscopio, manejando secreciones mucoides; afebril, a nivel hemodinamico eucardica y cifras tensionales en metas sin requerimiento de soporte vasoactivo, anúrica en paciente renal crónica en terapia de reemplazo renal peritonea, con agudización de la misma; realizandose sesiones diarias por servicio de nefrología; recibiendo soporte nutricional enteral con alimento con propósitos médicos especiales tipo pulmocar sin disponibilidad institucional, a nivel metabólico se ha caracterizado por variabilidad glucémica producto de enfermedad critica (glucometras 00:00 h 346 - 06:00 h 319).

Se reciben paradiagnosticos de hoy que evidencian leucocitosis en descenso, anemia moderada, plaquetas en metas, tiempos de coagulación adecuados, azoados elevados, hiperkalemia, resto de ionograma sin alteraciones, PCR elevada, AST fuera de rango de normalidad con ALT en metas, bilirrubina total dentro de la normalidad sin embargo con aumento de bilirrubina directa.

Desde el punto de vista cardiovascular cursó con síndrome coronario tipo infarto agudo al miocardio con elevación de biomarcadores, con ecocardiograma que reportó remodelado concéntrico con FEV conservada 69%, disfunción diastólica tipo I, dilatación auricular izquierda leve, TAPSE 20 mm, sin intervención adicional.

Paciente renal crónica en diálisis peritoneal, con agudización de la misma; valorado por servicio de nefrología quien considera debe continuar con diálisis peritoneales diarias, el día de ayer con ultrafiltrado de 2900 cc, sin embargo, ante azoados estacionarios y persistencia de hiperkalemia, se solicita concepto para reajuste de terapia dialitica.

Desde el punto de vista infeccioso con bacteriemia por *Serratia Marcescens* con reporte de hemocultivo control negativo. Recibiendo cubrimiento antimicrobiano con carbapenémico tipo meropenem; cultivo de secreción orotraqueal con crecimiento de *Enterobacter Cloacae* en cultivo previo y *Pseudomona Aeruginosa* en el nuevo. Continua terapia ripe debido a confirmación histologica de tbc pleural.

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:20:11 p. m.

Admisión: AD715724

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: SOL BEATRIZ GARCIA MARQUEZ

EPICRISIS

Paciente quien se encontraba recibiendo soporte nutricional enteral con alimento con propósitos médicos especiales tipo pulmocare, sin embargo, ante no disponibilidad en la institución, se ordena inicio de alimento para propósitos médicos especiales tipo ensure clínico frasco 220 ml (aporte proteico 67.5 gr en 24 horas, cálculo a 1.5 gr/kg/día, aporte calórico 1114 kcal/día, cálculo a 25 kcal/kg/día, volumen total 742.5 ml), meta de 31 cc/hora.

Considero paciente con patologías críticas crónicas, en plan de realización de traqueostomía por servicio de otorrinolaringología, programado para el día lunes 28/03/2022.

Seguimiento por los servicios de terapia física crítica, terapia ocupacional, fonoaudiología para rehabilitación temprana y precoz de paciente, terapia respiratoria integral, psicología crítica y trabajo social para reintegro al medio y núcleo familiar, soporte nutricional y metabólico críticos.

Debe permanecer en la unidad de cuidados intensivos por tratarse con requerimiento de ventilación mecánica invasiva, en riesgo de arritmias malignas, muerte súbita; además de necesidad de monitoreo continuo, vigilancia estricta de parámetros hemodinámicos, ventilatorios, neurológicos y metabólicos.

Fecha: 26/03/2022: 20:54:56, Historia: Evolución Clínica UCI, Prestador: JUAN PABLO ORTIZ SALAZAR, Especialidad: CUIDADO DEL PACIENTE EN ESTADO CRÍTICO

Análisis:

Femenina en la séptima década de la vida con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, exabiquista, enfermedad renal crónica en terapia de remplazo renal a través de catéter peritoneal; que ingresa inicialmente a la unidad debido a falla ventilatoria aguda que ameritó aseguramiento de la vía aérea en relación a derrame pleural masivo, con estudio de líquido pleural con reporte de exudado linfocitario con ADA positivo, por lo que ante alta posibilidad de tuberculosis pleural recibe terapia antifúngica, con toma de biopsia por toracoscopia por servicio de cirugía de tórax, la cual se llevó a cabo el día 09/03/22 específicamente realizaron decorticación pulmonar + pleurectomía parietal + pleurodesis por toracoscopia, con hallazgos intraoperatorios de lesiones tipo membranas en pleura parietal, con reporte de biopsia de decorticación que evidencia tejido fibroconectivo comprometido por proceso inflamatorio agudo y crónico, zonas de necrosis y de pleura parietal que evidencia compromiso de proceso granulomatoso crónico necrotizante compatible con tuberculosis. Durante su curso en la unidad, su proceso se ve entorpecido por detrimento neurológico marcado en relación a uremia producto de agudización de enfermedad renal, que ameritó reintubación y ajuste de TRR peritoneal diarias, además cursó con síndrome coronario agudo tipo infarto agudo al miocardio sin elevación del ST, concomitante con choque séptico requirente de soporte vasoaditivo, ya destetado. Actualmente con estancia en la Unidad de Cuidado crítico en contexto de bacteriemia por *Serratia Marcescens* multisensible tratada, con hemocultivo control negativo y foco pulmonar *Enterobacter Cloacae* multisensible/ actualmente *Pseudomonas aeruginosa*, recibiendo cubrimiento antimicrobiano con carbapenémico.

En ronda de la noche se encuentra a paciente en regulares condiciones generales bajo sedoanalgesia con derivado del opiáceo tipo fentanyl + dexmedetomidina, RASS -2, acoplada a ventilación mecánica invasiva modo AC/V, conservando adecuados índices de oxigenación al visoscopio, manejando secreciones mucoides; afebril, a nivel hemodinámico eucárdico y cifras tensionales elevadas sin requerimiento de soporte vasoaditivo, anúrica en paciente renal crónica en terapia de reemplazo renal peritoneal, con agudización de la misma; realizándose sesiones diarias por servicio de nefrología; recibiendo soporte nutricional enteral con alimento con propósitos médicos especiales tipo ensure clínico frasco 220 ml (aporte proteico 67.5 gr en 24 horas, cálculo a 1.5 gr/kg/día, aporte calórico 1114 kcal/día, cálculo a 25 kcal/kg/día, volumen total 742.5 ml), meta de 31 cc/hora, debido a no disponibilidad institucional de pulmocare, a nivel metabólico con variabilidad glucémica producto de enfermedad crítica.

Desde el punto de vista cardiovascular cursó con síndrome coronario tipo infarto agudo al miocardio con elevación de biomarcadores, con ecocardiograma que reportó remodelado concéntrico con FEV conservada 69%, disfunción diastólica tipo I, dilatación auricular izquierda leve, TAPSE 20 mm, sin intervención adicional.

Paciente renal crónica en diálisis peritoneal, con agudización de la misma; valorado por servicio de nefrología quien considera debe continuar con diálisis peritoneales diarias, el día de ayer con ultrafiltrado de 2900 cc, sin embargo, ante azoados estacionarios y persistencia de hiperkalemia, no encontramos a la espera de nuevo concepto para reajuste de terapia dialítica.

Desde el punto de vista infeccioso con bacteriemia por *Serratia Marcescens* con reporte de hemocultivo control negativo. Recibiendo cubrimiento antimicrobiano con carbapenémico tipo meropenem; cultivo de secreción orotraqueal con crecimiento de *Enterobacter Cloacae* en cultivo previo y *Pseudomonas aeruginosa* en el nuevo. Continúa terapia rípe debido a confirmación histológica de tbc pleural.

Considero paciente con patologías críticas crónicas, en plan de realización de traqueostomía por servicio de otorrinolaringología, programado para el día lunes 28/03/2022. En ronda médica se indica continuar órdenes previas. Atentos a su evolución.

Seguimiento por los servicios de terapia física crítica, terapia ocupacional, fonoaudiología para rehabilitación temprana y precoz de paciente, terapia respiratoria integral, psicología crítica y trabajo social para reintegro al medio y núcleo familiar, soporte nutricional y metabólico críticos.

Debe permanecer en la unidad de cuidados intensivos por tratarse con requerimiento de ventilación mecánica invasiva, en riesgo de arritmias malignas, muerte súbita; además de necesidad de monitoreo continuo, vigilancia estricta de parámetros hemodinámicos, ventilatorios, neurológicos y metabólicos.

Fecha: 27/03/2022: 10:17:01, Historia: Evolución Clínica UCI, Prestador: FELIPE HERRERA RUIZ, Especialidad: CUIDADO DEL PACIENTE EN ESTADO CRÍTICO

Análisis:

PARACLÍNICOS 27/03/22:

NA:136 K:5.3 CL:101

GASES ARTERIALES: PH:7.42 PO2:136 PCO2:39.3 HCO3:24.9 PAFI:456 LACT:0.67

Femenina en la séptima década de la vida con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, exabiquista, enfermedad renal crónica en terapia de remplazo renal a través de catéter peritoneal; que ingresa inicialmente a la unidad debido a falla ventilatoria aguda que ameritó aseguramiento de la vía aérea en relación a derrame pleural masivo, con estudio de líquido pleural con reporte de exudado linfocitario con ADA positivo, por lo que ante alta posibilidad de tuberculosis pleural recibe terapia antifúngica, con toma de biopsia por toracoscopia por servicio de cirugía de tórax, la cual se llevó a cabo el día 09/03/22 específicamente realizaron decorticación pulmonar + pleurectomía parietal + pleurodesis por toracoscopia, con hallazgos intraoperatorios de lesiones tipo membranas en pleura parietal, con reporte de biopsia de decorticación que evidencia tejido fibroconectivo comprometido por proceso inflamatorio agudo y crónico, zonas de necrosis y de pleura parietal que evidencia compromiso de proceso granulomatoso crónico necrotizante compatible con tuberculosis. Durante su curso en la unidad, su proceso se ve entorpecido por detrimento neurológico marcado en relación a uremia producto de agudización de enfermedad renal, que ameritó reintubación y ajuste de TRR peritoneal diarias, además cursó con síndrome coronario agudo tipo infarto agudo al miocardio sin elevación del ST, concomitante con choque séptico requirente de soporte vasoaditivo, ya destetado. Actualmente con estancia en la Unidad de Cuidado crítico en contexto de bacteriemia por *Serratia Marcescens* multisensible tratada, con hemocultivo control negativo y foco pulmonar *Enterobacter Cloacae* multisensible/ actualmente *Pseudomonas aeruginosa*, recibiendo cubrimiento antimicrobiano con carbapenémico.

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:20:11 p. m.

Admisión: AD715724

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: SOL BEATRIZ GARCIA MARQUEZ

EPICRISIS

Paciente en regulares condiciones generales bajo sedoanalgesia con derivado del opiáceo tipo fentanyl + dexmedetomidina, RASS -2, acoplada a ventilación mecánica invasiva modo AC/V, conservando adecuados índices de oxigenación al visoscopio, manejando secreciones mucoides; afebril, a nivel hemodinámico eucárdica y cifras tensionales elevadas sin requerimiento de soporte vasoactivo, anúrica en paciente renal crónica en terapia de reemplazo renal peritoneal, con agudización de la misma; realizándose sesiones diarias por servicio de nefrología; recibiendo soporte nutricional enteral con alimento con propósitos médicos especiales tipo ensure clinical frasco 220 ml (aporte proteico 67.5 gr en 24 horas, cálculo a 1.5 gr/kg/día, aporte calórico 1114 kcal/día, cálculo a 25 kcal/kg/día, volumen total 742.5 ml), meta de 31 cc/hora, debido a no disponibilidad institucional de pulmocare, a nivel metabólico con variabilidad glucémica producto de enfermedad crítica.

Paraclínicos de hoy sin trastorno electrolítico, gases arteriales con pafi adecuada, sin hiperlactatemia.

Desde el punto de vista cardiovascular cursó con síndrome coronario tipo infarto agudo al miocardio con elevación de biomarcadores, con ecocardiograma que reportó remodelado concéntrico con FEV conservada 69%, disfunción diastólica tipo I, dilatación auricular izquierda leve, TAPSE 20 mm, sin intervención adicional.

Paciente renal crónica en diálisis peritoneal, con agudización de la misma; valorado por servicio de nefrología quien considera debe continuar con diálisis peritoneales diarias, sin embargo, ante azoados estacionarios y persistencia de hiperkalemia, no encontramos a la espera de nuevo concepto para reajuste de terapia dialítica.

Desde el punto de vista infeccioso con bacteriemia por *Serratia Marcescens* con reporte de hemocultivo control negativo. Recibiendo cubrimiento antimicrobiano con carbapenémico tipo meropenem; cultivo de secreción orotraqueal con crecimiento de *Enterobacter Cloacae* en cultivo previo y *Pseudomona Aeruginosa* en el nuevo. Continúa terapia rípe debido a confirmación histológica de tbc pleural.

Considero paciente con patologías críticas crónicas, en plan de realización de traqueostomía por servicio de otorrinolaringología, programado para el día lunes 28/03/2022. El día de hoy dado resolución de hiponatremia suspendo solución salina, se indica continuar resto de órdenes previas. Atentos a su evolución.

Seguimiento por los servicios de terapia física crítica, terapia ocupacional, fonoaudiología para rehabilitación temprana y precoz de paciente, terapia respiratoria integral, psicología crítica y trabajo social para reintegro al medio y núcleo familiar, soporte nutricional y metabólico críticos.

Debe permanecer en la unidad de cuidados intensivos por tratarse con requerimiento de ventilación mecánica invasiva, en riesgo de arritmias malignas, muerte súbita; además de necesidad de monitoreo continuo, vigilancia estricta de parámetros hemodinámicos, ventilatorios, neurológicos y metabólicos.

Fecha: 27/03/2022: 12:56:34, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: EDGARD EDUARDO GUTIERREZ PUENTE, Especialidad: CIRUGIA DEL TORAX

Problema:

1. Tb pleural.

Subjetivo:

Pte. bajo IOT y soporte

Objetivo:

Paciente en malas condiciones generales, Bajo IOT y sedoanalgesia RASS 0, hidratada, sin soporte vasoactivo. Cuello simétrico, móvil sin adenopatías regionales. Murmullo vesicular disminuido en ambos campos pulmonares, sin sobreagregados. Abdomen globoso, sin masas palpables, catéter de diálisis implantado sin signos de infección y funcional. PATOLOGIA Necrosis compatible con TBC

Análisis:

Paciente en regulares condiciones generales, con fallo de extubación, con plan de extubación pero por somnolencia no ha sido posible. En el momento por nuestra especialidad, Se retiró toracostomía sin complicaciones. Continuamos seguimiento hasta lograr estabilización por parte de cuidado de crítico. Por ahora sin requerimiento de intervención quirúrgica por nuestra especialidad.

Fecha: 28/03/2022: 01:47:44, Historia: Evolución Clínica UCI, Prestador: HECTOR ROLANDO ROMERO RIVERA, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Análisis:

Femenina en la séptima década de la vida con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, extirpación, enfermedad renal crónica en terapia de reemplazo renal a través de catéter peritoneal; que ingresa inicialmente a la unidad debido a falla ventilatoria aguda que ameritó aseguramiento de la vía aérea en relación a derrame pleural masivo, con estudio de líquido pleural con reporte de exudado linfocitario con ADA positivo, por lo que ante alta posibilidad de tuberculosis pleural recibe terapia antifúngica, con toma de biopsia por toracoscopia por servicio de cirugía de tórax, la cual se llevó a cabo el día 09/03/22 específicamente realizaron decorticación pulmonar + pleurectomía parietal + pleurodesis por toracoscopia, con hallazgos intraoperatorios de lesiones tipo membranas en pleura parietal, con reporte de biopsia de decorticación que evidencia tejido fibroconectivo comprometido por proceso inflamatorio agudo y crónico, zonas de necrosis y de pleura parietal que evidencia compromiso de proceso granulomatoso crónico necrotizante compatible con tuberculosis. Durante su curso en la unidad, su proceso se ve entorpecido por detrimento neurológico marcado en relación a uremia producto de agudización de enfermedad renal, que ameritó reintubación y ajuste de TRR peritoneal diarias, además cursó con síndrome coronario agudo tipo infarto agudo al miocardio sin elevación del ST, concomitante con choque séptico requiriente de soporte vasoactivo, ya destetado. Actualmente con estancia en la Unidad de Cuidado crítico en contexto de bacteriemia por *Serratia Marcescens* multisensible tratada, con hemocultivo control negativo y foco pulmonar *Enterobacter Cloacae* multisensible/ actualmente *Pseudomonas aeruginosa*, recibiendo cubrimiento antimicrobiano con carbapenémico.

En ronda de la noche encuentro a paciente en regulares condiciones generales bajo sedoanalgesia con derivado del opiáceo tipo fentanyl + dexmedetomidina, RASS -2, acoplada a ventilación mecánica invasiva modo AC/V, conservando adecuados índices de oxigenación al visoscopio, manejando secreciones mucoides; afebril, a nivel hemodinámico eucárdica y cifras tensionales en metas sin requerimiento de soporte vasoactivo, anúrica en paciente renal crónica en terapia de reemplazo renal peritoneal, con agudización de la misma, realizándose sesiones diarias por servicio de nefrología; recibiendo soporte nutricional enteral con alimento con propósitos médicos especiales tipo ensure clinical frasco 220 ml (aporte proteico 67.5 gr en 24 horas, cálculo a 1.5 gr/kg/día, aporte calórico 1114 kcal/día, cálculo a 25 kcal/kg/día, volumen total 742.5 ml), meta de 31 cc/hora, debido a no disponibilidad institucional de pulmocare, a nivel metabólico con variabilidad glucémica producto de enfermedad crítica.

Desde el punto de vista cardiovascular cursó con síndrome coronario tipo infarto agudo al miocardio con elevación de biomarcadores, con ecocardiograma que reportó remodelado concéntrico con FEV conservada 69%, disfunción diastólica tipo I, dilatación auricular izquierda leve, TAPSE 20 mm, sin intervención adicional.

Paciente renal crónica en diálisis peritoneal, con agudización de la misma; valorado por servicio de nefrología quien considera debe continuar con diálisis peritoneales diarias, sin embargo, ante azoados estacionarios y persistencia de hiperkalemia, no encontramos a la espera de nuevo concepto para reajuste de terapia dialítica, con última sesión el día 27/03/2022 con ultrafiltración de 2130 cc sin complicaciones.

Desde el punto de vista infeccioso con bacteriemia por *Serratia Marcescens* con reporte de hemocultivo control negativo. Recibiendo cubrimiento antimicrobiano con carbapenémico tipo meropenem; cultivo de secreción orotraqueal con crecimiento de *Enterobacter Cloacae* en cultivo previo y *Pseudomona Aeruginosa* en el

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:20:11 p. m.

Admisión: AD715724

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: SOL BEATRIZ GARCIA MARQUEZ

EPICRISIS

nuevo. Continúa terapia ripe debido a confirmación histológica de tbc pleural.

Considero paciente con patologías críticas crónicas, en plan de realización de traqueostomía por servicio de otorrinolaringología, programado para el día lunes 28/03/2022, se da orden de iniciar suero dextrosado una vez se suspenda soporte nutricional por procedimiento para asegurar aporte calórico. Se indica continuar resto de ordenes previas. Atentos a su evolución.

Seguimiento por los servicios de terapia física crítica, terapia ocupacional, fonoaudiología para rehabilitación temprana y precoz de paciente, terapia respiratoria integral, psicología crítica y trabajo social para reintegro al medio y núcleo familiar, soporte nutricional y metabólico críticos.

Debe permanecer en la unidad de cuidados intensivos por tratarse con requerimiento de ventilación mecánica invasiva, en riesgo de arritmias malignas, muerte súbita; además de necesidad de monitoreo continuo, vigilancia estricta de parámetros hemodinámicos, ventilatorios, neurológicos y metabólicos.

Fecha: 28/03/2022: 10:48:05, Historia: Evolución Clínica UCI, Prestador: DANIEL ENRIQUE ALVARADO CUETO, Especialidad: CUIDADO DEL PACIENTE EN ESTADO CRÍTICO

Análisis:

PARACLINICOS (28/03/2022):

Hemograma: LEU 22,930 NEU 74,3% HB 7,7 HTO 25,9 VCM 99,9 HCM 29,8 PLT 448 TP 10,1/11 TPT 26,7/28,6 BUN 91 CREA 7,08 NA 138 K 6,6 CL 102

Gases arteriales: PH 7,42 PO2 113,5 PCO2 34,6 HCO3 22,3 PAFI 378 BE -1,8 LACT 0,57 SO2 98,3%

BIOPSIA: Decorticación: tejido fibroconectivo comprometido por proceso inflamatorio agudo y crónico, zonas de necrosis. Pleura parietal: comprometido por proceso granulomatoso crónico necrotizante compatible con tuberculosis.

ANÁLISIS:

Se trata de femenina en la séptima década de la vida con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, extabaquista; con estancia en la unidad de cuidados críticos en marco de insuficiencia respiratoria con requerimiento de reintubación en plan de realización de traqueostomía; en paciente en contexto de tuberculosis pleural por biopsia recibiendo esquema ripe; con intervención por servicio de cirugía de tórax decorticación pulmonar, pleurectomía parietal con pleurodesis por toracoscopia.

Desde el punto de vista cardiovascular cursó con síndrome coronario tipo infarto agudo al miocardio con elevación de biomarcadores, con ecocardiograma que reportó remodelado concéntrico con FEV conservada 69%, disfunción diastólica tipo I, dilatación auricular izquierda leve, TAPSE 20 mm, sin intervención adicional.

Paciente renal crónica en diálisis peritoneal, con agudización de la misma; valorado por servicio de nefrología quien considera debe continuar con diálisis peritoneales diarias. El día de ayer con ultrafiltrado de 2130 ml.

Desde el punto de vista infeccioso con bacteriemia por *Serratia Marcescens* con reporte de hemocultivo control negativo. Recibiendo cubrimiento antimicrobiano con carbapenémico tipo meropenem; cultivo de secreción orotraqueal con crecimiento de *Enterobacter Cloacae* en cultivo previo y *Pseudomona Aeruginosa* en el nuevo.

Paciente en regulares condiciones generales, recibiendo sedoanalgesia por derivado opiáceo y dexmedetomidina; bajo soporte ventilatorio invasivo modo a/c controlado por volumen, con adecuados índices de oxigenación al visoscopio, acoplada; taquicárdica, con cifras tensionales en meta, anúrica en paciente renal crónica; persiste con mejor control metabólico (glucemias: 141-181-189 mg/dl), con indicación de soporte nutricional enteral con alimento con propósitos médicos especiales tipo pulmocar 237 ml (aporte proteico en 24 horas: 67.5 g, cálculo a 1.5 g prot/kg/día, 1617 kcalorías totales, volumen total) meta de 45 cc/hora. Recibiendo aporte calórico con dextrosados dado por procedimiento.

Considero paciente con patologías críticas crónicas, en plan de realización de traqueostomía por servicio de otorrinolaringología, programado para el día hoy.

Seguimiento por los servicios de terapia física crítica, terapia ocupacional, fonoaudiología para rehabilitación temprana y precoz de paciente, terapia respiratoria integral, psicología crítica y trabajo social para reintegro al medio y núcleo familiar, soporte nutricional y metabólico críticos.

Debe permanecer en la unidad de cuidados intensivos por tratarse con requerimiento de ventilación mecánica invasiva, en riesgo de arritmias malignas, muerte súbita; además de necesidad de monitoreo continuo, vigilancia estricta de parámetros hemodinámicos, ventilatorios, neurológicos y metabólicos.

Fecha: 28/03/2022: 11:30:58, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: EDGARD EDUARDO GUTIERREZ PUENTE, Especialidad: CIRUGIA DEL TORAX

Problema:

1. Tb pleural.

Subjetivo:

Pte. bajo IOT y soporte

Objetivo:

Paciente en malas condiciones generales, Bajo IOT y sedoanalgesia RASS 0, hidratada, sin soporte vasoactivo. Cuello simétrico, móvil sin adenopatías regionales. Murmullo vesicular disminuido en ambos campos pulmonares, sin sobreagregados. Abdomen globoso, sin masas palpables, catéter de diálisis implantado sin signos de infección y funcional. **PATOLOGIA** Necrosis compatible con TBC

Análisis:

Paciente en regulares condiciones generales, con fallo de extubación, con plan de extubación pero por somnolencia no ha sido posible. En el momento por nuestra especialidad, Se retiró toracostomía sin complicaciones. Continuamos seguimiento hasta lograr estabilización por parte de cuidado de crítico. Por ahora sin requerimiento de intervención quirúrgica por nuestra especialidad.

Fecha: 28/03/2022: 16:49:37, Historia: Evolución Clínica UCI, Prestador: LUIS CARLOS JULIO NARVAEZ, Especialidad: CUIDADO DEL PACIENTE EN ESTADO CRÍTICO

Análisis:

Femenina en la séptima década de la vida con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, extabaquista, enfermedad renal crónica en terapia de remplazo renal a través de catéter peritoneal; que ingresa inicialmente a la unidad debido a falla ventilatoria aguda que ameritó aseguramiento de la vía aérea en relación a derrame pleural masivo, con estudio de líquido pleural con reporte de exudado linfocitario con ADA positivo, por lo que ante alta posibilidad de tuberculosis pleural recibe terapia antifúngica, con toma de biopsia por toracoscopia por servicio de cirugía de tórax, la cual se llevó a cabo el día 09/03/22 específicamente realizaron decorticación pulmonar + pleurectomía parietal + pleurodesis por toracoscopia, con hallazgos intraoperatorios de lesiones tipo membranas en pleura parietal, con reporte de biopsia de decorticación que evidencia tejido fibroconectivo comprometido por proceso inflamatorio agudo y crónico, zonas de necrosis y de pleura parietal que evidencia compromiso de proceso granulomatoso crónico necrotizante compatible con tuberculosis. Durante su curso en la unidad, su proceso se ve entorpecido por detrimento neurológico marcado en relación a uremia

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:20:11 p. m.

Admisión: AD715724

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: SOL BEATRIZ GARCIA MARQUEZ

EPICRISIS

producto de agudización de enfermedad renal, que ameritó reintubación y ajuste de TRR peritoneal diarias, además cursó con síndrome coronario agudo tipo infarto agudo al miocardio sin elevación del ST, concomitante con choque séptico requirente de soporte vasoactivo, ya destetado. Con estancia en la Unidad de Cuidado crítico en contexto de bacteriemia por *Serratia Marcescens* multisensible, con hemocultivo control negativo y foco pulmonar *Enterobacter Cloacae* multisensible/ último con *Pseudomonas auruginosa* multidrogorresistente, recibiendo cubrimiento antimicrobiano con carbapenémico. Actualmente en su postoperatorio inmediato de taqueostomía vía abierta, procedimiento realizado por servicio de ORL el 28/03/22, sin ninguna complicación intraquirúrgica documentada.

Actualmente se encuentra en regulares condiciones generales bajo sedoanalgesia con derivado del opiáceo tipo fentanyl + dexmedetomidina, RASS 0, acoplada a ventilación mecánica, a través de cánula de traqueostomía, modo AC/V, conservando adecuados índices de oxigenación al viscoscopio; afebril, a nivel hemodinámico taquicárdica y cifras tensionales en metas sin requerimiento de soporte vasoactivo, anúrica en paciente renal crónica en terapia de reemplazo renal peritonea, con agudización de la misma; realizándose sesiones diarias por servicio de nefrología; recibiendo soporte nutricional enteral con alimento con propósitos médicos especiales tipo tipo ensure clínico frasco 220 ml (aporte proteico 67.5 gr en 24 horas, cálculo a 1.5 gr/kg/día, aporte calórico 1114 kcal/día, cálculo a 25 kcal/kg/día, volumen total 742.5 ml), meta de 31 cc/hora, recibiendo esquema de insulina basal, con últimas glucometrías en metas.

Considero paciente con patologías críticas crónicas, quien cuenta con reporte de cultivo de secreción orotraqueal con crecimiento de *Pseudomonas Auruginosa*, sensible a meropenem por lo que continúa con dicho antibiótico. En paraclinicos de hoy llamativo leucocitosis, con cinética incrementando, por lo que instauro quinolona como sinergismo antibiótico.

Paciente en su postoperatorio inmediato, con sangrado a nivel de sitio de abordaje quirúrgico de traqueostomía, que no cedía a medidas compresivas, por lo que se indica antifibrinolítico y se notifica a servicio de ORL quienes instauran vendaje compresivo como método hemostático.

Seguimiento por los servicios de terapia física crítica, terapia ocupacional, fonoaudiología para rehabilitación temprana y precoz de paciente, terapia respiratoria integral, psicología crítica y trabajo social para reintegro al medio y núcleo familiar, soporte nutricional y metabólico críticos.

Debe permanecer en la unidad de cuidados intensivos por tratarse con requerimiento de ventilación mecánica invasiva, en riesgo de arritmias malignas, muerte súbita; además de necesidad de monitoreo continuo, vigilancia estricta de parámetros hemodinámicos, ventilatorios, neurológicos y metabólicos.

Fecha: 28/03/2022: 22:46:44, **Historia:** Evolución Clínica UCI, **Prestador:** JUAN PABLO ORTIZ SALAZAR, **Especialidad:** CUIDADO DEL PACIENTE EN ESTADO CRÍTICO

Análisis:

Femenina en la séptima década de la vida con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, extirpación, enfermedad renal crónica en terapia de reemplazo renal a través de catéter peritoneal; que ingresa inicialmente a la unidad debido a falla ventilatoria aguda que ameritó aseguramiento de la vía aérea en relación a derrame pleural masivo, con estudio de líquido pleural con reporte de exudado linfocitario con ADA positivo, por lo que ante alta posibilidad de tuberculosis pleural recibe terapia antifúngica, con toma de biopsia por toracoscopia por servicio de cirugía de tórax, la cual se llevó a cabo el día 09/03/22 específicamente realizaron decorticación pulmonar + pleurectomía parietal + pleurodesis por toracoscopia, con hallazgos intraoperatorios de lesiones tipo membranas en pleura parietal, con reporte de biopsia de decorticación que evidencia tejido fibroconectivo comprometido por proceso inflamatorio agudo y crónico, zonas de necrosis y de pleura parietal que evidencia compromiso de proceso granulomatoso crónico necrotizante compatible con tuberculosis. Durante su curso en la unidad, su proceso se ve entorpecido por detrimento neurológico marcado en relación a uremia producto de agudización de enfermedad renal, que ameritó reintubación y ajuste de TRR peritoneal diarias, además cursó con síndrome coronario agudo tipo infarto agudo al miocardio sin elevación del ST, concomitante con choque séptico requirente de soporte vasoactivo, ya destetado. Con estancia en la Unidad de Cuidado crítico en contexto de bacteriemia por *Serratia Marcescens* multisensible, con hemocultivo control negativo y foco pulmonar *Enterobacter Cloacae* multisensible/ último con *Pseudomonas auruginosa* multidrogorresistente, recibiendo cubrimiento antimicrobiano con carbapenémico. Actualmente en su postoperatorio inmediato de taqueostomía vía abierta, procedimiento realizado por servicio de ORL el 28/03/22, sin ninguna complicación intraquirúrgica documentada.

En ronda de la noche se encuentra en regulares condiciones generales bajo sedoanalgesia con derivado del opiáceo tipo fentanyl + dexmedetomidina, RASS 0, acoplada a ventilación mecánica a través de cánula de traqueostomía, modo AC/V, conservando adecuados índices de oxigenación al viscoscopio; afebril, a nivel hemodinámico eucárdica y cifras tensionales en metas sin requerimiento de soporte vasoactivo, anúrica en paciente renal crónica en terapia de reemplazo renal peritonea, con agudización de la misma, realizándose sesiones diarias por servicio de nefrología; recibiendo soporte nutricional enteral con alimento con propósitos médicos especiales tipo tipo ensure clínico frasco 220 ml (aporte proteico 67.5 gr en 24 horas, cálculo a 1.5 gr/kg/día, aporte calórico 1114 kcal/día, cálculo a 25 kcal/kg/día, volumen total 742.5 ml), meta de 31 cc/hora, recibiendo esquema de insulina basal, con últimas glucometrías en metas.

Considero paciente con patologías críticas crónicas, quien cuenta con reporte de cultivo de secreción orotraqueal con crecimiento de *Pseudomonas Auruginosa*, sensible a meropenem por lo que continúa con dicho antibiótico. En paraclinicos de hoy llamativo leucocitosis, con cinética incrementando, por lo que en ronda de la tarde se instauró quinolona como sinergismo antibiótico. Paciente en su postoperatorio inmediato, quien presentó sangrado a nivel de sitio de abordaje quirúrgico de traqueostomía que no cedía a medidas compresivas, por lo que se indicó antifibrinolítico y se notificó a servicio de ORL quienes instauraron vendaje compresivo como método hemostático. En ronda de la noche continuamos manejo médico instaurado, vigilancia estricta de parámetros hemodinámicos. Atentos a su evolución.

Seguimiento por los servicios de terapia física crítica, terapia ocupacional, fonoaudiología para rehabilitación temprana y precoz de paciente, terapia respiratoria integral, psicología crítica y trabajo social para reintegro al medio y núcleo familiar, soporte nutricional y metabólico críticos.

Debe permanecer en la unidad de cuidados intensivos por tratarse con requerimiento de ventilación mecánica invasiva, en riesgo de arritmias malignas, muerte súbita; además de necesidad de monitoreo continuo, vigilancia estricta de parámetros hemodinámicos, ventilatorios, neurológicos y metabólicos.

Fecha: 29/03/2022: 11:03:44, **Historia:** Evolución Clínica UCI, **Prestador:** DANIEL ENRIQUE ALVARADO CUETO, **Especialidad:** CUIDADO DEL PACIENTE EN ESTADO CRÍTICO

Análisis:

PARACLINICOS (29/03/2022):

Hemograma: LEU 22,920 NEU 64,2% HB 7,4 HTO 25,3 VCM 100,1 HCM 29,3 PLT 487 TP 11,3/10,4 TPT 30,2/24,8 BUN 89 CREA 6,82 NA 133 K 5,6 CL 97 Gases arteriales: PH 7,44 PO2 112 PCO2 34,3 HCO3 23 PAFI 376 BE -0,8 LACT 1,88 SO2 98%

BIOPSIA: Decorticación: tejido fibroconectivo comprometido por proceso inflamatorio agudo y crónico, zonas de necrosis. Pleura parietal: comprometido por proceso granulomatoso crónico necrotizante compatible con tuberculosis.

ANÁLISIS:

Se trata de femenina en la séptima década de la vida con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, extirpación; con estancia en la unidad de cuidados críticos en marco de insuficiencia respiratoria en paciente en contexto de tuberculosis pleural diagnosticado por biopsia recibiendo esquema rípe; con intervención por servicio de cirugía de tórax: decorticación pulmonar, pleurectomía parietal con

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:20:11 p. m.

Admisión: AD715724

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: SOL BEATRIZ GARCIA MARQUEZ

EPICRISIS

pleurodesis por toracoscopia.

Desde el punto de vista cardiovascular cursó con síndrome coronario tipo anfracto al miocardio actualmente evolucionado; reporta ecocardiograma remodelado concéntrico con FEV conservada 69%, disfunción diastólica tipo I, dilatación auricular izquierda leve, TAPSE 20 mm, sin intervención adicional.

Paciente renal crónica en diálisis peritoneal, con agudización de la misma; valorado por servicio de nefrología quien considera debe continuar con diálisis peritoneales diarias. El día de ayer con ultrafiltrado de 1800 ml.

Desde el punto de vista infeccioso con bacteriemia por *Serratia Marcescens* con reporte de hemocultivo control negativo. Cultivo de secreción orotraqueal con crecimiento de *Enterobacter Cloacae* en cultivo previo y *Pseudomona Aeruginosa* en el nuevo. Recibiendo antibioticoterapia actual con levofloxacino; con cumplimiento de esquema con carbapenémico el cual suspendo.

Paciente en regulares condiciones generales, recibiendo sedoanalgesia con derivado opiáceo y dexmedetomidina en plan destete; bajo soporte ventilatorio invasivo por traqueostomía modo aisto controlado por volumen, con adecuados índices de oxigenación al visoscopio, acoplada; taquicárdica, con cifras tensionales variables, anúrica en paciente renal crónica; con mal control metabólico (glucometrías: 99-327-538 mg/dl), recibiendo soporte nutricional enteral con alimento con propósitos médicos especiales tipo pulmocar 237 ml (aporte proteico en 24 horas: 67.5 g, cálculo a 1.5 g prot/kg/día, 1617 kcalorías totales, volumen total) meta de 45 cc/hora.

Considero paciente con patologías críticas crónicas, ya realizada traqueostomía, el día de hoy en plan de destete de sedoanalgesia y trabajo ventilatorio.

Seguimiento por los servicios de terapia física crítica, terapia ocupacional, fonoaudiología para rehabilitación temprana y precoz de paciente, terapia respiratoria integral, psicología crítica y trabajo social para reintegro al medio y núcleo familiar, soporte nutricional y metabólico críticos.

Debe permanecer en la unidad de cuidados intensivos por tratarse con requerimiento de ventilación mecánica invasiva, en riesgo de arritmias malignas, muerte súbita; además de necesidad de monitoreo continuo, vigilancia estricta de parámetros hemodinámicos, ventilatorios, neurológicos y metabólicos.

Fecha: 29/03/2022: 15:19:00, Historia: Evolución Clínica UCI, Prestador: DANIEL ENRIQUE ALVARADO CUETO, Especialidad: CUIDADO DEL PACIENTE EN ESTADO CRÍTICO

Análisis:

Femenina en la séptima década de la vida con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, extubada, enfermedad renal crónica en terapia de remplazo renal a través de catéter peritoneal; que ingresa inicialmente a la unidad debido a falla ventilatoria aguda en relación a derrame pleural masivo que ameritó aseguramiento de la vía aérea, con estudio de líquido pleural con reporte de exudado linfocitario con ADA positivo, por lo que ante alta posibilidad de tuberculosis pleural recibía terapia antifúngica, fue llevada a intervención quirúrgica por el servicio de cirugía de tórax, el día 09/03/22 donde realizaron decorticación pulmonar + pleurectomía parietal + toma de biopsia + pleurodesis por toracoscopia, con reporte de biopsia de decorticación que evidencia tejido fibroconectivo comprometido por proceso inflamatorio agudo y crónico, zonas de necrosis y de pleura parietal que evidencia compromiso de proceso granulomatoso crónico necrotizante compatible con tuberculosis. Durante su curso en la unidad, su proceso se ve entorpecido por deterioro neurológico marcado en relación a uremia producto de agudización de enfermedad renal, que ameritó reintubación y ajuste de TRR peritoneal diarias, además cursó con síndrome coronario agudo tipo infarto agudo al miocardio sin elevación del ST, concomitante con choque séptico requirente de soporte vasoaditivo, ya destetado. Además cursó con bacteriemia por *Serratia Marcescens* multisensible, con hemocultivo control negativo y foco pulmonar con cultivo de secreción traqueal con crecimiento de *Enterobacter Cloacae* multisensible/último del 21/03/22 con *Pseudomonas aeruginosa* multidrogorresistente recibiendo cobertura antibiótica con quinolón de acuerdo a perfil de sensibilidad. Actualmente en su postoperatorio inmediato de traqueostomía vía abierta, procedimiento realizado por servicio de ORL el 28/03/22, sin ninguna complicación intraquirúrgica documentada. De momento se encuentra en regulares condiciones generales, bajo ventilación mecánica, a través de cánula de traqueostomía, modo AC/V alterando con bilevel como método de trabajo ventilatorio paulatino, conservando adecuados índices de oxigenación al visoscopio, buen acople, facilitado por sedoanalgesia con derivado del opiáceo tipo fentanyl + dexmedetomidina, RASS 0; afebril, a nivel hemodinámico taquicárdica y cifras tensionales en metas sin requerimiento de soporte vasoaditivo, anúrica en paciente renal crónica en terapia de remplazo renal peritoneal, con agudización de la misma; realizándose sesiones diarias por servicio de nefrología, con cinética de azoados en descenso; recibiendo soporte nutricional enteral con alimento con propósitos médicos especiales tipo tipo ensure clinical frasco 220 ml (aporte proteico 67.5 gr en 24 horas, cálculo a 1.5 gr/kg/día, aporte calórico 1114 kcal/día, cálculo a 25 kcal/kg/día, volumen total 742.5 ml), meta de 31 cc/hora, recibiendo esquema de insulina basal, con control metabólico irregular. Considero paciente con patologías críticas crónicas, ya realizada traqueostomía, el día de hoy en plan de destete de sedoanalgesia y trabajo ventilatorio, por lo que se disminuye dosis de fentanyl y alternancia ventilatoria modo controlado con duales. Debe permanecer en la unidad de cuidados intensivos por tratarse con requerimiento de ventilación mecánica invasiva, en riesgo de arritmias malignas, muerte súbita; además de necesidad de monitoreo continuo, vigilancia estricta de parámetros hemodinámicos, ventilatorios, neurológicos y metabólicos. Seguimiento multidisciplinario de UCI.

Fecha: 29/03/2022: 16:25:12, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: EDGARD EDUARDO GUTIERREZ PUENTE, Especialidad: CIRUGIA DEL TORAX

Problema:

1. Tb pleural.

Subjetivo:

Pte bajo VMI por traqueostomía

Objetivo:

Paciente en malas condiciones generales, Bajo traqueostomía y sedoanalgesia RASS 0, hidratada, sin soporte vasoaditivo. Cuello simétrico, móvil sin adenopatías regionales. Murmullo vesicular disminuido en ambos campos pulmonares, sin sobreagregados. Abdomen globoso, sin masas palpables, catéter de diálisis implantado sin signos de infección y funcional. PATOLOGÍA Necrosis compatible con TBC

Análisis:

Paciente en regulares condiciones generales, con fallo de extubación, con plan de extubación pero por somnolencia no ha sido posible. En el momento por nuestra especialidad, Se retiró traqueostomía sin complicaciones. Continuamos seguimiento hasta lograr estabilización por parte de cuidado de crítico. Por ahora sin requerimiento de intervención quirúrgica por nuestra especialidad.

Fecha: 29/03/2022: 22:47:54, Historia: Evolución Clínica UCI, Prestador: JAIME SARMIENTO CALDERON, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Análisis:

Femenina en la séptima década de la vida con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, extubada, enfermedad renal crónica en terapia de remplazo renal a través de catéter peritoneal; que ingresa inicialmente a la unidad debido a falla ventilatoria aguda en relación a derrame pleural masivo que ameritó aseguramiento de la vía aérea, con estudio de líquido pleural con reporte de exudado linfocitario con ADA positivo, por lo que ante alta posibilidad de tuberculosis pleural recibía terapia antifúngica, fue llevada a intervención quirúrgica por el servicio de cirugía de tórax, el día 09/03/22 donde realizaron decorticación pulmonar + pleurectomía parietal + toma de biopsia + pleurodesis por toracoscopia, con reporte de biopsia de decorticación que evidencia tejido fibroconectivo comprometido por proceso inflamatorio agudo y crónico, zonas de necrosis y de pleura parietal que evidencia compromiso de proceso granulomatoso crónico necrotizante compatible con tuberculosis. Durante su curso en la unidad, su proceso se ve entorpecido por deterioro neurológico marcado en relación a uremia producto de agudización de enfermedad renal, que ameritó reintubación y ajuste de TRR peritoneal

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:20:11 p. m.

Admisión: AD715724

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: SOL BEATRIZ GARCIA MARQUEZ

EPICRISIS

diarias, además cursó con síndrome coronario agudo tipo infarto agudo al miocardio sin elevación del ST, concomitante con choque séptico requirente de soporte vasoactivo, ya destetado. Además cursó con bacteriemia por *Serratia Marcescens* multisensible, con hemocultivo control negativo y foco pulmonar con cultivo de secreción traqueal con crecimiento de *Enterobacter Cloacae* multisensible/último del 21/03/22 con *Pseudomonas aeruginosa* multidrogorresistente recibiendo cobertura antibiótica con quinolóna de acuerdo a perfil de sensibilidad. Actualmente en su postoperatorio inmediato de traqueostomía vía abierta, procedimiento realizado por servicio de ORL el 28/03/22, sin ninguna complicación intraquirúrgica documentada.

De momento se encuentra en regulares condiciones generales, bajo ventilación mecánica, a través de cánula de traqueostomía, modo AC/V alterando con bilevel como método de trabajo ventilatorio paulatino, conservando adecuados índices de oxigenación al visoscopio, buen acople, facilitado por sedoanalgesia con derivado del opiáceo tipo fentanyl + dexmedetomidina, RASS 0; afebril, a nivel hemodinámico taquicárdica y cifras tensionales en metas sin requerimiento de soporte vasoactivo, anúrica en paciente renal crónica en terapia de reemplazo renal peritoneal, con agudización de la misma; realizándose sesiones diarias por servicio de nefrología, con cinética de azoados en descenso; recibiendo soporte nutricional enteral con alimento con propósitos médicos especiales tipo tipo ensure clinical frasco 220 ml (aporte proteico 67.5 gr en 24 horas, cálculo a 1.5 gr/kg/día, aporte calórico 1114 kcal/día, cálculo a 25 kcal/kg/día, volumen total 742.5 ml), meta de 31 cc/hora, recibiendo esquema de insulina basal, con control metabólico irregular.

Considero paciente con patologías críticas crónicas, ya realizada traqueostomía, el día de hoy en plan de destete de sedoanalgesia y trabajo ventilatorio, alternancia ventilatoria modo controlado con duales.

Debe permanecer en la unidad de cuidados intensivos por tratarse con requerimiento de ventilación mecánica invasiva, en riesgo de arritmias malignas, muerte súbita; además de necesidad de monitoreo continuo, vigilancia estricta de parámetros hemodinámicos, ventilatorios, neurológicos y metabólicos. Seguimiento multidisciplinario de UCI.

Fecha: 30/03/2022: 10:18:37, Historia: Evolucion Clinica UCI, Prestador: DANIEL ENRIQUE ALVARADO CUETO, Especialidad: CUIDADO DEL PACIENTE EN ESTADO CRITICO

Análisis:

PARACLINICOS (30/03/2022):

Hemograma: LEU 19,980 NEU 84,3% HB 7,6 HTO 26,7 VCM 100,8 HCM 28,7 PLT 511 BUN 89 CREA 6,54 NA 134 K 5,0 CL 97

Gases arteriales: PH 7,43 PO2 96 PCO2 40 HCO3 26 PAFI 321 BE 1,7 LACT 1,4 SO2 97,5%

BIOPSIA: Decorticación: tejido fibroconectivo comprometido por proceso inflamatorio agudo y crónico, zonas de necrosis. Pleura parietal: comprometido por proceso granulomatoso crónico necrotizante compatible con tuberculosis.

ANÁLISIS:

Se trata de femenina en la séptima década de la vida con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, extabaquista; con estancia en la unidad de cuidados crítico en marco de insuficiencia respiratoria en paciente en contexto de tuberculosis pleural diagnosticado por biopsia recibiendo esquema ripe; con intervención por servicio de cirugía de tórax: decorticación pulmonar, pleurectomía parietal con pleurodesis por toracoscopia.

Desde el punto de vista cardiovascular cursó con síndrome coronario tipo infarto al miocardio actualmente evolucionado; reporta ecocardiograma remodelado concéntrico con FEVI conservada 69%, disfunción diastólica tipo I, dilatación auricular izquierda leve, TAPSE 20 mm, sin intervención adicional.

Paciente renal crónica en diálisis peritoneal, con agudización de la misma; valorado por servicio de nefrología quien considera debe continuar con diálisis peritoneales diarias, actualmente conectada.

Desde el punto de vista infeccioso con bacteriemia por *Serratia Marcescens* con reporte de hemocultivo control negativo. Cultivo de secreción orotraqueal con crecimiento de *Enterobacter Cloacae* en cultivo previo y *Pseudomonas Aeruginosa* en el nuevo. Recibiendo antibióticoterapia actual con levofloxacino hoy en su día 2.

Paciente en regulares condiciones generales, en destete de sedoanalgesia, actualmente solo recibiendo dexmedetomidina; bajo soporte ventilatorio invasivo por traqueostomía modo aiso controlado por volumen en aras de destete según tolerancia, con adecuados índices de oxigenación al visoscopio, acoplada; persiste taquicárdica sinusal, con cifras tensionales variables, anúrica en paciente renal crónica; con mal control metabólico (glucometrías: 150-480-119 mg/dl), recibiendo soporte nutricional enteral con alimento con propósitos médicos especiales tipo pulmocare 237 ml (aporte proteico en 24 horas: 67.5 g, cálculo a 1.5 g prot/kg/día, 1617 calorías totales, volumen total) meta de 45 cc/hora.

Considero paciente con patologías críticas crónicas, ya realizada traqueostomía, continua en plan de destete de sedoanalgesia y trabajo ventilatorio.

Seguimiento por los servicios de terapia física crítica, terapia ocupacional, fonoaudiología para rehabilitación temprana y precoz de paciente, terapia respiratoria integral, psicología crítica y trabajo social para reintegro al medio y núcleo familiar, soporte nutricional y metabólico críticos.

Debe permanecer en la unidad de cuidados intensivos por tratarse con requerimiento de ventilación mecánica invasiva, en riesgo de arritmias malignas, muerte súbita; además de necesidad de monitoreo continuo, vigilancia estricta de parámetros hemodinámicos, ventilatorios, neurológicos y metabólicos.

Fecha: 30/03/2022: 15:32:18, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: EDGARD EDUARDO GUTIERREZ PUENTE, Especialidad: CIRUGIA DEL TORAX

Problema:

1. Tb pleural.

Subjetivo:

Pte bajo VMI por traqueostomía

Objetivo:

Paciente en malas condiciones generales, Bajo traqueostomía y sedoanalgesia RASS 0, hidratada, sin soporte vasoactivo. Cuello simétrico, móvil sin adenopatías regionales. Murmullo vesicular disminuido en ambos campos pulmonares, sin sobreagregados. Abdomen globoso, sin masas palpables, catéter de diálisis implantado sin signos de infección y funcional. PATOLOGIA Necrosis compatible con TBC

Análisis:

Paciente en regulares condiciones generales, con fallo de extubación, con plan de extubación pero por somnolencia no fue posible. En el momento por nuestra especialidad. Continuamos seguimiento hasta lograr estabilización por parte de cuidado de crítico. Por ahora sin requerimiento de intervención quirúrgica por nuestra especialidad.

Fecha: 30/03/2022: 15:37:00, Historia: Evolucion Clinica UCI, Prestador: LUIS CARLOS JULIO NARVAEZ, Especialidad: CUIDADO DEL PACIENTE EN ESTADO CRITICO

Análisis:

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:20:11 p. m.

Admisión: AD715724

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: SOL BEATRIZ GARCIA MARQUEZ

EPICRISIS

Femenina en la séptima década de la vida con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, extabaquista, enfermedad renal crónica en terapia de remplazo renal a través de cateter peritoneal; que ingresa inicialmente a la unidad debido a falla ventilatoria aguda en relación a derrame pleural masivo que ameritó aseguramiento de la vía aérea, con estudio de liquido pleural con reporte de exudado linfocitario con ada positivo, por lo que ante alta posibilidad de tuberculosis pleural recibía terapia antifimica, fue llevada a intervención quirúrgica por el servicio de cirugía de tórax, el día 09/03/22 donde realizaron decorticación pulmonar + pleurectomía parietal + toma de biopsia + pleurodesis por toracosopia, con reporte de biopsia de decorticación que evidencia tejido fibroconectivo comprometido por proceso inflamatorio agudo y crónico, zonas de necrosis y de pleura parietal que evidencia compromiso de proceso granulomatoso crónico necrotizante compatible con tuberculosis. Durante su curso en la unidad, su proceso se ve entorpecido por detrimento neurologico marcado en relación a uremia producto de agudización de enfermedad renal, que ameritó reintubación y ajuste de TRR peritoneal diarias, ademas cursó con síndrome coronario agudo tipo infarto agudo al miocardio sin elevación del ST, concomitante con choque séptico requirente de soporte vasoactivo, ya destetado. Además cursó con bacteriemia por Serratia Marcescens multisensible, con hemocultivo control negativo y foco pulmonar con cultivo de secreción traqueal con crecimiento de enterobacter Cloacae multisensible/último del 21/03/22 con Pseudomonas aeruginosa multidrogoresistente recibiendo cobertura antibiotica con quinolóna de acuerdo a perfil de sensibilidad. Actualmente en su postoperatorio inmediato de traqueostomía vía abierta, procedimiento realizado por servicio de ORL el 28/03/22, sin ninguna complicación intraquirúrgica documentada. De momento se encuentra en regulares condiciones generales, bajo ventilación mecánica, a través de cánula de traqueostomía, modo AC/V alterando con bilevel como método de trabajo ventilatorio paulatino, conservando adecuados índices de oxigenación al visoscopio, buen acople, facilitado por sedoanalgesia con dexmedetomidina, a dosis bajas (0.2 mcg/kg/h), RASS 0; afebril, a nivel hemodinámico taquicardia y cifras tensionales en metas sin requerimiento de soporte vasoactivo, anúrica en paciente renal crónica en terapia de reemplazo renal peritoneal, con agudización de la misma; realizandose sesiones diarias por servicio de nefrología, con cinética de azúados en descenso; recibiendo soporte nutricional enteral con alimento con propósitos médicos especiales tipo tipo ensure clinical frasco 220 ml (aporte proteico 67.5 gr en 24 horas, cálculo a 1.5 gr/kg/día, aporte calórico 1114 kcal/día, cálculo a 25 kcal/kg/día, volumen total 742.5 ml), meta de 31 cc/hora, recibiendo esquema de insulina basal. Considero paciente con patologías críticas crónicas, ya realizada traqueostomía, continua en plan de trabajo ventilatorio, alternancia ventilatoria modo controlado con duales, además en plan de prueba de vía oral. Debe permanecer en la unidad de cuidados intensivos por tratarse con requerimiento de ventilación mecánica invasiva, en riesgo de arritmias malignas, muerte súbita; además de necesidad de monitoreo continuo, vigilancia estricta de parámetros hemodinámicos, ventilatorios, neurológicos y metabólicos. Seguimiento multidisciplinario de UCI.

Fecha: 30/03/2022: 20:24:31, Historia: Evolucion Clinica UCI, Prestador: ALVARO ANDRES ZAPATA LEAL, Especialidad: CUIDADO DEL PACIENTE EN ESTADO CRITICO

Análisis:

Se trata de femenina en la séptima década de la vida con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, extabaquista; con estancia en la unidad de cuidados crítico en marco de insuficiencia respiratoria en paciente en contexto de tuberculosis pleural diagnosticado por biopsia recibiendo esquema ripe; con intervención por servicio de cirugía de tórax decorticación pulmonar, pleurectomía parietal con pleurodesis por toracosopia. Desde el punto de vista cardiovascular cursó con síndrome coronario tipo infarto al miocardio actualmente evolucionado; reporta ecocardiograma remodelado concéntrico con FEM conservada 69%, disfunción diastólica tipo I, dilatación auricular izquierda leve, TAPSE 20 mm, sin intervención adicional. Paciente cursando con bacteriemia por Serratia Marcescens con reporte de hemocultivo control negativo. Cultivo de secreción orotraqueal con crecimiento de Enterobacter Cloacae en cultivo previo y Pseudomona Aeruginosa en el nuevo. Recibiendo antibiototerapia actual con levofloxacino hoy en su día 2.

Paciente en regulares condiciones generales, en destete de sedoanalgesia, actualmente solo recibiendo dexmedetomidina; bajo soporte ventilatorio invasivo por traqueostomía modo aisto controlado por volumen en aras de destete según tolerancia, con adecuados índices de oxigenación al visoscopio, acoplada; persiste taquicardia sinusal, con cifras tensionales variables, anúrica en paciente renal crónica; con mal control metabólico (glucometrías: 150-480-119 mg/dl), recibiendo soporte nutricional enteral con alimento con propósitos médicos especiales tipo pulmocare 237 ml (aporte proteico en 24 horas: 67.5 g, cálculo a 1.5 g prot/kg/día, 1617 calorías totales, volumen total) meta de 45 cc/hora.

Considero paciente con patologías críticas crónicas, ya realizada traqueostomía, continua en plan de destete de sedoanalgesia y trabajo ventilatorio. Paciente renal crónica en diálisis peritoneal, con agudización de la misma; valorado por servicio de nefrología quien considera debe continuar con diálisis peritoneales diarias, actualmente conectada.

Seguimiento por los servicios de terapia física crítica, terapia ocupacional, fonoaudiología para rehabilitación temprana y precoz de paciente, terapia respiratoria integral, psicología crítica y trabajo social para reintegro al medio y núcleo familiar, soporte nutricional y metabólico críticos.

Debe permanecer en la unidad de cuidados intensivos por tratarse con requerimiento de ventilación mecánica invasiva, en riesgo de arritmias malignas, muerte súbita; además de necesidad de monitoreo continuo, vigilancia estricta de parámetros hemodinámicos, ventilatorios, neurológicos y metabólicos.

Fecha: 31/03/2022: 10:16:26, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: EDGARD EDUARDO GUTIERREZ PUENTE, Especialidad: CIRUGIA DEL TORAX

Problema:

1. Tb pleural.

Subjetivo:

Pte. bajo VM por traqueostomía. Enfermería reporta paciente mas despierta y mas activa.

Objetivo:

Paciente en Regulares condiciones generales, Bajo VM por traqueostomía y sedoanalgesia RASS 0, hidratada, sin soporte vasoactivo. Cuello simétrico, móvil sin adenopatías regionales. Murmullo vesicular disminuido en ambos campos pulmonares, sin sobreagregados. Abdomen globoso, sin masas palpables, catéter de diálisis implantado sin signos de infección y funcional. PATOLOGIA Necrosis compatible con TBC

Análisis:

Paciente en regulares condiciones generales, con fallo de extubación, que requirió traqueostomía, ahora en proceso de reclutamiento pulmonar y ejercicios de reacondicionamiento muscular, por lo cual cuidado crítico inicia tramite para hostal. Por nuestra especialidad, quedamos atentos a evolucion, Sin requerimiento de manejo quirúrgico. Se explica.

Fecha: 31/03/2022: 10:17:55, Historia: Evolucion Clinica UCI, Prestador: DANIEL ENRIQUE ALVARADO CUETO, Especialidad: CUIDADO DEL PACIENTE EN ESTADO CRITICO

Análisis:

Se trata de femenina en la séptima década de la vida con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, extabaquista; con estancia en la unidad de cuidados crítico en marco de insuficiencia respiratoria en paciente en contexto de tuberculosis pleural diagnosticado por biopsia recibiendo esquema ripe; con intervención por servicio de cirugía de tórax decorticación pulmonar, pleurectomía parietal con pleurodesis por toracosopia.

Desde el punto de vista cardiovascular cursó con síndrome coronario tipo infarto al miocardio actualmente evolucionado; reporta ecocardiograma remodelado concéntrico con FEM conservada 69%, disfunción diastólica tipo I, dilatación auricular izquierda leve, TAPSE 20 mm, sin intervención adicional.

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:20:11 p. m.

Admisión: AD715724

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: SOL BEATRIZ GARCIA MARQUEZ

EPICRISIS

Paciente renal crónica en diálisis peritoneal, con agudización de la misma; valorado por servicio de nefrología quien considera debe continuar con diálisis peritoneales diarias, última realizada con ultrafiltrado de 1750 ml.

Desde el punto de vista infeccioso con bacteriemia por *Serratia Marcescens* con reporte de hemocultivo control negativo. Cultivo de secreción orotraqueal con crecimiento de *Enterobacter Cloacae* en cultivo previo y *Pseudomona Aeruginosa* en el nuevo. Recibiendo antibioterapia actual con levofloxacino hoy en su día 3.

Paciente en regulares condiciones generales, actualmente sin sedolagesa en plan de evaluación neurológica y trabajo ventilatorio progresivo, continua bajo soporte ventilatorio invasivo por traqueostomía modo aisto controlado por volumen en aras de destete según tolerancia, con adecuados índices de oxigenación al visocopio, acoplada; persiste taquicardia sinusal, con cifras tensionales en meta, anúrica en paciente renal crónica; con mal control metabólico (glucometrías: 256-232-133mg/dl) requiriendo esquema de corrección y ajustes; pasando soporte nutricional enteral con alimento con propósitos médicos especiales tipo pulmocar 237 ml (aporte proteico en 24 horas: 67.5 g, cálculo a 1.5 g prot/kg/día, 1617 kcalorías totales, volumen total) meta de 45 cc/hora por sonda enteral en plan de prueba de vía oral el día de hoy, atentos.

Considero paciente con patologías críticas crónicas, ya realizada traqueostomía, continua en plan de trabajo ventilatorio.

Seguimiento por los servicios de terapia física crítica, terapia ocupacional, fonoaudiología para rehabilitación temprana y precoz de paciente, terapia respiratoria integral, psicología crítica y trabajo social para reintegro al medio y núcleo familiar, soporte nutricional y metabólico críticos.

Debe permanecer en la unidad de cuidados intensivos por tratarse con requerimiento de ventilación mecánica invasiva, en riesgo de arritmias malignas, muerte súbita; además de necesidad de monitoreo continuo, vigilancia estricta de parámetros hemodinámicos, ventilatorios, neurológicos y metabólicos.

Fecha: 31/03/2022: 16:02:31, Historia: Evolucion Clinica UCI, Prestador: LUIS CARLOS JULIO NARVAEZ, Especialidad: CUIDADO DEL PACIENTE EN ESTADO CRITICO

Análisis:

Femenina en la séptima década de la vida con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, estibaquista, enfermedad renal crónica en terapia de remplazo renal a través de cateter peritoneal; que ingresa inicialmente a la unidad debido a falla ventilatoria aguda en relación a derrame pleural masivo que ameritó aseguramiento de la vía aérea, con estudio de liquido pleural con reporte de exudado linfocitario con ada positivo, por lo que ante alta posibilidad de tuberculosis pleural recibía terapia antifimica, fue llevada a intervención quirúrgica por el servicio de cirugía de tórax, el día 09/03/22 donde realizaron decorticación pulmonar + pleurectomía parietal + toma de biopsia + pleurodesis por toracosopia, con reporte de biopsia de decorticación que evidencia tejido fibroconectivo comprometido por proceso inflamatorio agudo y crónico, zonas de necrosis y de pleura parietal que evidencia compromiso de proceso granulomatoso crónico necrotizante compatible con tuberculosis. Durante su curso en la unidad, su proceso se ve entorpecido por detrimento neurologico marcado en relación a uremia producto de agudización de enfermedad renal, que ameritó reintubación y ajuste de TRR peritoneal diarias, ademas cursó con síndrome coronario agudo tipo infarto agudo al miocardio sin elevación del ST, concomitante con choque séptico requirente de soporte vasoactivo, ya destetado. Además cursó con bacteriemia por *Serratia Marcescens* multisensible, con hemocultivo control negativo y foco pulmonar con cultivo de secreción traqueal con crecimiento de *enterobacter Cloacae* multisensible/último del 21/03/22 con *Pseudomonas auruginosa* multidrogoresistente recibiendo cobertura antibiotica con quinolóna de acuerdo a perfil de sensibilidad. Actualmente en su postoperatorio inmediato de taqueostomia via abierta, procedimiento realizado por servicio de ORL el 28/03/22, sin ninguna complicación intraquirurgica documentada. De momento se encuentra en regulares condiciones generales, bajo ventilación ventilación mecánica, através de cánula de traqueostomia, modo AC/V alterando con bilevel como método de trabajo ventilatorio paulatino, conservando adecuados índices de oxigenación al visocopio, sin uso de sedantes, a nivel neurologico alertable, sigue ordenes sencillas; a nivel hemodinamico taquicardia y cifras tensionales con tendencia a la hipertensión sin soporte con vasoactivo, anúrica en paciente renal crónica en terapia de reemplazo renal peritoneal, con agudización de la misma; realizandose sesiones diarias por servicio de nefrología, con cinética de azados en descenso; recibiendo soporte nutricional enteral con alimento con propósitos médicos especiales tipo tipo ensure clinical frasco 220 ml (aporte proteico 67.5 gr en 24 horas, cálculo a 1.5 gr/kg/día, aporte calórico 1114 kcal/día, cálculo a 25 kcal/kg/día, volumen total 742.5 ml), meta de 31 cc/hora, recibiendo esquema de insulina basal, con buen control metabólico en las últimas horas, afebril. Considero paciente con patologías críticas crónicas, ya realizada traqueostomía, continua en plan de trabajo ventilatorio, alternancia ventilatoria modo controlado con duales, además en plan de prueba de vía oral. En ronda médica decido instaurar manejo con antihipertensivo antagonista de los canales de calcio considerando ademas su efecto cronotropo negativo, en aras lograr control de frecuencia cardiaca y cifras tensionales, no realizo más cambios en manejo previamente instuarado. Debe permanecer en la unidad de cuidados intensivos por tratarse con requerimiento de ventilación mecánica invasiva a través de cánula de tra, en riesgo de arritmias malignas, muerte súbita; además de necesidad de monitoreo continuo, vigilancia estricta de parámetros hemodinámicos, ventilatorios, neurológicos y metabólicos. Seguimiento multidisciplinario de UCI.

Fecha: 31/03/2022: 19:59:31, Historia: Evolucion Clinica UCI, Prestador: FELIPE HERRERARUIZ, Especialidad: CUIDADO DEL PACIENTE EN ESTADO CRITICO

Análisis:

Paciente en la séptima década de la vida con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, estibaquista, enfermedad renal crónica en terapia de remplazo renal a través de cateter peritoneal; que ingresa inicialmente a la unidad debido a falla ventilatoria aguda en relación a derrame pleural masivo que ameritó aseguramiento de la vía aérea, con estudio de liquido pleural con reporte de exudado linfocitario con ada positivo, por lo que ante alta posibilidad de tuberculosis pleural recibía terapia antifimica, fue llevada a intervención quirúrgica por el servicio de cirugía de tórax, el día 09/03/22 donde realizaron decorticación pulmonar + pleurectomía parietal + toma de biopsia + pleurodesis por toracosopia, con reporte de biopsia de decorticación que evidencia tejido fibroconectivo comprometido por proceso inflamatorio agudo y crónico, zonas de necrosis y de pleura parietal que evidencia compromiso de proceso granulomatoso crónico necrotizante compatible con tuberculosis.

Durante su curso en la unidad, su proceso se ve entorpecido por detrimento neurologico marcado en relación a uremia producto de agudización de enfermedad renal, que ameritó reintubación y ajuste de TRR peritoneal diarias, ademas cursó con síndrome coronario agudo tipo infarto agudo al miocardio sin elevación del ST, concomitante con choque séptico requirente de soporte vasoactivo, ya destetado. Además cursó con bacteriemia por *Serratia Marcescens* multisensible, con hemocultivo control negativo y foco pulmonar con cultivo de secreción traqueal con crecimiento de *enterobacter Cloacae* multisensible/último del 21/03/22 con *Pseudomonas auruginosa* multidrogoresistente recibiendo cobertura antibiotica con quinolóna de acuerdo a perfil de sensibilidad. Actualmente en su postoperatorio inmediato de taqueostomia via abierta, procedimiento realizado por servicio de ORL el 28/03/22, sin ninguna complicación intraquirurgica documentada.

Actualmente en regulares condiciones generales, bajo ventilación ventilación mecánica, através de cánula de traqueostomia, modo AC/V alterando con bilevel como método de trabajo ventilatorio paulatino, conservando adecuados índices de oxigenación al visocopio, sin uso de sedantes, a nivel neurologico alertable, sigue ordenes sencillas; a nivel hemodinamico taquicardia y cifras tensionales con tendencia a la hipertensión sin soporte con vasoactivo, anúrica en paciente renal crónica en terapia de reemplazo renal peritoneal, con agudización de la misma; realizandose sesiones diarias por servicio de nefrología, con cinética de azados en descenso; recibiendo soporte nutricional enteral con alimento con propósitos médicos especiales tipo tipo ensure clinical, recibiendo esquema de insulina basal, con buen control metabólico en las últimas horas, afebril.

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:20:11 p. m.

Admisión: AD715724

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: SOL BEATRIZ GARCIA MARQUEZ

EPICRISIS

Paciente quien continua en plan de trabajo ventilatorio, alternancia ventilatoria modo controlado con duales, además en plan de prueba de vía oral. El día de hoy con reajuste de manejo con antihipertensivo antagonista de los canales de calcio considerando además su efecto cronotrope negativo, en aras lograr control de frecuencia cardíaca y cifras tensionales.

Debe permanecer en la unidad de cuidados intensivos por tratarse con requerimiento de ventilación mecánica invasiva a través de cánula de tra, en riesgo de arritmias malignas, muerte súbita; además de necesidad de monitoreo continuo, vigilancia estricta de parámetros hemodinámicos, ventilatorios, neurológicos y metabólicos. Seguimiento multidisciplinario de UCI.

Fecha: 01/04/2022: 12:05:02, **Historia:** Evolucion Clinica UCI, **Prestador:** DANIEL ENRIQUE ALVARADO CUETO, **Especialidad:** CUIDADO DEL PACIENTE EN ESTADO CRITICO

Análisis:

Se trata de femenina en la séptima década de la vida con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, extabaquista; con estancia en la unidad de cuidados crítico en marco de insuficiencia respiratoria en paciente en contexto de tuberculosis pleural diagnosticado por biopsia recibiendo esquema ripe; con intervención por servicio de cirugía de tórax: decorticación pulmonar, pleurectomía parietal con pleurodesis por toracoscopia.

Desde el punto de vista cardiovascular cursó con síndrome coronario tipo infarto al miocardio actualmente evolucionado; reporta ecocardiograma remodelado concéntrico con FEVI conservada 69%, disfunción diastólica tipo I, dilatación auricular izquierda leve, TAPSE 20 mm, sin intervención adicional.

Paciente renal crónica en diálisis peritoneal, con agudización de la misma; valorado por servicio de nefrología quien considera debe continuar con diálisis peritoneales diarias, última realizada con ultrafiltrado de 1750 ml.

Desde el punto de vista infeccioso con bacteriemia por *Serratia Marcescens* con reporte de hemocultivo control negativo. Cultivo de secreción orotraqueal con crecimiento de *Enterobacter Cloacae* en cultivo previo y *Pseudomona Aeruginosa* en el nuevo. Recibiendo antibióticoterapia actual con levofloxacino hoy en su día 4.

Paciente en regulares condiciones generales, actualmente sin sedolagesa en plan de evaluación neurológica y trabajo ventilatorio progresivo, continua bajo soporte ventilatorio invasivo por traqueostomía modo aisto controlado por volumen en aras de destete según tolerancia, con adecuados índices de oxigenación al visoscopia, acoplada; persiste taquicardica sinusal, con cifras tensionales en meta, anúrica en paciente renal crónica; con mal control metabólico (glucemias: 248-65-177 mg/dl) requiriendo esquema de corrección y ajustes; pasando soporte nutricional enteral con alimento con propósitos médicos especiales tipo pulmocare 237 ml (aporte proteico en 24 horas: 67.5 g, cálculo a 1.5 g prot/kg/día, 1617 kcalorías totales, volumen total) meta de 45 cc/hora pro sonda enteral en plan de prueba de vía oral el día de hoy, atentos.

Considero paciente con patologías críticas crónicas, ya realizada traqueostomía, continua en plan de trabajo ventilatorio.

Seguimiento por los servicios de terapia física crítica, terapia ocupacional, fonoaudiología para rehabilitación temprana y precoz de paciente, terapia respiratoria integral, psicología crítica y trabajo social para reintegro al medio y núcleo familiar, soporte nutricional y metabólico críticos.

Debe permanecer en la unidad de cuidados intensivos por tratarse con requerimiento de ventilación mecánica invasiva, en riesgo de arritmias malignas, muerte súbita; además de necesidad de monitoreo continuo, vigilancia estricta de parámetros hemodinámicos, ventilatorios, neurológicos y metabólicos.

Fecha: 01/04/2022: 13:43:44, **Historia:** Evolución Clínica General, **Prestador:** EDGARD EDUARDO GUTIERREZ PUENTE, **Especialidad:** CIRUGIA DEL TORAX

Problema:

1. Tb pleural. 2. VENTILACION MECANICA

Subjetivo:

Pte. bajo VMI por traqueostomía. Enfermería reporta paciente mas despierta y mas activa.

Objetivo:

Paciente en Regulares condiciones generales, Bajo VMNI por traqueostomía y sedoanalgesia RASS 0, hidratada, sin soporte vasoactivo. Cuello simétrico, móvil sin adenopatías regionales. Murmullo vesicular disminuido en ambos campos pulmonares, sin sobreagregados. Abdomen globoso, sin masas palpables, catéter de diálisis implantado sin signos de infección y funcional. **PATOLOGIA** Necrosis compatible con TBC

Análisis(A):

Análisis:

Paciente en regulares condiciones generales, con fallo de extubación, que requirió traqueostomía, ahora en proceso de reclutamiento pulmonar y ejercicios de reacondicionamiento muscular, por lo cual cuidado crítico inicia tramite para hostal. Por nuestra especialidad, quedamos atentos a evolucion, Sin requerimiento de manejo quirurgico. **EN ESTE MOMENTO ESTAMOS A LA ESPERA DE HOSTAL Y REALIZAR GASTROSTOMIA YA QUE LA PACIENTE NO SE PUEDE ALIMENTAR DE MANERA NORMAL**

Fecha: 01/04/2022: 18:02:35, **Historia:** Evolucion Clinica UCI, **Prestador:** DANIEL ENRIQUE ALVARADO CUETO, **Especialidad:** CUIDADO DEL PACIENTE EN ESTADO CRITICO

Análisis:

Femenina en la séptima década de la vida con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, extabaquista, enfermedad renal crónica en terapia de remplazo renal a través de cateter peritoneal; que ingresa inicialmente a la unidad debido a falla ventilatoria aguda en relación a derrame pleural masivo que ameritó aseguramiento de la vía aérea, con estudio de liquido pleural con reporte de exudado linfocitario con ada positivo, por lo que ante alta posibilidad de tuberculosis pleural recibía terapia antifimica, fue llevada a intervención quirúrgica por el servicio de cirugía de tórax, el día 09/03/22 donde realizaron decorticación pulmonar + pleurectomía parietal + toma de biopsia + pleurodesis por toracoscopia, con reporte de biopsia de decorticación que evidencia tejido fibroconectivo comprometido por proceso inflamatorio agudo y crónico, zonas de necrosis y de pleura parietal que evidencia compromiso de proceso granulomatoso crónico necrotizante compatible con tuberculosis. Durante su curso en la unidad, su proceso se ve entorpecido por detrimento neurologico marcado en relación a uremia producto de agudización de enfermedad renal, que ameritó reintubación y ajuste de TRR peritoneal diarias, además cursó con síndrome coronario agudo tipo infarto agudo al miocardio sin elevación del ST, concomitante con choque séptico requirente de soporte vasoactivo, ya destetado. Además cursó con bacteriemia por *Serratia Marcescens* multisensible, con hemocultivo control negativo y foco pulmonar con cultivo de secreción traqueal con crecimiento de *enterobacter Cloacae* multisensible/último del 21/03/22 con *Pseudomonas auruginosa* multidrogorresistente recibiendo cobertura antibiotica con quinolóna de acuerdo a perfil de sensibilidad. Actualmente en su postoperatorio inmediato de taqueostomia via abierta, procedimiento realizado por servicio de ORL el 28/03/22, sin ninguna complicación intraquirurgica documentada. De momento se encuentra en regulares condiciones generales, bajo ventilación ventilación mecánica, a través de cánula de traqueostomía, modo AC/V alterando con bilevel como método de trabajo ventilatorio paulatino, conservando adecuados índices de oxigenación al visoscopia, sin uso de sedantes, a nivel neurologico alertable, sigue ordenes sencillas; a nivel hemodinamico frecuencias cardiacas controladas y cifras tensionales en metas bajo manejo antihipertensivo, anúrica en paciente renal crónica en terapia de reemplazo renal peritoneal, con agudización de la misma; realizandose sesiones diarias por servicio de nefrología, con cinética de azoados en

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:20:11 p. m.

Admisión: AD715724

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: SOL BEATRIZ GARCIA MARQUEZ

EPICRISIS

descenso; recibiendo soporte nutricional enteral con alimento con propósitos médicos especiales tipo tipo ensure clinical frasco 220 ml (aporte proteico 67.5 gr en 24 horas, cálculo a 1.5 gr/kg/día, aporte calórico 1114 kcal/día, cálculo a 25 kcal/kg/día, volumen total 742.5 ml), meta de 31 cc/hora, recibiendo esquema de insulina basal, con buen control metabólico en las últimas horas, afebril. Considero paciente con patologías críticas crónicas, ya realizada traqueostomía, continúa en plan de trabajo ventilatorio, alternancia ventilatoria modo controlado con duales, además en plan de prueba de vía oral. En ronda médica no realizo cambios en manejo previamente instaurado. Debe permanecer en la unidad de cuidados intensivos por tratarse con requerimiento de ventilación mecánica invasiva a través de cánula de tra, en riesgo de arritmias malignas, muerte súbita; además de necesidad de monitoreo continuo, vigilancia estricta de parámetros hemodinámicos, ventilatorios, neurológicos y metabólicos. Seguimiento multidisciplinario de UCI.

Fecha: 01/04/2022: 20:21:19, Historia: Evolucion Clinica UCI, Prestador: JUAN PABLO ORTIZ SALAZAR, Especialidad: CUIDADO DEL PACIENTE EN ESTADO CRITICO

Análisis:

Femenina en la séptima década de la vida con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, extabaquista, enfermedad renal crónica en terapia de remplazo renal a través de cateter peritoneal; que ingresa inicialmente a la unidad debido a falla ventilatoria aguda en relación a derrame pleural masivo que ameritó aseguramiento de la vía aérea, con estudio de liquido pleural con reporte de exudado linfocitario con ada positivo, por lo que ante alta posibilidad de tuberculosis pleural recibía terapia antifimica, fue llevada a intervención quirúrgica por el servicio de cirugía de tórax, el día 09/03/22 donde realizaron decorticación pulmonar + pleurectomía parietal + toma de biopsia + pleurodesis por toracoscopia, con reporte de biopsia de decorticación que evidencia tejido fibroconectivo comprometido por proceso inflamatorio agudo y crónico, zonas de necrosis y de pleura parietal que evidencia compromiso de proceso granulomatoso crónico necrotizante compatible con tuberculosis. Durante su curso en la unidad, su proceso se ve entorpecido por detrimento neurologico marcado en relación a uremia producto de agudización de enfermedad renal, que ameritó reintubación y ajuste de TRR peritoneal diarias, ademas cursó con síndrome coronario agudo tipo infarto agudo al miocardio sin elevación del ST, concomitante con choque séptico requirente de soporte vasoactivo, ya destetado. Además cursó con bacteriemia por Serratia Marcescens multisensible, con hemocultivo control negativo y foco pulmonar con cultivo de secreción traqueal con crecimiento de enterobacter Cloacae multisensible/último del 21/03/22 con Pseudomonas aeruginosa multidrogorresistente recibiendo cobertura antibiotica con quinolóna de acuerdo a perfil de sensibilidad. Actualmente en su postoperatorio inmediato de taqueostomia via abierta, procedimiento realizado por servicio de ORL el 28/03/22, sin ninguna complicación intraquirurgica documentada. De momento se encuentra en regulares condiciones generales, bajo ventilación ventilación mecánica, a través de cánula de traqueostomia, modo AC/V alterando con bilevel como método de trabajo ventilatorio paulatino, conservando adecuados índices de oxigenación al visoscopio, sin uso de sedantes, a nivel neurologico alertable, sigue ordenes sencillas; a nivel hemodinamico frecuencias cardiacas controladas y cifras tensionales en metas bajo manejo antihipertensivo, anúrica en paciente renal crónica en terapia de reemplazo renal peritoneal, con agudización de la misma; realizandose sesiones diarias por servicio de nefrologia, con cinética de azoados en descenso; recibiendo soporte nutricional enteral con alimento con propósitos médicos especiales tipo tipo ensure clinical frasco 220 ml (aporte proteico 67.5 gr en 24 horas, cálculo a 1.5 gr/kg/día, aporte calórico 1114 kcal/día, cálculo a 25 kcal/kg/día, volumen total 742.5 ml), meta de 31 cc/hora, recibiendo esquema de insulina basal, con buen control metabólico en las últimas horas, afebril. Considero paciente con patologías críticas crónicas, ya realizada traqueostomía, continúa en plan de trabajo ventilatorio, alternancia ventilatoria modo controlado con duales, además en plan de prueba de vía oral.

En ronda médica de la noche no realizo cambios en manejo previamente instaurado.

Debe permanecer en la unidad de cuidados intensivos por tratarse con requerimiento de ventilación mecánica invasiva a través de cánula de tra, en riesgo de arritmias malignas, muerte súbita; además de necesidad de monitoreo continuo, vigilancia estricta de parámetros hemodinámicos, ventilatorios, neurológicos y metabólicos. Seguimiento multidisciplinario de UCI.

Fecha: 02/04/2022: 11:28:30, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: ALEXANDER FERNANDO FERNANDEZ ARRIETA, Especialidad: CIRUGIA DEL TORAX

Problema:

1. Tb pleural. 2. VENTILACION MECANICA PROLONGADA

Subjetivo:

Pte. bajo VMI por traqueostomía.

Objetivo:

Paciente en Regulares condiciones generales, Bajo VMNI por traqueostomía y sedoanalgesia RASS 0, hidratada, sin soporte vasoactivo. Cuello simétrico, móvil sin adenopatías regionales. Murmullo vesicular disminuido en ambos campos pulmonares, sin sobreagregados. Abdomen globoso, sin masas palpables, catéter de diálisis implantado sin signos de infección y funcional. PATOLOGIA Necrosis compatible con TBC

Análisis:

Paciente en unidad de cuidados intensivos, bajo soporte ventilatorio mecanico a traves de traqueostomia, no ha sido posible completar el destete ventilatorio, No amerita nuevo manejo por cirugía de torax, está a la espera de tramites para continuar manejo en hostal

Fecha: 02/04/2022: 13:38:17, Historia: Evolucion Clinica UCI, Prestador: FELIPE HERRERA RUIZ, Especialidad: CUIDADO DEL PACIENTE EN ESTADO CRITICO

Análisis:

Laboratorios:

Hb 8 Leu 15.000 Neu 81.6% Plt 443.000

Na 129 K 4.7 Cl 90

BUN 130 Creat 7.47

Gases arteriales pH 7.46 PO2 134 PCO2 32.7 HCO3 23.1 BE -0.3 LACT 1.96 PAFI 447

Femenina en la séptima década de la vida con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, extabaquista, enfermedad renal crónica en terapia de remplazo renal a través de cateter peritoneal; que ingresa inicialmente a la unidad debido a falla ventilatoria aguda en relación a derrame pleural masivo que ameritó aseguramiento de la vía aérea, con estudio de liquido pleural con reporte de exudado linfocitario con ada positivo, por lo que ante alta posibilidad de tuberculosis pleural recibía terapia antifimica, fue llevada a intervención quirúrgica por el servicio de cirugía de tórax, el día 09/03/22 donde realizaron decorticación pulmonar + pleurectomía parietal + toma de biopsia + pleurodesis por toracoscopia, con reporte de biopsia de decorticación que evidencia tejido fibroconectivo comprometido por proceso inflamatorio agudo y crónico, zonas de necrosis y de pleura parietal que evidencia compromiso de proceso granulomatoso crónico necrotizante compatible con tuberculosis. Durante su curso en la unidad, su proceso se ve entorpecido por detrimento neurologico marcado en relación a uremia producto de agudización de enfermedad renal, que ameritó reintubación y ajuste de TRR peritoneal diarias, ademas cursó con síndrome coronario agudo tipo infarto agudo al miocardio sin elevación del ST, concomitante con choque séptico requirente de soporte vasoactivo, ya destetado. Además cursó con bacteriemia por Serratia Marcescens multisensible, con hemocultivo control negativo y foco pulmonar con cultivo de secreción traqueal con crecimiento de enterobacter Cloacae multisensible/último del 21/03/22 con Pseudomonas aeruginosa multidrogorresistente recibiendo cobertura antibiotica con quinolóna de acuerdo a perfil de sensibilidad. Actualmente en su postoperatorio de taqueostomia via abierta, procedimiento realizado por servicio de ORL el 28/03/22, sin ninguna complicación intraquirurgica documentada.

De momento se encuentra en regulares condiciones generales, bajo ventilación ventilación mecánica a través de cánula de traqueostomia, modo AC/V alterando con bilevel como método de trabajo ventilatorio paulatino, conservando adecuados índices de oxigenación al visoscopio, sin uso de sedantes, a nivel neurologico alertable, sigue ordenes sencillas; a nivel hemodinamico frecuencias cardiacas controladas y cifras tensionales en metas bajo manejo antihipertensivo, anúrica en paciente renal crónica en terapia de reemplazo renal peritoneal, con agudización de la misma; realizandose sesiones diarias por servicio de nefrologia, con cinética de azoados en descenso; recibiendo soporte nutricional enteral con alimento con propósitos médicos especiales tipo tipo

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:20:11 p. m.

Admisión: AD715724

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: SOL BEATRIZ GARCIA MARQUEZ

EPICRISIS

ensure clinical frasco 220 ml (aporte proteico 67.5 gr en 24 horas, cálculo a 1.5 gr/kg/día, aporte calórico 1114 kcal/día, cálculo a 25 kcal/kg/día, volumen total 742.5 ml), meta de 31 cc/hora, en manejo con esquema de insulina basal, regular control metabólico en las últimas horas (glucometrías 00:00 horas 439 mg/dl - 06:00 horas 488 mg/dl - 07:00 horas 235 mg/dl), afebril.

Paraclicnicos del día de hoy evidencian leucocitosis a expensas de neutrofilos, anemia moderada sin requerimiento transfusional, plaquetas normales, azoados elevados, hiponatremia moderada, resto de ionograma normal. Gases arteriales con evidencia de alcalosis respiratoria compensada, sin trastorno de la oxigenación.

Considero paciente con patologías críticas crónicas, ya realizada traqueostomía, continua en plan de trabajo ventilatorio, alternancia ventilatoria modo controlado con duales, además en plan de prueba de vía oral. En el momento recibiendo diálisis peritoneal. Dada hiponatremia moderada, se indica inicio de solución salina endovenosa. Seguimos atentos a su evolución.

Debe permanecer en la unidad de cuidados intensivos por tratarse con requerimiento de ventilación mecánica invasiva a través de cánula de traqueostomía, en riesgo de arritmias malignas, muerte súbita; además de necesidad de monitoreo continuo, vigilancia estricta de parámetros hemodinámicos, ventilatorios, neurológicos y metabólicos. Seguimiento multidisciplinario de UCI.

Fecha: 02/04/2022: 21:35:37, Historia: Evolución Clínica UCI, Prestador: JAIME SARMIENTO CALDERON, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Análisis:

Femenina en la séptima década de la vida con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, estabiquista, enfermedad renal crónica en terapia de remplazo renal a través de catéter peritoneal; que ingresa inicialmente a la unidad debido a falla ventilatoria aguda en relación a derrame pleural masivo que ameritó aseguramiento de la vía aérea, con estudio de líquido pleural con reporte de exudado linfocitario con ADA positivo, por lo que ante alta posibilidad de tuberculosis pleural recibía terapia antifúngica, fue llevada a intervención quirúrgica por el servicio de cirugía de tórax, el día 09/03/22 donde realizaron decorticación pulmonar + pleurectomía parietal + toma de biopsia + pleurodesis por toracoscopia, con reporte de biopsia de decorticación que evidencia tejido fibroconectivo comprometido por proceso inflamatorio agudo y crónico, zonas de necrosis y de pleura parietal que evidencia compromiso de proceso granulomatoso crónico necrotizante compatible con tuberculosis. Durante su curso en la unidad, su proceso se ve entorpecido por deterioro neurológico marcado en relación a uremia producto de agudización de enfermedad renal, que ameritó reintubación y ajuste de TRR peritoneal diarias, además cursó con síndrome coronario agudo tipo infarto agudo al miocardio sin elevación del ST, concomitante con choque séptico requirente de soporte vasoaditivo, ya destetado. Además cursó con bacteriemia por *Serratia Marcescens* multisensible, con hemocultivo control negativo y foco pulmonar con cultivo de secreción traqueal con crecimiento de enterobacter *Cloacae* multisensible/último del 21/03/22 con *Pseudomonas auruginosa* multidrogorresistente recibiendo cobertura antibiótica con quinolón de acuerdo a perfil de sensibilidad. Actualmente en su postoperatorio de traqueostomía vía abierta, procedimiento realizado por servicio de ORL el 28/03/22, sin ninguna complicación intraquirúrgica documentada.

En ronda nocturna se encuentra en regulares condiciones generales, bajo ventilación mecánica a través de cánula de traqueostomía, modo AC/V alterando con bilevel como método de trabajo ventilatorio paulatino, conservando adecuados índices de oxigenación al visoscopio, sin uso de sedantes, a nivel neurológico alertable, sigue órdenes sencillas; a nivel hemodinámico frecuencias cardíacas controladas y cifras tensionales en metas bajo manejo antihipertensivo, anúrica en paciente renal crónica en terapia de remplazo renal peritoneal, con agudización de la misma; realizándose sesiones diarias por servicio de nefrología; recibiendo soporte nutricional enteral con alimento con propósitos médicos especiales tipo tipo ensure clinical frasco 220 ml (aporte proteico 67.5 gr en 24 horas, cálculo a 1.5 gr/kg/día, aporte calórico 1114 kcal/día, cálculo a 25 kcal/kg/día, volumen total 742.5 ml), meta de 31 cc/hora, en manejo con esquema de insulina basal, regular control metabólico en las últimas horas dado por hipoglucemias, afebril.

Considero paciente con patologías críticas crónicas, ya realizada traqueostomía, continua en plan de trabajo ventilatorio, alternancia ventilatoria modo controlado con duales, además en plan de prueba de vía oral. El día de hoy recibí diálisis peritoneal sin complicaciones. En ronda médica indico continuar manejo previamente instaurado. Seguimos atentos a su evolución.

Debe permanecer en la unidad de cuidados intensivos por tratarse con requerimiento de ventilación mecánica invasiva a través de cánula de traqueostomía, en riesgo de arritmias malignas, muerte súbita; además de necesidad de monitoreo continuo, vigilancia estricta de parámetros hemodinámicos, ventilatorios, neurológicos y metabólicos. Seguimiento multidisciplinario de UCI.

Fecha: 03/04/2022: 12:43:34, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: ALEXANDER FERNANDO FERNANDEZ ARRIETA, Especialidad: CIRUGIA DEL TORAX

Problema:

1. Tb pleural. 2. VENTILACION MECANICA PROLONGADA

Paciente en unidad de cuidados intensivos, bajo soporte ventilatorio mecánico a través de traqueostomía, no ha sido posible completar el destete ventilatorio, No amerita nuevo manejo por cirugía de tórax, está a la espera de trámites para continuar manejo en hospital

Subjetivo:

Paciente bajo soporte ventilatorio, no interactúa

Objetivo:

Paciente en regulares condiciones generales, Bajo VMNI por traqueostomía y sedoanalgesia RASS 0, hidratada, sin soporte vasoaditivo. Cuello simétrico, móvil sin adenopatías regionales. Murmullo vesicular disminuido en ambos campos pulmonares, sin sobreagregados. Abdomen globoso, sin masas palpables, catéter de diálisis implantado sin signos de infección y funcional. PATOLOGÍA Necrosis compatible con TBC

Análisis:

Paciente en unidad de cuidados intensivos, bajo soporte ventilatorio mecánico a través de traqueostomía, quien se mantiene estacionaria clínicamente, por lo que se decidió traslado a hospital para continuar manejo.

Fecha: 03/04/2022: 15:56:45, Historia: Evolución Clínica UCI, Prestador: WILLIAM YAMITH CASTRO MENDOZA, Especialidad: CIRUGIA GENERAL

Análisis:

Femenina en la séptima década de la vida con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, estabiquista, enfermedad renal crónica en terapia de remplazo renal a través de catéter peritoneal; que ingresa inicialmente a la unidad debido a falla ventilatoria aguda en relación a derrame pleural masivo que ameritó aseguramiento de la vía aérea, con estudio de líquido pleural con reporte de exudado linfocitario con ADA positivo, por lo que ante alta posibilidad de tuberculosis pleural recibía terapia antifúngica, fue llevada a intervención quirúrgica por el servicio de cirugía de tórax, el día 09/03/22 donde realizaron decorticación pulmonar + pleurectomía parietal + toma de biopsia + pleurodesis por toracoscopia, con reporte de biopsia de decorticación que evidencia tejido fibroconectivo comprometido por proceso inflamatorio agudo y crónico, zonas de necrosis y de pleura parietal que evidencia compromiso de proceso granulomatoso crónico necrotizante compatible con tuberculosis. Durante su curso en la unidad, su proceso se ve entorpecido por deterioro neurológico marcado en relación a uremia producto de agudización de enfermedad renal, que ameritó reintubación y ajuste de TRR peritoneal diarias, además cursó con síndrome coronario agudo tipo infarto agudo al miocardio sin elevación del ST, concomitante con choque séptico requirente de soporte vasoaditivo, ya destetado. Además cursó con bacteriemia por *Serratia Marcescens* multisensible, con hemocultivo control negativo y foco pulmonar con cultivo de secreción traqueal con crecimiento de enterobacter *Cloacae* multisensible/último del 21/03/22 con *Pseudomonas auruginosa* multidrogorresistente

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:20:11 p. m.

Admisión: AD715724

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: SOL BEATRIZ GARCIA MARQUEZ

EPICRISIS

recibiendo cobertura antibiotica con quinolón de acuerdo a perfil de sensibilidad. Actualmente en su postoperatorio de taqueostomia via abierta, procedimiento realizado por servicio de ORL el 28/03/22, sin ninguna complicación intraquirurgica documentada.

En ronda se encuentra en regulares condiciones generales, bajo ventilación mecánica a través de cánula de traqueostomia, modo AC/V alterando con bilevel como método de trabajo ventilatorio paulatino, conservando adecuados índices de oxigenación al visoscopio, sin uso de sedantes, a nivel neurologico alertable, sigue ordenes sencillas; a nivel hemodinamico frecuencias cardiacas controladas y cifras tensionales en metas bajo manejo antihipertensivo, anúrica en paciente renal crónica en terapia de reemplazo renal peritoneal, con agudización de la misma; realizandose sesiones diarias por servicio de nefrologia; recibiendo soporte nutricional enteral con alimento con propósitos médicos especiales tipo tipo ensure clinical frasco 220 ml (aporte proteico 67.5 gr en 24 horas, cálculo a 1.5 gr/kg/día, aporte calórico 1114 kcal/día, cálculo a 25 kcal/kg/día, volumen total 742.5 ml), meta de 31 cc/hora, en manejo con esquema de insulina basal, regular control metabólico en las últimas horas dado por hipoglicemias, afebril.

Considero paciente con patologías críticas crónicas, ya realizada traqueostomia, continua en plan de trabajo ventilatorio, alternancia ventilatoria modo controlado con duales, además en plan de prueba de via oral. El día de hoy recibio dialisis peritoneal sin complicaciones. En ronda medica indico continuar manejo previamente instaurado. Seguimos atentos a su evolucion.

Debe permanecer en la unidad de cuidados intensivos por tratarse con requerimiento de ventilación mecánica invasiva a través de cánula de traqueostomia, en riesgo de arritmias malignas, muerte súbita; además de necesidad de monitoreo continuo, vigilancia estricta de parámetros hemodinámicos, ventilatorios, neurológicos y metabólicos. Seguimiento multidisciplinario de UCI.

Fecha: 03/04/2022: 20:37:14, Historia: Evolucion Clinica UCI, Prestador: ALVARO ANDRES ZAPATA LEAL, Especialidad: CUIDADO DEL PACIENTE EN ESTADO CRITICO

Análisis:

Femenina en la séptima década de la vida con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, extabaquista, enfermedad renal crónica en terapia de reemplazo renal a través de cateter peritoneal; que ingresa inicialmente a la unidad debido a falla ventilatoria aguda en relación a derrame pleural masivo que ameritó aseguramiento de la vía aérea, con estudio de liquido pleural con reporte de exudado linfocitario con ada positivo, por lo que ante alta posibilidad de tuberculosis pleural recibia terapia antifimica, fue llevada a intervención quirúrgica por el servicio de cirugía de tórax, el día 09/03/22 donde realizaron decorticación pulmonar + pleurectomia parietal + toma de biopsia + pleurodesis por toracosopia, con reporte de biopsia de decorticación que evidencia tejido fibroconectivo comprometido por proceso inflamatorio agudo y crónico, zonas de necrosis y de pleura parietal que evidencia compromiso de proceso granulomatoso crónico necrotizante compatible con tuberculosis.

Durante su curso en la unidad, su proceso se ve entorpecido por detrimento neurologico marcado en relación a uremia producto de agudización de enfermedad renal, que ameritó reintubación y ajuste de TRR peritoneal diarias, ademas cursó con síndrome coronario agudo tipo infarto agudo al miocardio sin elevación del ST, concomitante con choque séptico requirente de soporte vasoaditivo, ya destetado. Además cursó con bacteriemia por Serratia Marcescens multisensible, con hemocultivo control negativo y foco pulmonar con cultivo de secreción traqueal con crecimiento de enterobacter Cloacae multisensible/último del 21/03/22 con Pseudomonas auruginosa multidrogorresistente recibiendo cobertura antibiotica con quinolón de acuerdo a perfil de sensibilidad. Actualmente en su postoperatorio de taqueostomia via abierta, procedimiento realizado por servicio de ORL el 28/03/22, sin ninguna complicación intraquirurgica documentada.

Actualmente en regulares condiciones generales, a nivel neurologico alertable, sigue ordenes sencillas; bajo ventilación mecánica conservando adecuados índices de oxigenación al visoscopio, sin uso de sedantes; a nivel hemodinamico frecuencias cardiacas controladas y cifras tensionales en metas bajo manejo antihipertensivo, anúrica en paciente renal crónica en terapia de reemplazo renal peritoneal en día de hoy con ultrafiltrado de 3lit, con agudización de la misma; realizandose sesiones diarias por servicio de nefrologia; recibiendo soporte nutricional enteral con alimento con propósitos médicos especiales tipo tipo ensure clinical, en manejo con esquema de insulina basal, regular control metabólico.

Paciente quien continua en plan de trabajo ventilatorio, alternancia ventilatoria modo controlado con duales, además en plan de prueba de via oral. Se considera solicitarparadicos de control para evaluar curso de la enfermedad. Seguimos atentos a su evolucion.

Debe permanecer en la unidad de cuidados intensivos por tratarse con requerimiento de ventilación mecánica invasiva a través de cánula de traqueostomia, en riesgo de arritmias malignas, muerte súbita; además de necesidad de monitoreo continuo, vigilancia estricta de parámetros hemodinámicos, ventilatorios, neurológicos y metabólicos. Seguimiento multidisciplinario de UCI.

Fecha: 04/04/2022: 10:29:26, Historia: Evolucion Clinica UCI, Prestador: DANIEL ENRIQUE ALVARADO CUETO, Especialidad: CUIDADO DEL PACIENTE EN ESTADO CRITICO

Análisis:

PARACLINICOS (04/04/2022):

Hemograma: LEU 18,900 NEU 77,6% HB 6,7 HTO 22,6 VCM 101,3 HCM 30,3 PLT 346 BUN 104 CREA 6,09 NA 131 K 4,1 CL 94

ANÁLISIS:

Se trata de femenina en la séptima década de la vida con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, extabaquista; con estancia en la unidad de cuidados crítico en marco de insuficiencia respiratoria en paciente en contexto de tuberculosis pleural diagnosticado por biopsia recibiendo esquema ripe; con intervención por servicio de cirugía de tórax: decorticación pulmonar, pleurectomia parietal con pleurodesis por toracosopia.

Desde el punto de vista cardiovascular cursó con síndrome coronario tipo anfrato al miocardio actualmente evolucionado; reporta ecocardiograma remodelado concéntrico con FEVI conservada 69%, disfunción diastólica tipo I, dilatación auricular izquierda leve, TAPSE 20 mm, sin intervención adicional.

Paciente renal crónica en diálisis peritoneal, con agudización de la misma; valorado por servicio de nefrologia quien cosnidera debe continuar con dialisis peritoneales diarias, última realizada con ultrafiltrado de 3274 ml.

Desde el punto de vista infeccioso con bacteriemia por Serratia Marcescens con reporte de hemocultivo control negativo. Cultivo de secreción orotraqueal con crecimiento de Enterobacter Cloacae en cultivo previo y Pseudomona Aeruginosa en el nuevo. Recibiendo antibiotico terapia actual con levofloxacin hoy en su último día 7.

Análítica sanguínea del día con persistencia de leucocitosis, afebril, con anemia severa en plan de transfusión de una unidad de gl'bulos rojos empaquetados, plaquetograma en meta, hiperazemia en paciente renal, con trastorno electrolítico tipo hiponatremia.

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:20:11 p. m.

Admisión: AD715724

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: SOL BEATRIZ GARCIA MARQUEZ

EPICRISIS

Paciente en regulares condiciones generales, actualmente sin sedanalgesia en evaluación neurológica y trabajo ventilatorio progresivo, continua bajo soporte ventilatorio invasivo por traqueostomía modo aisto controlado por volumen en aras de destete según tolerancia, con adecuados índices de oxigenación al visoscopio, acoplada; manejando frecuencias cardíacas y cifras tensionales en meta, anúrica en paciente renal crónica; con mal control metabólico (glucometrías: 322-82-59 mg/dl) requiriendo esquema de corrección y ajustes; pasando soporte nutricional enteral con alimento con propósitos médicos especiales tipo pulmocar 237 ml (aporte proteico en 24 horas: 67.5 g, cálculo a 1.5 g prot/kg/día, 1617 kcalorías totales, volumen total) meta de 45 cc/hora.

Considero paciente con patologías críticas crónicas, ya realizada traqueostomía, sin posibilidad de uso de vía oral dado componente neurológico por lo que considero realización de gastrostomía; continua en plan de trabajo ventilatorio.

Seguimiento por los servicios de terapia física crítica, terapia ocupacional, fonoaudiología para rehabilitación temprana y precoz de paciente, terapia respiratoria integral, psicología crítica y trabajo social para reintegro al medio y núcleo familiar, soporte nutricional y metabólico críticos.

Debe permanecer en la unidad de cuidados intensivos por tratarse con requerimiento de ventilación mecánica invasiva, en riesgo de arritmias malignas, muerte súbita; además de necesidad de monitoreo continuo, vigilancia estricta de parámetros hemodinámicos, ventilatorios, neurológicos y metabólicos.

Fecha: 04/04/2022: 16:34:27, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: EDGARD EDUARDO GUTIERREZ PUENTE, Especialidad: CIRUGIA DEL TORAX

Problema:

1. Tb pleural. 2. VENTILACION MECANICA PROLONGADA Paciente en unidad de cuidados intensivos, bajo soporte ventilatorio mecanico a traves de traqueostomía, no ha sido posible completar el destete ventilatorio, No amerita nuevo manejo por cirugia de torax, está a la espera de tramites para continuar manejo en hostal

Subjetivo:

Paciente bajo soporte ventilatorio, no interactua

Objetivo:

Paciente en Regulares condiciones generales, Bajo VMN por traqueostomía y sedoanalgesia RASS 0, hidratada, sin soporte vasoactivo. Cuello simétrico, móvil sin adenopatías regionales. Murmullo vesicular disminuido en ambos campos pulmonares, sin sobreagregados. Abdomen globoso, sin masas palpables, catéter de diálisis implantado sin signos de infección y funcional. PATOLOGIA Necrosis compatible con TBC

Análisis:

Paciete en unidad de cuidados intensivos, bajo soporte ventilatorio mecanico a traves de traqueostomía, SE EXPERA GASTROSTOMA TAMBIEN, quien se mantiene estacionaria clinicamente, por lo que se decidió traslado a hostal para continuar manejo.

Fecha: 04/04/2022: 16:36:56, Historia: Evolucion Clinica UCI, Prestador: LUIS CARLOS JULIO NARVAEZ, Especialidad: CUIDADO DEL PACIENTE EN ESTADO CRITICO

Análisis:

Femenina en la séptima década de la vida con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, exabaquista, enfermedad renal crónica en terapia de remplazo renal a través de cateter peritoneal; que ingresa inicialmente a la unidad debido a falla ventilatoria aguda en relación a derrame pleural masivo que ameritó aseguramiento de la vía aérea, con estudio de liquido pleural con reporte de exudado linfocitario con ada positivo, por lo que ante alta posibilidad de tuberculosis pleural recibía terapia antifimica, fue llevada a intervención quirúrgica por el servicio de cirugía de tórax el día 09/03/22, donde realizaron decorticación pulmonar + pleurectomía parietal + toma de biopsia + pleurodesis por toracosopia, con reporte de biopsia de decorticación que evidencia tejido fibroconectivo comprometido por proceso inflamatorio agudo y crónico, zonas de necrosis y de pleura parietal que evidencia compromiso de proceso granulomatoso crónico necrotizante compatible con tuberculosis. Durante su curso en la unidad, su proceso se ve entorpecido por detrimento neurologico marcado en relación a uremia producto de agudización de enfermedad renal, que ameritó reintubación y ajuste de TRR peritoneal diarias, ademas cursó con síndrome coronario agudo tipo infarto agudo al miocardio sin elevación del ST, concomitante con choque séptico requirente de soporte vasoactivo, ya destetado. Además cursó con bacteriemia por Serratia Marcescens multisensible, con hemocultivo control negativo y foco pulmonar con cultivo de secreción traqueal con crecimiento de enterobacter Cloacae multisensible/último del 21/03/22 con Pseudomonas auruginosa multidrogorresistente recibiendo cobertura antibiotica con quinolóna de acuerdo a perfil de sensibilidad, completando su ultimo día hoy 04/04/22 el esquema propuesto. Actualmente en su postoperatorio de taqueostomía via abierta, procedimiento realizado por servicio de ORL el 28/03/22, sin ninguna complicación intraquirurgica documentada.

De momento se encuentra en regulares condiciones generales, bajo ventilación ventilación mecánica a través de cánula de traqueostomía, modo AC/V alterando con bilevel como método de trabajo ventilatorio paulatino, conservando adecuados índices de oxigenación al visoscopio, sin uso de sedantes, para evolución neurologia; glasgow 10 puntos (AO: 3 RV: 1 RM: 6); a nivel hemodinamico frecuencias cardiacas controladas y cifras tensionales en metas bajo manejo antihipertensivo, anúrica en paciente renal crónica en terapia de reemplazo renal peritoneal, con agudización de la misma; realizandose sesiones diarias por servicio de nefrologia, con cinética de azoados en descenso; recibiendo soporte nutricional enteral con alimento con propósitos médicos especiales tipo tipo ensure clinical frasco 220 ml (aporte proteico 67.5 gr en 24 horas, cálculo a 1.5 gr/kg/día, aporte calórico 1114 kcal/día, cálculo a 25 kcal/kg/día, volumen total 742.5 ml), meta de 31 cc/hora, en manejo con esquema de insulina basal, regular control metabólico en las últimas horas, afebril.

Considero paciente con patologías críticas crónicas, ya realizada traqueostomía, aun con soporte ventilatorio, sin posibilidad de uso de vía oral dado componente neurológico, por lo que se encuentra a la espera de realizacion gastrostomia endoscopia percutánea progmada para el dia de mañana 04/04/22.Considero paciente con requerimiento de cuidados crónicos por lo que activo traslado a hostal con las siguiente órdenes médicas:

ventilación mecánica por traqueostomía

bromuro de ipratropio inhalador aplicar 4 puff cada 6 horas

alimento para propósitos médicos especiales tipo ensure clinical frasco 220 ml (aporte proteico 67.5 gr en 24 horas, cálculo a 1.5 gr/kg/día, aporte calórico 1114 kcal/día, cálculo a 25 kcal/kg/día, volumen total 742.5 ml). meta de 31 cc/hora

terapia ripe (isoniazida rifampicina pirazinamida etambutol) 3 tabletas diarias (fi: 01/03/2022) hasta completar esquema

atorvastatina tab 40 mg por sng cada 24 horas

propranolol tab 40 mg por sng cada 12 horas

clonidina tab 75 mcg por sng cada 12 horas condicionados a cifras de pam

calcitriol tab 0.25 mcg tab por sng cada 24 horas

acido folico tab 1 mg por sng cada 24 horas

eritropoyetina amp, aplicar 2000 u sc interdiaria (lunes, miércoles y viernes)

omeprazol 40 mg iv 24 horas

heparina sodica amp 5000 ui sc cada 12 horas

insulina glargina amp, aplicar 25 u sc cada 24 horas

diálisis peritoneales diarias

programada gastrostomía endoscópica percutpnea para el dia 05/04/22

cuidados propios de enfermería 24 horas al dia

seguimiento por terapia respiratoria, terapia física, fonoaudiología para rehabilitación

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:20:11 p. m.

Admisión: AD715724

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: SOL BEATRIZ GARCIA MARQUEZ

EPICRISIS

seguimiento por médico general, según considere por especialista

Por lo pronto permanecer en la unidad de cuidados intensivos por tratarse con requerimiento de ventilación mecánica invasiva a través de cánula de traqueostomía, en riesgo de arritmias malignas, muerte súbita; además de necesidad de monitoreo continuo, vigilancia estricta de parámetros hemodinámicos, ventilatorios, neurológicos y metabólicos. Seguimiento multidisciplinario de UCI.

Fecha: 04/04/2022: 23:50:20, **Historia:** Evolucion Clinica UCI, **Prestador:** JUAN PABLO ORTIZ SALAZAR, **Especialidad:** CUIDADO DEL PACIENTE EN ESTADO CRITICO

Análisis:

Femenina en la séptima década de la vida con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, extabaquista, enfermedad renal crónica en terapia de remplazo renal a través de cateter peritoneal; que ingresa inicialmente a la unidad debido a falla ventilatoria aguda en relación a derrame pleural masivo que ameritó aseguramiento de la vía aérea, con estudio de liquido pleural con reporte de exudado linfocitario con ada positivo, por lo que ante alta posibilidad de tuberculosis pleural recibía terapia antifimica, fue llevada a intervención quirúrgica por el servicio de cirugía de tórax el día 09/03/22, donde realizaron decorticación pulmonar + pleurectomía parietal + toma de biopsia + pleurodesis por toracosopia, con reporte de biopsia de decorticación que evidencia tejido fibroconectivo comprometido por proceso inflamatorio agudo y crónico, zonas de necrosis y de pleura parietal que evidencia compromiso de proceso granulomatoso crónico necrotizante compatible con tuberculosis. Durante su curso en la unidad, su proceso se ve entorpecido por detrimento neurologico marcado en relación a uremia producto de agudización de enfermedad renal, que ameritó reintubación y ajuste de TRR peritoneal diarias, ademas cursó con síndrome coronario agudo tipo infarto agudo al miocardio sin elevación del ST, concomitante con choque séptico requirente de soporte vasoactivo, ya destetado. Además cursó con bacteriemia por Serratia Marcescens multisensible, con hemocultivo control negativo y foco pulmonar con cultivo de secreción traqueal con crecimiento de enterobacter Cloacae multisensible/último del 21/03/22 con Pseudomonas aeruginosa multidrogorresistente recibiendo cobertura antibiotica con quinolóna de acuerdo a perfil de sensibilidad, completando su ultimo día hoy 04/04/22 el esquema propuesto. Actualmente en su postoperatorio de traqueostomía via abierta, procedimiento realizado por servicio de ORL el 28/03/22, sin ninguna complicación intraquirurgica documentada.

En ronda de la noche se encuentra en regulares condiciones generales, bajo ventilación ventilación mecánica a través de cánula de traqueostomía, modo AC/V alterando con bilevel como método de trabajo ventilatorio paulatino, conservando adecuados índices de oxigenación al visoscopio, sin uso de sedantes, para evolución neurologia; glasgow 10 puntos (AO: 3 RV: 1 RM 6); a nivel hemodinamico frecuencias cardiacas controladas y cifras tensionales en metas bajo manejo antihipertensivo, anúrica en paciente renal crónica en terapia de reemplazo renal peritoneal, con agudización de la misma; realizandose sesiones diarias por servicio de nefrologia, con cinética de azoados en descenso; recibiendo soporte nutricional enteral con alimento con propósitos médicos especiales tipo tipo ensure clinical frasco 220 ml (aporte proteico 67.5 gr en 24 horas, cálculo a 1.5 gr/kg/día, aporte calórico 1114 kcal/día, cálculo a 25 kcal/kg/día, volumen total 742.5 ml), meta de 31 cc/hora, en manejo con esquema de insulina basal, regular control metabólico en las últimas horas, afebril.

Considero paciente con patologías críticas crónicas, ya realizada traqueostomía, aun con soporte ventilatorio, sin posibilidad de uso de vía oral dado componente neurológico, por lo que se encuentra a la espera de realización gastrostomía endoscopia percutánea programada para el día de mañana 04/04/22, debido a lo cual, dado anemia severa, se indica transfusion de hemoderivado y hemograma postransfusional. Paciente con requerimiento de cuidados crónicos por lo que activo traslado a hostal, a la espera de autorización por su eps. En ronda medica se indica continuar manejo medico previamente instaurado. Seguimos atentos a su evolucion.

Por lo pronto permanecer en la unidad de cuidados intensivos por tratarse con requerimiento de ventilación mecánica invasiva a través de cánula de traqueostomía, en riesgo de arritmias malignas, muerte súbita; además de necesidad de monitoreo continuo, vigilancia estricta de parámetros hemodinámicos, ventilatorios, neurológicos y metabólicos. Seguimiento multidisciplinario de UCI.

Fecha: 05/04/2022: 10:43:18, **Historia:** Evolucion Clinica UCI, **Prestador:** DANIEL ENRIQUE ALVARADO CUETO, **Especialidad:** CUIDADO DEL PACIENTE EN ESTADO CRITICO

Análisis:

PARACLINICOS (05/04/2022):

Gases arteriales: PH 7,51 PO2 148 PCO2 30,6 HCO3 24,2 PAFI 495 BE 2,2 LACT 0,69 SO2 99%

ANÁLISIS:

Se trata de femenina en la séptima década de la vida con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, extabaquista; con estancia en la unidad de cuidados crítico en marco de insuficiencia respiratoria en paciente en contexto de tuberculosis pleural diagnosticado por biopsia recibiendo esquema ripe; con intervención por servicio de cirugía de tórax: decorticación pulmonar, pleurectomía parietal con pleurodesis por toracosopia.

Desde el punto de vista cardiovascular cursó con síndrome coronario tipo anfrato al miocardio actualmente evolucionado; reporta ecocardiograma remodelado concéntrico con FEVI conservada 69%, disfunción diastólica tipo I, dilatación auricular izquierda leve, TAPSE 20 mm, sin intervención adicional.

Paciente renal crónica en diálisis peritoneal, con agudización de la misma; valorado por servicio de nefrología quien cosnidera debe continuar con dialisis pertioneales diarias.

Desde el punto de vista infeccioso con cumplimiento de antibioticoterapia, ya resuelta bacteriemia por Serratia Marcescens con reporte de hemocultivo control negativo. Cultivo de secreción orotraqueal con crecimiento de Enterobacter Cloacae en cultivo previo y Pseudomona Aeruginosa en el nuevo, tratada.

Actualmente se encuentra a paciente con Glasgow 9/15 estacionario, sin sedonalgesea; continua bajo soporte ventilatorio invasivo por traqueostomía modo aisto controlado por volumen, acoplado con adecuados índices de oxigenación al visoscopio; manejando frecuencias cardíacas y cifras tensionales en meta, anúrica en paciente renal crónica; con mal control metabólico (glucometrías: 107-61 mg/dl) requiriendo esquema de corrección y ajustes; de momento recibiendo aporte calórico con dextrosados dado procedimiento programado para el día de hoy, con indicación de soporte nutricional enteral con alimento con propósitos médicos especiales tipo pulmocare 237 ml (aporte proteico en 24 horas: 67.5 g, cálculo a 1.5 g prot/kg/día, 1617 kcalorías totales, volumen total) meta de 45 cc/hora.

Considero paciente con patologías críticas crónicas, ya realizada traqueostomía, en plan de gastrostomía el día de hoy y posterior traslado a unidad de cuidados crónicos.

Seguimiento por los servicios de terapia física crítica, terapia ocupacional, fonoaudiología para rehabilitación temprana y precoz de paciente, terapia respiratoria integral, psicología crítica y trabajo social para reintegro al medio y núcleo familiar, soporte nutricional y metabólico críticos.

Debe permanecer en la unidad de cuidados intensivos por tratarse con requerimiento de ventilación mecánica invasiva; además de necesidad de monitoreo

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:20:11 p. m.

Admisión: AD715724

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: SOL BEATRIZ GARCIA MARQUEZ

EPICRISIS

continuo, vigilancia estricta de parámetros hemodinámicos, ventilatorios, neurológicos y metabólicos.

Fecha: 05/04/2022: 14:01:34, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: ALEXANDER FERNANDO FERNANDEZ ARRIETA, Especialidad: CIRUGIA DEL TORAX

Problema:

DX: 1. Tb pleural. 2. VENTILACION MECANICA PROLONGADA

Subjetivo:

Paciente bajo soporte ventilatorio.

Objetivo:

Paciente en Regulares condiciones generales, Bajo VMNI por traqueostomía y sedoanalgesia RASS 0, hidratada, sin soporte vasoactivo. Cuello simétrico, móvil sin adenopatías regionales. Murmullo vesicular disminuido en ambos campos pulmonares, sin sobreagregados. Abdomen globoso, sin masas palpables, catéter de diálisis implantado sin signos de infección y funcional. PATOLOGIA Necrosis compatible con TBC

Análisis:

Paciente en unidad de cuidados intensivos, bajo soporte ventilatorio mecanico a traves de traqueostomia, tiene programado para el dia de hoy, la realización de gastrostomía. Se mantiene estacionaria clinicamente, por lo que se decidió traslado a hostal para continuar manejo.

Fecha: 05/04/2022: 15:06:43, Historia: Evolucion Clinica UCI, Prestador: DANIEL ENRIQUE ALVARADO CUETO, Especialidad: CUIDADO DEL PACIENTE EN ESTADO CRITICO

Análisis:

Femenina en la séptima década de la vida con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, extabaquista, enfermedad renal crónica en terapia de remplazo renal a través de cateter peritoneal; que ingresa inicialmente a la unidad debido a falla ventilatoria aguda en relación a derrame pleural masivo que ameritó aseguramiento de la vía aérea, con estudio de liquido pleural con reporte de exudado linfocitario con ada positivo, por lo que ante alta posibilidad de tuberculosis pleural recibía terapia antifimica, fue llevada a intervención quirúrgica por el servicio de cirugía de tórax el día 09/03/22, donde realizaron decorticación pulmonar + pleurectomía parietal + toma de biopsia + pleurodesis por toracosopia, con reporte de biopsia de decorticación que evidencia tejido fibroconectivo comprometido por proceso inflamatorio agudo y crónico, zonas de necrosis y de pleura parietal que evidencia compromiso de proceso granulomatoso crónico necrotizante compatible con tuberculosis. Durante su curso en la unidad, su proceso se ve entorpecido por detrimento neurologico marcado en relación a uremia producto de agudización de enfermedad renal, que ameritó reintubación y ajuste de TRR peritoneal diarias, ademas cursó con síndrome coronario agudo tipo infarto agudo al miocardio sin elevación del ST, concomitante con choque séptico requirente de soporte vasoactivo, ya destetado. Además cursó con bacteriemia por Serratia Marcescens multisensible, con hemocultivo control negativo y foco pulmonar con cultivo de secreción traqueal con crecimiento de enterobacter Cloacae multisensible/último del 21/03/22 con Pseudomonas auruginosa multidrogorresistente recibiendo cobertura antibiotica con quinolóna de acuerdo a perfil de sensibilidad, completando su ultimo dia hoy 04/04/22 el esquema propuesto.

Actualmente en su postoperatorio de taqueostomia via abierta, procedimiento realizado por servicio de ORL el 28/03/22, debido imposibilidad de uso de vía oral dado componente neurológico por lo que se realizó gastrostomía endoscópica percutánea, el día de hoy 05/04/22 sin ninguna complicación. De momento se encuentra en regulares condiciones generales, bajo ventilación ventilación mecánica a través de cánula de traqueostomia, modo AC/V alterando con bilevel como método de trabajo ventilatorio paulatino, conservando adecuados índices de oxigenación al visoscopio, sin uso de sedantes, con estado neurologico estacionario; glasgow 10 puntos (AO: 3 RV: 1 RM 6); a nivel hemodinamico frecuencias cardiacas controladas y cifras tensionales en metas bajo manejo antihipertensivo, anúrica en paciente renal crónica en terapia de remplazo renal peritoneal, con agudización de la misma; realizandose sesiones diarias por servicio de nefrologia, con cinética de azoados en descenso; recibiendo soporte nutricional enteral con alimento con propósitos médicos especiales tipo tipo ensure clinical frasco 220 ml (aporte proteico 67.5 gr en 24 horas, cálculo a 1.5 gr/kg/día, aporte calórico 1114 kcal/dia, cálculo a 25 kcal/kg/día, volumen total 742.5 ml), meta de 31 cc/hora, en manejo con esquema de insulina basal, regular control metabólico en las últimas horas, afebril.

Considero paciente con patologías críticas crónicas, ya realizada traqueostomía y gastrostomía, con clínica estacionaria, requirente de cuidados crónicos, por lo que se encuentra a la espera de trámite administrativo para traslado a hostal. En ronda de la tarde no realizo cambios en manejo previamente instaurado. Por lo pronto permanecer en la unidad de cuidados intensivos por tratarse con requerimiento de ventilación mecánica invasiva a través de cánula de traqueostomia, en riesgo de arritmias malignas, muerte súbita; además de necesidad de monitoreo continuo, vigilancia estricta de parámetros hemodinámicos, ventilatorios, neurológicos y metabólicos. Seguimiento multidisciplinario de UCI.

Fecha: 05/04/2022: 20:24:30, Historia: Evolucion Clinica UCI, Prestador: JAIME SARMIENTO CALDERON, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Análisis:

Femenina en la séptima década de la vida con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, extabaquista, enfermedad renal crónica en terapia de remplazo renal a través de cateter peritoneal; que ingresa inicialmente a la unidad debido a falla ventilatoria aguda en relación a derrame pleural masivo que ameritó aseguramiento de la vía aérea, con estudio de liquido pleural con reporte de exudado linfocitario con ada positivo, por lo que ante alta posibilidad de tuberculosis pleural recibía terapia antifimica, fue llevada a intervención quirúrgica por el servicio de cirugía de tórax el día 09/03/22, donde realizaron decorticación pulmonar + pleurectomía parietal + toma de biopsia + pleurodesis por toracosopia, con reporte de biopsia de decorticación que evidencia tejido fibroconectivo comprometido por proceso inflamatorio agudo y crónico, zonas de necrosis y de pleura parietal que evidencia compromiso de proceso granulomatoso crónico necrotizante compatible con tuberculosis.

Durante su curso en la unidad, su proceso se ve entorpecido por detrimento neurologico marcado en relación a uremia producto de agudización de enfermedad renal, que ameritó reintubación y ajuste de TRR peritoneal diarias, ademas cursó con síndrome coronario agudo tipo infarto agudo al miocardio sin elevación del ST, concomitante con choque séptico requirente de soporte vasoactivo, ya destetado. Además cursó con bacteriemia por Serratia Marcescens multisensible, con hemocultivo control negativo y foco pulmonar con cultivo de secreción traqueal con crecimiento de enterobacter Cloacae multisensible/último del 21/03/22 con Pseudomonas auruginosa multidrogorresistente recibiendo cobertura antibiotica con quinolóna de acuerdo a perfil de sensibilidad, completando su ultimo dia hoy 04/04/22 el esquema propuesto.

Actualmente en regulares condiciones generales, bajo ventilación ventilación mecánica a través de cánula de traqueostomia, modo AC/V alterando con bilevel como método de trabajo ventilatorio paulatino, conservando adecuados índices de oxigenación al visoscopio, sin uso de sedantes, con estado neurologico estacionario; glasgow 10 puntos (AO: 3 RV: 1 RM 6); a nivel hemodinamico frecuencias cardiacas controladas y cifras tensionales en metas bajo manejo antihipertensivo, anúrica en paciente renal crónica en terapia de remplazo renal peritoneal, con agudización de la misma; realizandose sesiones diarias por servicio de nefrologia, con cinética de azoados en descenso; recibiendo soporte nutricional enteral con alimento con propósitos médicos especiales tipo tipo ensure clinical, en manejo con esquema de insulina basal, regular control metabólico en las últimas horas, afebril.

Considero paciente con patologías críticas crónicas, ya realizada traqueostomía y gastrostomía, con clínica estacionaria, requirente de cuidados crónicos, por lo que se encuentra a la espera de trámite administrativo para traslado a hostal.

Debe permanecer en la unidad de cuidados intensivos por tratarse con requerimiento de ventilación mecánica invasiva a través de cánula de traqueostomia, en riesgo de arritmias malignas, muerte súbita; además de necesidad de monitoreo continuo, vigilancia estricta de parámetros hemodinámicos, ventilatorios, neurológicos y metabólicos. Seguimiento multidisciplinario de UCI.

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:20:11 p. m.

Admisión: AD715724

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: SOL BEATRIZ GARCIA MARQUEZ

EPICRISIS

Fecha: 06/04/2022: 11:44:19, Historia: Evolucion Clinica UCI, Prestador: DANIEL ENRIQUE ALVARADO CUETO, Especialidad: CUIDADO DEL PACIENTE EN ESTADO CRITICO

Análisis:

Se trata de femenina en la séptima década de la vida con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, extabaquista; con estancia en la unidad de cuidados crítico en marco de insuficiencia respiratoria en paciente en contexto de tuberculosis pleural diagnosticado por biopsia recibiendo esquema ripe; con intervención por servicio de cirugía de tórax decorticación pulmonar, pleurectomía parietal con pleurodesis por toracoscopia.

Desde el punto de vista cardiovascular cursó con síndrome coronario tipo anfracto al miocardio actualmente evolucionado; reporta ecocardiograma remodelado concéntrico con FEV conservada 69%, disfunción diastólica tipo I, dilatación auricular izquierda leve, TAPSE 20 mm, sin intervención adicional.

Paciente renal crónica en diálisis peritoneal, con agudización de la misma; valorado por servicio de nefrología quien considera debe continuar con diálisis peritoneales diarias.

Desde el punto de vista infeccioso con cumplimiento de antibióticoterapia, ya resuelta bacteriemia por *Serratia Marcescens* con reporte de hemocultivo control negativo. Cultivo de secreción orotraqueal con crecimiento de *Enterobacter Cloacae* en cultivo previo y *Pseudomona Aeruginosa* en el nuevo, tratada.

Actualmente se encuentra a paciente con Glasgow 9/15 estacionario, sin sedanalgesia; continua bajo soporte ventilatorio invasivo por traqueostomía modo aisto controlado por volumen, acoplado con adecuados índices de oxigenación al visoscopio; manejando frecuencias cardíacas y cifras tensionales en meta, anúrica en paciente renal crónica; con regular control metabólico requiriendo esquema de corrección y ajustes; recibiendo soporte nutricional enteral con alimento con propósitos médicos especiales tipo pulmocar 237 ml (aporte proteico en 24 horas: 67.5 g, cálculo a 1.5 g prot/kg/día, 1617 kcalorías totales, volumen total) meta de 45 cc/hora por gastrostomía.

Considero paciente con patologías críticas crónicas, ya realizada traqueostomía y gastrostomía, a la espera de traslado a unidad de cuidados crónicos.

Seguimiento por los servicios de terapia física crítica, terapia ocupacional, fonoaudiología para rehabilitación temprana y precoz de paciente, terapia respiratoria integral, psicología crítica y trabajo social para reintegro al medio y núcleo familiar, soporte nutricional y metabólico críticos.

Debe permanecer en la unidad de cuidados intensivos por tratarse con requerimiento de ventilación mecánica invasiva; además de necesidad de monitoreo continuo, vigilancia estricta de parámetros hemodinámicos, ventilatorios, neurológicos y metabólicos.

Fecha: 06/04/2022: 13:25:54, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: EDGARD EDUARDO GUTIERREZ PUENTE, Especialidad: CIRUGIA DEL TORAX

Problema:

1. Tb pleural. 2. VENTILACION MECANICA PROLONGADA

Subjetivo:

Paciente bajo soporte ventilatorio.

Objetivo:

Paciente en Regulares condiciones generales, Bajo VMNI por traqueostomía y sedoanalgesia RASS 0, hidratada, sin soporte vasoactivo. Cuello simétrico, móvil sin adenopatías regionales. Murmullo vesicular disminuido en ambos campos pulmonares, sin sobreagregados. Abdomen globoso, gastrostomía funcional, sin masas palpables, catéter de diálisis implantado sin signos de infección y funcional. PATOLOGIA Necrosis compatible con TBC

Análisis:

Paciente en unidad de cuidados intensivos, bajo soporte ventilatorio mecanico a traves de traqueostomia, se realizó la gastrostomía, sin complicaciones, con adecuado funcionamiento. Se mantiene estacionaria clinicamente, por lo que se decidió traslado a hostal para continuar manejo.

Fecha: 06/04/2022: 17:15:12, Historia: Evolucion Clinica UCI, Prestador: LUIS CARLOS JULIO NARVAEZ, Especialidad: CUIDADO DEL PACIENTE EN ESTADO CRITICO

Análisis:

Femenina en la séptima década de la vida con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, extabaquista, enfermedad renal crónica en terapia de remplazo renal a través de cateter peritoneal; que ingresa inicialmente a la unidad debido a falla ventilatoria aguda en relación a derrame pleural masivo que ameritó aseguramiento de la vía aérea, con estudio de liquido pleural con reporte de exudado linfocitario con ada positivo, por lo que ante alta posibilidad de tuberculosis pleural recibía terapia antifimica, fue llevada a intervención quirúrgica por el servicio de cirugía de tórax el día 09/03/22, donde realizaron decorticación pulmonar + pleurectomía parietal + toma de biopsia + pleurodesis por toracoscopia, con reporte de biopsia de decorticación que evidencia tejido fibroconectivo comprometido por proceso inflamatorio agudo y crónico, zonas de necrosis y de pleura parietal que evidencia compromiso de proceso granulomatoso crónico necrotizante compatible con tuberculosis. Durante su curso en la unidad, su proceso se ve entorpecido por detrimento neurológico marcado en relación a uremia producto de agudización de enfermedad renal, que ameritó reintubación y ajuste de TRR peritoneal diarias, ademas cursó con síndrome coronario agudo tipo infarto agudo al miocardio sin elevación del ST, concomitante con choque séptico requirente de soporte vasoactivo, ya destetado. Además cursó con bacteriemia por *Serratia Marcescens* multisensible, con hemocultivo control negativo y foco pulmonar con cultivo de secreción traqueal con crecimiento de *enterobacter Cloacae* multisensible/último del 21/03/22 con *Pseudomonas auruginosa* multidrogresistente recibiendo cobertura antibiótica con quinolóna de azoados en descenso; recibiendo soporte nutricional enteral con alimento con propósitos médicos especiales tipo tipo ensure clinical frasco 220 ml (aporte proteico 67.5 gr en 24 horas, cálculo a 1.5 gr/kg/día, aporte calórico 1114 kcal/día, cálculo a 25 kcal/kg/día, volumen total 742.5 ml), meta de 31 cc/hora, en manejo con esquema de insulina basal, regular control metabólico en las últimas horas, afebril.

De momento se encuentra en regulares condiciones generales, bajo ventilación ventilación mecánica a través de cánula de traqueostomia, modo PRVC alterando con AC/V como método de trabajo ventilatorio paulatino, conservando adecuados índices de oxigenación al visoscopio, sin uso de sedantes, con estado neurológico estacionario; glasgow 10 puntos (AO: 3 RV: 1 RM: 6); a nivel hemodinámico frecuencias cardíacas controladas y cifras tensionales en metas bajo manejo antihipertensivo, anúrica en paciente renal crónica en terapia de reemplazo renal peritoneal, con agudización de la misma; realizandose sesiones diarias por servicio de nefrología, con cinética de azoados en descenso; recibiendo soporte nutricional enteral con alimento con propósitos médicos especiales tipo tipo ensure clinical frasco 220 ml (aporte proteico 67.5 gr en 24 horas, cálculo a 1.5 gr/kg/día, aporte calórico 1114 kcal/día, cálculo a 25 kcal/kg/día, volumen total 742.5 ml), meta de 31 cc/hora, en manejo con esquema de insulina basal, regular control metabólico en las últimas horas, afebril.

Considero paciente con patologías críticas crónicas, ya realizada traqueostomía y gastrostomía, con clínica estacionaria, requirente de cuidados crónicos, por lo que se encuentra a la espera de trámite administrativo para traslado a hostal. En ronda de la tarde no realizo cambios en manejo previamente instaurado. Por lo pronto permanecer en la unidad de cuidados intensivos por tratarse con requerimiento de ventilación mecánica invasiva a través de cánula de traqueostomia, en riesgo de arritmias malignas, muerte súbita; además de necesidad de monitoreo continuo, vigilancia estricta de parámetros hemodinámicos, ventilatorios, neurológicos y metabólicos. Seguimiento multidisciplinario de UCI.

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:20:11 p. m.

Admisión: AD715724

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: SOL BEATRIZ GARCIA MARQUEZ

EPICRISIS

Fecha: 06/04/2022: 21:00:49, Historia: Evolucion Clinica UCI, Prestador: ALVARO ANDRES ZAPATA LEAL, Especialidad: CUIDADO DEL PACIENTE EN ESTADO CRITICO

Análisis:

Femenina en la séptima década de la vida con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, extabaquista, enfermedad renal crónica en terapia de remplazo renal a través de cateter peritoneal; que ingresa inicialmente a la unidad debido a falla ventilatoria aguda en relación a derrame pleural masivo que ameritó aseguramiento de la vía aérea, con estudio de liquido pleural con reporte de exudado linfocitario con ADA positivo, por lo que ante alta posibilidad de tuberculosis pleural recibía terapia antifimica, fue llevada a intervención quirúrgica por el servicio de cirugía de tórax el día 09/03/22, donde realizaron decorticación pulmonar + pleurectomía parietal + toma de biopsia + pleurodesis por toracosopia, con reporte de biopsia de decorticación que evidencia tejido fibroconectivo comprometido por proceso inflamatorio agudo y crónico, zonas de necrosis y de pleura parietal que evidencia compromiso de proceso granulomatoso crónico necrotizante compatible con tuberculosis. Durante su curso en la unidad, su proceso se ve entorpecido por detrimento neurologico marcado en relación a uremia producto de agudización de enfermedad renal, que ameritó reintubación y ajuste de TRR peritoneal diarias, ademas cursó con síndrome coronario agudo tipo infarto agudo al miocardio sin elevación del ST, concomitante con choque séptico requirente de soporte vasactivo, ya destetado. Además cursó con bacteriemia por *Serratia Marcescens* multisensible, con hemocultivo control negativo y foco pulmonar con cultivo de secreción traqueal con crecimiento de *Enterobacter Cloacae* multisensible/último del 21/03/22 con *Pseudomonas aeruginosa* multidrogorresistente recibiendo cobertura antibiotica con quinolóna de acuerdo a perfil de sensibilidad, completando su ultimo día hoy 04/04/22 el esquema propuesto. Actualmente en su postoperatorio de taqueostomía vía abierta, procedimiento realizado por servicio de ORL el 28/03/22, debido imposibilidad de uso de vía oral dado componente neurológico por lo que se realizó gastrostomía endoscópica percutánea, el día de hoy 05/04/22 sin ninguna complicación. Actualmente se encuentra en regulares condiciones generales, bajo ventilación mecánica conectada a través de cánula de traqueostomía, modo PRVC alterando con AC/V como método de trabajo ventilatorio paulatino, conservando adecuados índices de oxigenación al visoscopio, sin uso de sedantes, con estado neurologico estacionario; glasgow 10 puntos (AO: 3 RV: 1 RM 6); a nivel hemodinamico frecuencias cardiacas controladas y cifras tensionales en metas bajo manejo antihipertensivo, anúrica en paciente renal crónica en terapia de reemplazo renal peritoneal, con agudización de la misma; realizandose sesiones diarias por servicio de nefrologia, con cinética de azoados en descenso; recibiendo soporte nutricional enteral con alimento con propósitos médicos especiales tipo tipo ensure clinical frasco 220 ml (aporte proteico 67.5 gr en 24 horas, cálculo a 1.5 gr/kg/día, aporte calórico 1114 kcal/día, cálculo a 25 kcal/kg/día, volumen total 742.5 ml), meta de 31 cc/hora, en manejo con esquema de insulina basal, regular control metabólico, afebril sin datos de sirs.

femenina quein evoluciona en marco de patologías críticas crónicas, ya realizada traqueostomía y gastrostomía, con clínica estacionaria, requiriente de cuidados crónicos, por lo que se encuentra a la espera de aprobación por parte de su entidad prestadora de servicio para traslado a hostal. De momento indico continuidad de manejo medico instaurado sin cambios, se indica continuidad de estancia en la unidad de cuidados intensivos por tratarse con requerimiento de ventilación mecánica invasiva a través de cánula de traqueostomía, en riesgo de arritmias malignas, muerte súbita; además de necesidad de monitoreo continuo, vigilancia estricta de parámetros hemodinámicos, ventilatorios, neurológicos y metabólicos. Seguimiento multidisciplinario de UCI.

Fecha: 07/04/2022: 10:35:51, Historia: Evolucion Clinica UCI, Prestador: DANIEL ENRIQUE ALVARADO CUETO, Especialidad: CUIDADO DEL PACIENTE EN ESTADO CRITICO

Análisis:

PARACLINICOS (07/04/2022):

Hemograma: LEU 10,040 NEU 69,8% HB 8,3 HTO 27,4 VCM 99,6 HCM 30,1 PLT 222 BUN 77 CREA 5,17 NA 124 K 3,0 CL 90 MG 1,3

ANÁLISIS:

Se trata de femenina en la séptima década de la vida con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, extabaquista; con estancia en la unidad de cuidados crítico en marco de insuficiencia respiratoria en paciente en contexto de tuberculosis pleural diagnosticado por biopsia recibiendo esquema ripe; con intervención por servicio de cirugía de tórax: decorticación pulmonar, pleurectomía parietal con pleurodesis por toracosopia.

Desde el punto de vista cardiovascular cursó con síndrome coronario tipo infarto al miocardio actualmente evolucionado; reporta ecocardiograma remodelado concéntrico con FEV conservada 69%, disfunción diastólica tipo I, dilatación auricular izquierda leve, TAPSE 20 mm, sin intervención adicional.

Paciente renal crónica en diálisis peritoneal, con agudización de la misma; valorado por servicio de nefrología quien considera debe continuar con diálisis peritoneales diarias.

Desde el punto de vista infeccioso con cumplimiento de antibioticoterapia, ya resuelta bacteriemia por *Serratia Marcescens* con reporte de hemocultivo control negativo. Cultivo de secreción orotraqueal con crecimiento de *Enterobacter Cloacae* en cultivo previo y *Pseudomonas Aeruginosa* en el nuevo, tratada.

Actualmente se encuentra a paciente con Glasgow 9/15 estacionario, sin sedolagesa; continua bajo soporte ventilatorio invasivo por traqueostomía modo aisto controlado por volumen, acoplado con adecuados índices de oxigenación al visoscopio; manejando frecuencias cardiacas y cifras tensionales en meta, anúrica en paciente renal crónica; con regular control metabólico requiriendo esquema de corrección y ajustes; recibiendo soporte nutricional enteral con alimento con propósitos médicos especiales tipo pulmocare 237 ml (aporte proteico en 24 horas: 67.5 g, cálculo a 1.5 g prot/kg/día, 1617 kcalorías totales, volumen total) meta de 45 cc/hora por gastrostomía.

Considero paciente con patologías críticas crónicas, ya realizada traqueostomía y gastrostomía, a la espera de traslado a unidad de cuidados crónicos. Se indica inicio de potasio parenteral dado hipokalemia. De resto de paraclínicos sin leucocitosis, anemia moderada, plaquetograma en meta, hiperazotemia en paciente renal crónica.

Seguimiento por los servicios de terapia física crítica, terapia ocupacional, fonoaudiología para rehabilitación temprana y precoz de paciente, terapia respiratoria integral, psicología crítica y trabajo social para reintegro al medio y núcleo familiar, soporte nutricional y metabólico críticos.

Debe permanecer en la unidad de cuidados intensivos por tratarse con requerimiento de ventilación mecánica invasiva; además de necesidad de monitoreo continuo, vigilancia estricta de parámetros hemodinámicos, ventilatorios, neurológicos y metabólicos.

Fecha: 07/04/2022: 14:43:27, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: EDGARD EDUARDO GUTIERREZ PUENTE, Especialidad: CIRUGIA DEL TORAX

Problema:

1. Tb pleural. 2. VENTILACION MECANICA PROLONGADA

Subjetivo:

Paciente bajo soporte ventilatorio.

Objetivo:

Paciente en Regulares condiciones generales, Bajo VMNI por traqueostomía y sedoanalgesia RASS 0, hidratada, sin soporte vasactivo. Cuello simétrico, móvil sin adenopatías regionales. Murmullo vesicular disminuido en ambos campos pulmonares, sin sobreagregados. Abdomen globoso, gastrostomía funcional, sin masas palpables, catéter de diálisis implantado sin signos de infección y funcional. PATOLOGIA Necrosis compatible con TBC

Análisis:

Paciente en unidad de cuidados intensivos, bajo soporte ventilatorio mecanico a traves de traqueostomía, gastrostomía funcional. Se mantiene estacionaria

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:20:11 p. m.

Admisión: AD715724

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: SOL BEATRIZ GARCIA MARQUEZ

EPICRISIS

clínicamente, pendiente traslado al hospital para continuar manejo.

Fecha: 07/04/2022: 16:07:12, Historia: Evolucion Clínica UCI, Prestador: LUIS CARLOS JULIO NARVAEZ, Especialidad: CUIDADO DEL PACIENTE EN ESTADO CRÍTICO

Análisis:

Femenina en la séptima década de la vida con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, extirpación, enfermedad renal crónica en terapia de reemplazo renal a través de catéter peritoneal; que ingresa inicialmente a la unidad debido a falla ventilatoria aguda en relación a derrame pleural masivo que ameritó aseguramiento de la vía aérea, con estudio de líquido pleural con reporte de exudado linfocitario con ADA positivo, por lo que ante alta posibilidad de tuberculosis pleural recibía terapia antifúngica, fue llevada a intervención quirúrgica por el servicio de cirugía de tórax el día 09/03/22, donde realizaron decorticación pulmonar + pleurectomía parietal + toma de biopsia + pleurodesis por toracoscopia, con reporte de biopsia de decorticación que evidencia tejido fibroconectivo comprometido por proceso inflamatorio agudo y crónico, zonas de necrosis y de pleura parietal que evidencia compromiso de proceso granulomatoso crónico necrotizante compatible con tuberculosis. Durante su curso en la unidad, su proceso se ve entorpecido por deterioro neurológico marcado en relación a uremia producto de agudización de enfermedad renal, que ameritó reintubación y ajuste de TRR peritoneal diarias, además cursó con síndrome coronario agudo tipo infarto agudo al miocardio sin elevación del ST, concomitante con choque séptico requirente de soporte vasoaditivo, ya destetado. Además cursó con bacteriemia por *Serratia Marcescens* multisensible, con hemocultivo control negativo y foco pulmonar con cultivo de secreción traqueal con crecimiento de enterobacter *Cloacae* multisensible/último del 21/03/22 con *Pseudomonas aeruginosa* multidrogorresistente recibiendo cobertura antibiótica con quinolón de acuerdo a perfil de sensibilidad, completando su último día hoy 04/04/22 el esquema propuesto. Actualmente en su postoperatorio de taqueostomía vía abierta, procedimiento realizado por servicio de ORL el 28/03/22, debido imposibilidad de uso de vía oral dado componente neurológico por lo que se realizó gastrostomía endoscópica percutánea, el día 05/04/22 sin ninguna complicación.

De momento se encuentra en regulares condiciones generales, bajo ventilación mecánica a través de cánula de traqueostomía, modo PRVC alterando con AC/V como método de trabajo ventilatorio paulatino, conservando adecuados índices de oxigenación al visoscopio, sin uso de sedantes, con estado neurológico estacionario; Glasgow 10 puntos (AO: 3 RV: 1 RM: 6); a nivel hemodinámico frecuencias cardíacas controladas y cifras tensionales en metas bajo manejo antihipertensivo, anúrica en paciente renal crónica en terapia de reemplazo renal peritoneal, con agudización de la misma; realizándose sesiones diarias por servicio de nefrología, con cinética de azúcos en descenso; recibiendo soporte nutricional enteral con alimento con propósitos médicos especiales tipo tipo ensure clínico frasco 220 ml (aporte proteico 67.5 gr en 24 horas, cálculo a 1.5 gr/kg/día, aporte calórico 1114 kcal/día, cálculo a 25 kcal/kg/día, volumen total 742.5 ml), meta de 31 cc/hora, en manejo con esquema de insulina basal, regular control metabólico en las últimas horas, afebril.

Considero paciente con patologías críticas crónicas, ya realizada traqueostomía y gastrostomía, con clínica estacionaria, requirente de cuidados crónicos, por lo que se encuentra a la espera de trámite administrativo para traslado a hospital. En ronda de la tarde no realicé cambios en manejo previamente instaurado. Por lo pronto permanecer en la unidad de cuidados intensivos por tratarse con requerimiento de ventilación mecánica invasiva a través de cánula de traqueostomía, en riesgo de arritmias malignas, muerte súbita; además de necesidad de monitoreo continuo, vigilancia estricta de parámetros hemodinámicos, ventilatorios, neurológicos y metabólicos. Seguimiento multidisciplinario de UCI.

Fecha: 07/04/2022: 20:10:06, Historia: Evolucion Clínica UCI, Prestador: FELIPE HERRERARUIZ, Especialidad: CUIDADO DEL PACIENTE EN ESTADO CRÍTICO

Análisis:

Femenina en la séptima década de la vida con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, extirpación, enfermedad renal crónica en terapia de reemplazo renal a través de catéter peritoneal; que ingresa inicialmente a la unidad debido a falla ventilatoria aguda en relación a derrame pleural masivo que ameritó aseguramiento de la vía aérea, con estudio de líquido pleural con reporte de exudado linfocitario con ADA positivo, por lo que ante alta posibilidad de tuberculosis pleural recibía terapia antifúngica, fue llevada a intervención quirúrgica por el servicio de cirugía de tórax el día 09/03/22, donde realizaron decorticación pulmonar + pleurectomía parietal + toma de biopsia + pleurodesis por toracoscopia, con reporte de biopsia de decorticación que evidencia tejido fibroconectivo comprometido por proceso inflamatorio agudo y crónico, zonas de necrosis y de pleura parietal que evidencia compromiso de proceso granulomatoso crónico necrotizante compatible con tuberculosis.

Durante su curso en la unidad, su proceso se ve entorpecido por deterioro neurológico marcado en relación a uremia producto de agudización de enfermedad renal, que ameritó reintubación y ajuste de TRR peritoneal diarias, además cursó con síndrome coronario agudo tipo infarto agudo al miocardio sin elevación del ST, concomitante con choque séptico requirente de soporte vasoaditivo, ya destetado. Además cursó con bacteriemia por *Serratia Marcescens* multisensible, con hemocultivo control negativo y foco pulmonar con cultivo de secreción traqueal con crecimiento de enterobacter *Cloacae* multisensible/último del 21/03/22 con *Pseudomonas aeruginosa* multidrogorresistente recibiendo cobertura antibiótica con quinolón de acuerdo a perfil de sensibilidad, completando su último día hoy 04/04/22 el esquema propuesto. Actualmente en su postoperatorio de taqueostomía vía abierta, procedimiento realizado por servicio de ORL el 28/03/22, debido imposibilidad de uso de vía oral dado componente neurológico por lo que se realizó gastrostomía endoscópica percutánea, el día 05/04/22 sin ninguna complicación.

Actualmente en regulares condiciones generales, bajo ventilación mecánica a través de cánula de traqueostomía, modo PRVC alterando con AC/V como método de trabajo ventilatorio paulatino; a nivel hemodinámico frecuencias cardíacas controladas y cifras tensionales en metas bajo manejo antihipertensivo, anúrica en paciente renal crónica en terapia de reemplazo renal peritoneal, con agudización de la misma; realizándose sesiones diarias por servicio de nefrología, con cinética de azúcos en descenso; recibiendo soporte nutricional enteral con alimento con propósitos médicos especiales tipo tipo ensure clínico, en manejo con esquema de insulina basal, regular control metabólico en las últimas horas, afebril.

Paciente con patologías críticas crónicas, ya realizada traqueostomía y gastrostomía, con clínica estacionaria, requirente de cuidados crónicos, por lo que se encuentra a la espera de trámite administrativo para traslado a hospital. En ronda de la tarde no realicé cambios en manejo previamente instaurado.

Debe permanecer en la unidad de cuidados intensivos por tratarse con requerimiento de ventilación mecánica invasiva a través de cánula de traqueostomía, en riesgo de arritmias malignas, muerte súbita; además de necesidad de monitoreo continuo, vigilancia estricta de parámetros hemodinámicos, ventilatorios, neurológicos y metabólicos. Seguimiento multidisciplinario de UCI.

Fecha: 08/04/2022: 10:42:11, Historia: Evolucion Clínica UCI, Prestador: DANIEL ENRIQUE ALVARADO CUETO, Especialidad: CUIDADO DEL PACIENTE EN ESTADO CRÍTICO

Análisis:

Se trata de femenina en la séptima década de la vida con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, extirpación; con estancia en la unidad de cuidados críticos en marco de insuficiencia respiratoria en paciente en contexto de tuberculosis pleural diagnosticado por biopsia recibiendo esquema RIPE; con intervención por servicio de cirugía de tórax: decorticación pulmonar, pleurectomía parietal con pleurodesis por toracoscopia.

Desde el punto de vista cardiovascular cursó con síndrome coronario tipo infarto al miocardio actualmente evolucionado; reporta ecocardiograma remodelado concéntrico con FEVI conservada 69%, disfunción diastólica tipo I, dilatación auricular izquierda leve, TAPSE 20 mm, sin intervención adicional.

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:20:11 p. m.

Admisión: AD715724

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: SOL BEATRIZ GARCIA MARQUEZ

EPICRISIS

Paciente renal crónica en diálisis peritoneal, con agudización de la misma; valorado por servicio de nefrología quien considera debe continuar con diálisis peritoneales diarias.

Desde el punto de vista infeccioso con cumplimiento de antibioticoterapia, ya resuelta bacteriemia por *Serratia Marcescens* con reporte de hemocultivo control negativo. Cultivo de secreción orotraqueal con crecimiento de *Enterobacter Cloacae* en cultivo previo y *Pseudomona Aeruginosa* en el nuevo, tratada. Paciente con cuadro inflamatorio crónico dado tuberculois pleural actualmente en manejo con esquema ripe desde el día de 01/03/2022.

Se encuentra a paciente con Glasgow 9/15 estacionario, sin sedolagesa; continua bajo soporte ventilatorio invasivo por traqueostomía modo aisto controlado por volumen, acoplada con adecuados índices de oxigenación al visoscopio; manejando frecuencias cardíacas y cifras tensionales en meta, anúrica en paciente renal crónica; con regular control metabólico requiriendo esquema de corrección y ajustes; recibiendo soporte nutricional enteral con alimento con propósitos médicos especiales tipo pulmocar 237 ml (aporte proteico en 24 horas: 67.5 g, cálculo a 1.5 g prot/kg/día, 1617 kcalorías totales, volumen total) meta de 45 cc/hora por gastrostomía.

Considero paciente con patologías críticas crónicas, ya realizada traqueostomía y gastrostomía, a la espera de traslado a unidad de cuidados crónicos. Se suspende reposición de potasio parenteral.

Seguimiento por los servicios de terapia física crítica, terapia ocupacional, fonoaudiología para rehabilitación temprana y precoz de paciente, terapia respiratoria integral, psicología crítica y trabajo social para reintegro al medio y núcleo familiar, soporte nutricional y metabólico críticos.

Debe permanecer en la unidad de cuidados intensivos por tratarse con requerimiento de ventilación mecánica invasiva; además de necesidad de monitoreo continuo, vigilancia estricta de parámetros hemodinámicos, ventilatorios, neurológicos y metabólicos.

Fecha: 08/04/2022: 15:08:55, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: EDGARD EDUARDO GUTIERREZ PUENTE, Especialidad: CIRUGIA DEL TORAX

Problema:

1. Tb pleural. 2. VENTILACION MECANICA PROLONGADA

Subjetivo:

Paciente bajo soporte ventilatorio.

Objetivo:

Paciente en Regulares condiciones generales, hidratada, sin soporte vasoactivo. Cuello simétrico, móvil sin adenopatías regionales, cánula de traqueostomía funcional conectada a ventilación mecánica. Murmullo vesicular disminuido en ambos campos pulmonares, sin sobreagregados. Abdomen globoso, gastrostomía funcional, sin masas palpables, catéter de diálisis implantado sin signos de infección y funcional. PATOLOGIA Necrosis compatible con TBC

Análisis:

Paciente en unidad de cuidados intensivos, bajo soporte ventilatorio mecanico a traves de traqueostomia, gastrostomia funcional. Sin cambios clinicos significativos, pendiente traslado al hostal para continuar manejo.

Fecha: 08/04/2022: 16:56:07, Historia: Evolucion Clinica UCI, Prestador: DANIEL ENRIQUE ALVARADO CUETO, Especialidad: CUIDADO DEL PACIENTE EN ESTADO CRITICO

Análisis:

Femenina en la séptima década de la vida con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, extabaquista, enfermedad renal crónica en terapia de remplazo renal a través de cateter peritoneal; que ingresa inicialmente a la unidad debido a falla ventilatoria aguda en relación a derrame pleural masivo que ameritó aseguramiento de la vía aérea, con estudio de liquido pleural con reporte de exudado linfocitario con ada positivo, por lo que ante alta posibilidad de tuberculosis pleural recibía terapia antifimica, fue llevada a intervención quirúrgica por el servicio de cirugía de tórax el día 09/03/22, donde realizaron decorticación pulmonar + pleurectomía parietal + toma de biopsia + pleurodesis por toracosopia, con reporte de biopsia de decorticación que evidencia tejido fibroconectivo comprometido por proceso inflamatorio agudo y crónico, zonas de necrosis y de pleura parietal que evidencia compromiso de proceso granulomatoso crónico necrotizante compatible con tuberculosis. Durante su curso en la unidad, su proceso se ve entorpecido por detrimento neurologico marcado en relación a uremia producto de agudización de enfermedad renal, que ameritó reintubación y ajuste de TRR peritoneal diarias, ademas cursó con síndrome coronario agudo tipo infarto agudo al miocardio sin elevación del ST, concomitante con choque séptico requirente de soporte vasoactivo, ya destetado. Además cursó con bacteriemia por *Serratia Marcescens* multisensible, con hemocultivo control negativo y foco pulmonar con cultivo de secreción traqueal con crecimiento de *enterobacter Cloacae* multisensible/último del 21/03/22 con *Pseudomonas auruginosa* multidrogoresistente recibiendo cobertura antibiotica con quinolóna de acuerdo a perfil de sensibilidad, completando su ultimo dia hoy 04/04/22 el esquema propuesto. Actualmente en su postoperatorio de taqueostomia via abierta, procedimiento realizado por servicio de ORL el 28/03/22, debido imposibilidad de uso de vía oral dado componente neurológico por lo que se realizó gastrostomía endoscópica percutánea, el día 05/04/22 sin ninguna complicación.

De momento se encuentra en regulares condiciones generales, bajo ventilación ventilación mecánica a través de cánula de traqueostomia, modo PRVC alterando con AC/V como método de trabajo ventilatorio paulatino, conservando adecuados índices de oxigenación al visoscopio, sin uso de sedantes, con estado neurologico estacionario; glasgow 10 puntos (AO: 3 RV: 1 RM 6); a nivel hemodinamico frecuencias cardiacas controladas y cifras tensionales en metas bajo manejo antihipertensivo, anúrica en paciente renal crónica en terapia de remplazo renal peritoneal, con agudización de la misma; realizandose sesiones diarias por servicio de nefrologia, con cinética de azoados en descenso; recibiendo soporte nutricional enteral con alimento con propósitos médicos especiales tipo tipo ensure clinical frasco 220 ml (aporte proteico 67.5 gr en 24 horas, cálculo a 1.5 gr/kg/día, aporte calórico 1114 kcal/día, cálculo a 25 kcal/kg/día, volumen total 742.5 ml), meta de 31 cc/hora, en manejo con esquema de insulina basal, regular control metabólico en las últimas horas, afebril. A nivel paraclinico sin leucocitosis, sin alteraciones hidroelectroliticas.

Considero paciente con patologías críticas crónicas, ya realizada traqueostomía y gastrostomía, con clínica estacionaria, requirente de cuidados crónicos, por lo que se encuentra a la espera de trámite administrativo para traslado a hostal. En ronda de la tarde no realizo cambios en manejo previamente instaurado. Por lo pronto permanecer en la unidad de cuidados intensivos por tratarse con requerimiento de ventilación mecánica invasiva a través de cánula de traqueostomia, en riesgo de arrimias malignas, muerte súbita; además de necesidad de monitoreo continuo, vigilancia estricta de parámetros hemodinámicos, ventilatorios, neurológicos y metabólicos. Seguimiento multidisciplinario de UCI.

Fecha: 08/04/2022: 20:12:58, Historia: Evolucion Clinica UCI, Prestador: JUAN PABLO ORTIZ SALAZAR, Especialidad: CUIDADO DEL PACIENTE EN ESTADO CRITICO

Análisis:

Se trata de femenina en la séptima década de la vida con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, extabaquista; con estancia en la unidad de cuidados crítico en marco de insuficiencia respiratoria en paciente en contexto de tuberculosis pleural diagnosticado por biopsia recibiendo esquema ripe; con intervención por servicio de cirugía de tórax decorticación pulmonar, pleurectomía parietal con pleurodesis por toracosopia.

Desde el punto de vista cardiovascular cursó con síndrome coronario tipo anfrato al miocardio actualmente evolucionado; reporta ecocardiograma remodelado concéntrico con FEM conservada 69%, disfunción diastólica tipo I, dilatación auricular izquierda leve, TAPSE 20 mm, sin intervención adicional.

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:20:11 p. m.

Admisión: AD715724

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: SOL BEATRIZ GARCIA MARQUEZ

EPICRISIS

Paciente renal crónica en diálisis peritoneal, con agudización de la misma; valorado por servicio de nefrología quien considera debe continuar con diálisis peritoneales diarias.

Desde el punto de vista infeccioso con cumplimiento de antibioticoterapia, ya resuelta bacteriemia por *Serratia Marcescens* con reporte de hemocultivo control negativo. Cultivo de secreción orotraqueal con crecimiento de *Enterobacter Cloacae* en cultivo previo y *Pseudomona Aeruginosa* en el nuevo, tratada. Paciente con cuadro inflamatorio crónico dado tuberculois pleural actualmente en manejo con esquema ripe desde el día de 01/03/2022.

En el momento continua paciente con glsagow estacionario, signos vitales en metas; paciente con patologías críticas crónicas, ya realizada traqueostomía y gastrostomía, a la espera de traslado a unidad de cuidados crónicos.

Seguimiento por los servicios de terapia física crítica, terapia ocupacional, fonoaudiología para rehabilitación temprana y precoz de paciente, terapia respiratoria integral, psicología crítica y trabajo social para reintegro al medio y núcleo familiar, soporte nutricional y metabólico críticos.

Debe permanecer en la unidad de cuidados intensivos por tratarse con requerimiento de ventilación mecánica invasiva; además de necesidad de monitoreo continuo, vigilancia estricta de parámetros hemodinámicos, ventilatorios, neurológicos y metabólicos.

Fecha: 09/04/2022: 11:21:48, Historia: Evolucion Clinica UCI, Prestador: FELIPE HERRERA RUIZ, Especialidad: CUIDADO DEL PACIENTE EN ESTADO CRITICO
Análisis:

Se trata de femenina en la séptima década de la vida con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, extabaquista; con estancia en la unidad de cuidados crítico en marco de insuficiencia respiratoria en paciente en contexto de tuberculosis pleural diagnosticado por biopsia recibiendo esquema ripe; con intervención por servicio de cirugía de tórax: decorticación pulmonar, pleurectomía parietal con pleurodesis por toracoscopia.

Desde el punto de vista cardiovascular cursó con síndrome coronario tipo infarto al miocardio actualmente evolucionado; reporta ecocardiograma remodelado concéntrico con FEV conservada 69%, disfunción diastólica tipo I, dilatación auricular izquierda leve, TAPSE 20 mm, sin intervención adicional.

Paciente renal crónica en diálisis peritoneal, con agudización de la misma; valorado por servicio de nefrología quien considera debe continuar con diálisis peritoneales diarias.

Desde el punto de vista infeccioso con cumplimiento de antibioticoterapia, ya resuelta bacteriemia por *Serratia Marcescens* con reporte de hemocultivo control negativo. Cultivo de secreción orotraqueal con crecimiento de *Enterobacter Cloacae* en cultivo previo y *Pseudomona Aeruginosa* en el nuevo, tratada. Paciente con cuadro inflamatorio crónico dado tuberculois pleural actualmente en manejo con esquema ripe desde el día de 01/03/2022.

De momento se encuentra en regulares condiciones generales, bajo ventilación mecánica a través de cánula de traqueostomía, conservando adecuados índices de oxigenación al visoscopio, sin uso de sedantes, con estado neurológico estacionario; a nivel hemodinámico frecuencias cardíacas controladas y cifras tensionales en metas bajo manejo antihipertensivo, anúrica en paciente renal crónica en terapia de reemplazo renal peritoneal, con agudización de la misma; realizándose sesiones diarias por servicio de nefrología, con cinética de azoados en descenso; recibiendo soporte nutricional enteral con alimento con propósitos médicos especiales tipo tipo ensure clinical frasco 220 ml (aporte proteico 67.5 gr en 24 horas, cálculo a 1.5 gr/kg/día, aporte calórico 1114 kcal/día, cálculo a 25 kcal/kg/día, volumen total 742.5 ml), meta de 31 cc/hora, en manejo con esquema de insulina basal, regular control metabólico en las últimas horas, afebril, con deposiciones líquidas #5.

Paciente con patologías críticas crónicas, ya realizada traqueostomía y gastrostomía, con clínica estacionaria, requiriente de cuidados crónicos, por lo que se encuentra a la espera de trámite administrativo para traslado a hospital.

Seguimiento por los servicios de terapia física crítica, terapia ocupacional, fonoaudiología para rehabilitación temprana y precoz de paciente, terapia respiratoria integral, psicología crítica y trabajo social para reintegro al medio y núcleo familiar, soporte nutricional y metabólico críticos.

Debe permanecer en la unidad de cuidados intensivos por tratarse con requerimiento de ventilación mecánica invasiva; además de necesidad de monitoreo continuo, vigilancia estricta de parámetros hemodinámicos, ventilatorios, neurológicos y metabólicos.

Fecha: 09/04/2022: 12:20:35, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: EDGARD EDUARDO GUTIERREZ PUENTE, Especialidad: CIRUGIA DEL TORAX
Problema:

1. Tb pleural. 2. VENTILACION MECANICA PROLONGADA

Subjetivo:

Paciente bajo soporte ventilatorio.

Objetivo:

Paciente en Regulares condiciones generales, hidratada, sin soporte vasoactivo. Cuello simétrico, móvil sin adenopatías regionales, cánula de traqueostomía funcional conectada a ventilación mecánica. Murmullo vesicular disminuido en ambos campos pulmonares, sin sobreaagregados. Abdomen globoso, gastrostomía funcional, sin masas palpables, catéter de diálisis implantado sin signos de infección y funcional. PATOLOGIA Necrosis compatible con TBC

Análisis:

Paciente en unidad de cuidados intensivos, bajo soporte ventilatorio mecanico a traves de traqueostomia, gastrostomia funcional. Sin cambios clinicos significativos, pendiente traslado al hospital para continuar manejo.

Fecha: 09/04/2022: 20:04:22, Historia: Evolucion Clinica UCI, Prestador: JUAN PABLO ORTIZ SALAZAR, Especialidad: CUIDADO DEL PACIENTE EN ESTADO CRITICO
Análisis:

Se trata de femenina en la séptima década de la vida con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, extabaquista; con estancia en la unidad de cuidados crítico en marco de insuficiencia respiratoria en paciente en contexto de tuberculosis pleural diagnosticado por biopsia recibiendo esquema ripe; con intervención por servicio de cirugía de tórax: decorticación pulmonar, pleurectomía parietal con pleurodesis por toracoscopia.

Desde el punto de vista cardiovascular cursó con síndrome coronario tipo infarto al miocardio actualmente evolucionado; reporta ecocardiograma remodelado concéntrico con FEV conservada 69%, disfunción diastólica tipo I, dilatación auricular izquierda leve, TAPSE 20 mm, sin intervención adicional.

Paciente renal crónica en diálisis peritoneal, con agudización de la misma; valorado por servicio de nefrología quien considera debe continuar con diálisis peritoneales diarias.

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:20:11 p. m.

Admisión: AD715724

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: SOL BEATRIZ GARCIA MARQUEZ

EPICRISIS

Desde el punto de vista infeccioso con cumplimiento de antibioticoterapia, ya resuelta bacteriemia por *Serratia Marcescens* con reporte de hemocultivo control negativo. Cultivo de secreción orotraqueal con crecimiento de *Enterobacter Cloacae* en cultivo previo y *Pseudomona Aeruginosa* en el nuevo, tratada. Paciente con cuadro inflamatorio crónico dado tuberculois pleural actualmente en manejo con esquema ripe desde el día de 01/03/2022.

En ronda nocturna se encuentra en regulares condiciones generales, bajo ventilación ventilación mecánica a través de cánula de traqueostomía, conservando adecuados índices de oxigenación al visoscopio, sin uso de sedantes, con estado neurológico estacionario; a nivel hemodinámico frecuencias cardíacas controladas y cifras tensionales en metas bajo manejo antihipertensivo, anúrica en paciente renal crónica en terapia de reemplazo renal peritoneal, con agudización de la misma; realizándose sesiones diarias por servicio de nefrología, con cinética de azoados en descenso; recibiendo soporte nutricional enteral con alimento con propósitos médicos especiales tipo tipo ensure clinical frasco 220 ml (aporte proteico 67.5 gr en 24 horas, cálculo a 1.5 gr/kg/día, aporte calórico 1114 kcal/día, cálculo a 25 kcal/kg/día, volumen total 742.5 ml), meta de 31 cc/hora, en manejo con esquema de insulina basal, regular control metabólico en las últimas horas, afebril, con deposiciones líquidas #5.

Paciente con patologías críticas crónicas, ya realizada traqueostomía y gastrostomía, con clínica estacionaria, requiriente de cuidados crónicos, por lo que se encuentra a la espera de trámite administrativo para traslado a hospital.

Seguimiento por los servicios de terapia física crítica, terapia ocupacional, fonoaudiología para rehabilitación temprana y precoz de paciente, terapia respiratoria integral, psicología crítica y trabajo social para reintegro al medio y núcleo familiar, soporte nutricional y metabólico críticos.

Debe permanecer en la unidad de cuidados intensivos por tratarse con requerimiento de ventilación mecánica invasiva; además de necesidad de monitoreo continuo, vigilancia estricta de parámetros hemodinámicos, ventilatorios, neurológicos y metabólicos.

Fecha: 10/04/2022: 11:16:03, Historia: Evolucion Clinica UCI, Prestador: JUAN PABLO ORTIZ SALAZAR, Especialidad: CUIDADO DEL PACIENTE EN ESTADO CRITICO

Análisis:

PACIENTE FEMENINA EN LA SÉPTIMA DÉCADA DE LA VIDA CON ANTECEDENTES DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL, DIABETES MELLITUS TIPO 2, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA, EXTABAQUISTA; CON ESTANCIA EN LA UNIDAD DE CUIDADOS CRÍTICO EN MARCO DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA EN PACIENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PLEURAL DIAGNOSTICADO POR BIOPSIA RECIBIENDO ESQUEMA RIPE; CON INTERVENCIÓN POR SERVICIO DE CIRUGÍA DE TÓRAX: DECORTICACIÓN PULMONAR, PLEURECTOMÍA PARIETAL CON PLEURODESIS POR TORACOSCOPIA, CURSÓ CON SÍNDROME CORONARIO TIPO I AM NO ST ACTUALMENTE EVOLUCIONADO; CUENTA CON REPORTE DE ECOCARDIOGRAMA CON REMODELADO CONCÉNTRICO CON FEVI CONSERVADA 69%, DISFUNCIÓN DIASTÓLICA TIPO I, DILATACIÓN AURICULAR IZQUIERDA LEVE, TAPSE 20 MM, ADICIONALMENTE PACIENTE RENAL CRÓNICA EN DIÁLISIS PERITONEAL, CON AGUDIZACIÓN DE LA MISMA; EN SEGUIMIENTO POR SERVICIO DE NEFROLOGÍA QUIEN INDICO CONTINUACIÓN DE DIÁLISIS PERITONEALES DIARIAS, DESDE EL PUNTO DE VISTA INFECCIOSO CON CUMPLIMIENTO DE ANTIBIOTICOTERAPIA, YA RESUELTA BACTERIEMIA POR *SERRATIA MARCESCENS* CON REPORTE DE HEMOCULTIVO CONTROL NEGATIVO. CULTIVO DE SECRECIÓN OROTRAQUEAL CON CRECIMIENTO DE *ENTEROBACTER CLOACAE* EN CULTIVO PREVIO Y *PSEUDOMONA AERUGINOSA* EN EL NUEVO, YA MANEJADA TRATADA POR ÚLTIMO PACIENTE CON CUADRO INFLAMATORIO CRÓNICO DADO TBC PLEURAL ACTUALMENTE EN MANEJO CON ESQUEMA RIPE DESDE EL DÍA DE 01/03/2022.

ACTUALMENTE SE ENCUENTRA PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, BAJO VENTILACIÓN VENTILACIÓN MECÁNICA A TRAVÉS DE CÁNULA DE TRAQUEOSTOMIA, CONSERVANDO ADECUADOS ÍNDICES DE OXIGENACIÓN AL VISOSCOPIO, SIN USO DE SEDANTES, CON ESTADO NEUROLÓGICO ESTACIONARIO, HEMODINÁMICAMENTE EUCÁRDICA CON CIFRAS TENSIONALES EN METAS BAJO MANEJO ANTIHIPERTENSIVO, ANÚRICA EN PACIENTE RENAL CRÓNICA EN TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL PERITONEAL, CON AGUDIZACIÓN DE LA MISMA; REALIZÁNDOSE SESIONES DIARIAS POR SERVICIO DE NEFROLOGÍA, CON CINÉTICA DE AZOADOS EN DESCENSO; RECIBIENDO SOPORTE NUTRICIONAL ENTERAL CON ALIMENTO CON PROPÓSITOS MÉDICOS ESPECIALES TIPO TIPO ENSURE CLINICAL FRASCO 220 ML (APORTE PROTEICO 67.5 GR EN 24 HORAS, CÁLCULO A 1.5 GR/KG/DÍA, APOORTE CALÓRICO 1114 Kcal/DÍA, CÁLCULO A 25 Kcal/Kg/DÍA, VOLUMEN TOTAL 742.5 ML), META DE 31 CC/HORA, EN MANEJO CON ESQUEMA DE INSULINA BASAL, REGULAR CONTROL METABÓLICO (00-170, 06-321 MG/DL), AFEBRIL, CON DEPOSICIONES PRESENTES.

PACIENTE CON PATOLOGÍAS CRÍTICAS CRÓNICAS, YA REALIZADA TRAQUEOSTOMÍA Y GASTROSTOMÍA, CON CLÍNICA ESTACIONARIA, REQUIRIENTE DE CUIDADOS CRÓNICOS, POR LO QUE SE ENCUENTRA A LA ESPERA DE TRÁMITE ADMINISTRATIVO PARA TRASLADO A HOSPITAL, POR LO PRONTO CONTINUO IGUALES ORDENES MEDICAS, ATENTOS A EVOLUCIÓN CLÍNICA.

SEGUIMIENTO POR LOS SERVICIOS DE TERAPIA FÍSICA CRÍTICA, TERAPIA OCUPACIONAL, FONOAUDIOLÓGICA PARA REHABILITACIÓN TEMPRANA Y PRECOZ DE PACIENTE, TERAPIA RESPIRATORIA INTEGRAL, PSICOLOGÍA CRÍTICA Y TRABAJO SOCIAL PARA REINTEGRO AL MEDIO Y NÚCLEO FAMILIAR, SOPORTE NUTRICIONAL Y METABÓLICO CRÍTICOS.

PACIENTE AMERITA ESTANCIA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS POR TRATARSE CON REQUERIMIENTO DE VENTILACIÓN MECÁNICA INVASIVA; ADEMÁS DE NECESIDAD DE MONITOREO CONTINUO, VIGILANCIA ESTRUCTA DE PARÁMETROS HEMODINÁMICOS, VENTILATORIOS, NEUROLÓGICOS Y METABÓLICOS.

Fecha: 10/04/2022: 13:33:56, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: EDGARD EDUARDO GUTIERREZ PUENTE, Especialidad: CIRUGIA DEL TORAX

Problema:

1. Tb pleural. 2. VENTILACION MECANICA PROLONGADA

Subjetivo:

Paciente bajo soporte ventilatorio.

Objetivo:

Paciente en Regulares condiciones generales, hidratada, sin soporte vasoactivo. Cuello simétrico, móvil sin adenopatías regionales, cánula de traqueostomía funcional conectada a ventilación mecánica. Murmullo vesicular disminuido en ambos campos pulmonares, sin sobreagregados. Abdomen globoso, gastrostomía funcional, sin masas palpables, catéter de diálisis implantado sin signos de infección y funcional. PATOLOGÍA Necrosis compatible con TBC

Análisis:

Paciente en unidad de cuidados intensivos, bajo soporte ventilatorio mecanico a traves de traqueostomía, gastrostomía funcional. Sin cambios clinicos significativos, pendiente traslado al hospital para continuar manejo.

Fecha: 10/04/2022: 19:57:51, Historia: Evolucion Clinica UCI, Prestador: JUAN PABLO ORTIZ SALAZAR, Especialidad: CUIDADO DEL PACIENTE EN ESTADO CRITICO

Análisis:

PACIENTE FEMENINA EN LA SÉPTIMA DÉCADA DE LA VIDA CON ANTECEDENTES DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL, DIABETES MELLITUS TIPO 2, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA, EXTABAQUISTA; CON CUMPLIMIENTO DE ANTIBIOTICOTERAPIA, YA RESUELTA BACTERIEMIA POR *SERRATIA MARCESCENS* CON REPORTE DE HEMOCULTIVO CONTROL NEGATIVO. CULTIVO DE SECRECIÓN OROTRAQUEAL CON CRECIMIENTO DE *ENTEROBACTER CLOACAE* EN CULTIVO PREVIO Y *PSEUDOMONA AERUGINOSA* EN EL NUEVO, YA MANEJADA TRATADA POR ÚLTIMO PACIENTE CON

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:20:11 p. m.

Admisión: AD715724

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: SOL BEATRIZ GARCIA MARQUEZ

EPICRISIS

CUADRO INFLAMATORIO CRÓNICO DADO TBC PLEURAL ACTUALMENTE EN MANEJO CON ESQUEMA RIPE DESDE EL DÍA DE 01/03/2022.

ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, BAJO VENTILACIÓN MECÁNICA A TRAVÉS DE CÁNULA DE TRAQUEOSTOMIA, CONSERVANDO ADECUADOS ÍNDICES DE OXIGENACIÓN AL VISOSCOPIO, SIN USO DE SEDANTES, CON ESTADO NEUROLÓGICO ESTACIONARIO, HEMODINÁMICAMENTE EUCÁRDICA, CON CIFRAS TENSIONALES EN METAS BAJO MANEJO ANTIHIPERTENSIVO, ANÚRICA EN PACIENTE RENAL CRÓNICA EN TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL PERITONEAL, CON AGUDIZACIÓN DE LA MISMA; REALIZÁNDOSE SESIONES DIARIAS POR SERVICIO DE NEFROLOGÍA, CON CINÉTICA DE AZOADOS EN DESCENSO; RECIBIENDO SOPORTE NUTRICIONAL ENTERAL CON ALIMENTO CON PROPÓSITOS MÉDICOS ESPECIALES TIPO TIPO ENSURE CLINICAL EN MANEJO CON ESQUEMA DE INSULINA BASAL, REGULAR CONTROL METABÓLICO, AFEBRIL, CON DEPOSICIONES PRESENTES.

PACIENTE CON PATOLOGÍAS CRÍTICAS CRÓNICAS, YA REALIZADA TRAQUEOSTOMÍA Y GASTROSTOMÍA, CON CLÍNICA ESTACIONARIA, REQUIRIENTE DE CUIDADOS CRÓNICOS, POR LO QUE SE ENCUENTRA A LA ESPERA DE TRÁMITE ADMINISTRATIVO PARA TRASLADO A HOSTAL, POR LO PRONTO CONTINUO IGUALES ORDENES MEDICAS, ATENTOS A EVOLUCIÓN CLÍNICA.

SEGUIMIENTO POR LOS SERVICIOS DE TERAPIA FÍSICA CRÍTICA, TERAPIA OCUPACIONAL, FONOAUDIOLÓGIA PARA REHABILITACIÓN TEMPRANA Y PRECOZ DE PACIENTE, TERAPIA RESPIRATORIA INTEGRAL, PSICOLOGÍA CRÍTICA Y TRABAJO SOCIAL PARA REINTEGRO AL MEDIO Y NÚCLEO FAMILIAR, SOPORTE NUTRICIONAL Y METABÓLICO CRÍTICOS.

PACIENTE AMERITA ESTANCIA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS POR TRATARSE CON REQUERIMIENTO DE VENTILACIÓN MECÁNICA INVASIVA; ADEMÁS DE NECESIDAD DE MONITOREO CONTINUO, VIGILANCIA Estricta DE PARÁMETROS HEMODINÁMICOS, VENTILATORIOS, NEUROLÓGICOS Y METABÓLICOS.

Fecha: 11/04/2022: 10:37:21, Historia: Evolucion Clinica UCI, Prestador: DANIEL ENRIQUE ALVARADO CUETO, Especialidad: CUIDADO DEL PACIENTE EN ESTADO CRÍTICO

Análisis:

Se trata de femenina en la séptima década de la vida con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, extabaquista; con estancia en la unidad de cuidados crítico en marco de insuficiencia respiratoria en paciente en contexto de tuberculosis pleural diagnosticado por biopsia recibiendo esquema ripe; con intervención por servicio de cirugía de tórax: decorticación pulmonar, pleurectomía parietal con pleurodesis por toracoscopia.

Desde el punto de vista cardiovascular cursó con síndrome coronario tipo infarto al miocardio actualmente evolucionado; reporta ecocardiograma remodelado concéntrico con FEVI conservada 69%, disfunción diastólica tipo I, dilatación auricular izquierda leve, TAPSE 20 mm, sin intervención adicional.

Paciente renal crónica en diálisis peritoneal, con agudización de la misma; valorado por servicio de nefrología quien considera debe continuar con diálisis peritoneales diarias. Última con ultrafiltrado de 380 ml.

Desde el punto de vista infeccioso con cumplimiento de antibióticoterapia, ya resuelta bacteriemia por *Serratia Marcescens* con reporte de hemocultivo control negativo. Cultivo de secreción orotraqueal con crecimiento de *Enterobacter Cloacae* en cultivo previo y *Pseudomona Aeruginosa* en el nuevo, tratada. Paciente con cuadro inflamatorio crónico dado tuberculois pleural actualmente en manejo con esquema ripe desde el día de 01/03/2022.

Se encuentra a paciente con Glasgow 9/15 estacionario, sin sedolagesa; continua bajo soporte ventilatorio invasivo por traqueostomía modo aisto controlado por volumen, acoplada con adecuados índices de oxigenación al visoscopio; manejando frecuencias cardíacas en meta, cifras tensionales limítrofes sin uso de sopotes por lo que se suspende anti hipertensivo; anúrica en paciente renal crónica; con regular control metabólico requirente de ajuste de insulina basal y se inicia alimento con propósitos médicos especiales para paciente diabético tipo glucerna cada 8 horas además de licuados especiales para pacientes con sonda de gastrostomía.

Considero paciente con patologías críticas crónicas, ya realizada traqueostomía y gastrostomía, a la espera de traslado a unidad de cuidados crónicos. Se espera ventilador de hostal para pruebas y acople.

Seguimiento por los servicios de terapia física crítica, terapia ocupacional, fonoaudiología para rehabilitación temprana y precoz de paciente, terapia respiratoria integral, psicología crítica y trabajo social para reintegro al medio y núcleo familiar, soporte nutricional y metabólico críticos.

Debe permanecer en la unidad de cuidados intensivos por tratarse con requerimiento de ventilación mecánica invasiva; además de necesidad de monitoreo continuo, vigilancia estricta de parámetros hemodinámicos, ventilatorios, neurológicos y metabólicos.

Fecha: 11/04/2022: 12:32:35, Historia: Notas, Prestador: EDGARD EDUARDO GUTIERREZ PUENTE, Especialidad: CIRUGIA DEL TORAX

Asunto: NOTA DE CIRUGIA DE TORAX

Descripción: SOL BEATRIZ GARCIA MARQUEZ CC: 45430103EPS: COOSALUD EDAD: 66 AÑOS IMPRESIONES DIAGNOSTICAS 1. Tb pleural. 2. VENTILACION MECANICA PROLONGADA Subjetivo(S): Paciente bajo soporte ventilatorio. Objetivo(O): Paciente en Regulares condiciones generales, hidratada, sin soporte vasooactivo. Cuello simétrico, móvil sin adenopatías regionales, cánula de traqueostomía funcional conectada a ventilación mecánica. Murmullo vesicular disminuido en ambos campos pulmonares, sin sobreagregados. Abdomen globoso, gastrostomía funcional, sin masas palpables, catéter de diálisis implantado sin signos de infección y funcional. PATOLOGIA Necrosis compatible con TBC Análisis(A): Paciente en unidad de cuidados intensivos, bajo soporte ventilatorio mecanico a traves de traqueostomía, gastrostomía funcional. Estacionaria en su condición crítica, pendiente traslado al hostal para continuar manejo. ORDENES MEDICAS Por UCI

Fecha: 11/04/2022: 15:44:37, Historia: Evolucion Clinica UCI, Prestador: LUIS CARLOS JULIO NARVAEZ, Especialidad: CUIDADO DEL PACIENTE EN ESTADO CRÍTICO

Análisis:

Femenina en la séptima década de la vida con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, extabaquista, enfermedad renal crónica en terapia de remplazo renal a través de catéter peritoneal; que ingresa inicialmente a la unidad debido a falla ventilatoria aguda en relación a derrame pleural masivo que ameritó aseguramiento de la vía aérea, con estudio de líquido pleural con reporte de exudado linfocitario con ADA positivo, por lo que ante alta posibilidad de tuberculosis pleural recibía terapia antifímica, fue llevada a intervención quirúrgica por el servicio de cirugía de tórax el día 09/03/22, donde realizaron decorticación pulmonar + pleurectomía parietal + toma de biopsia + pleurodesis por toracoscopia, con reporte de biopsia de decorticación que evidencia tejido fibroconectivo comprometido por proceso inflamatorio agudo y crónico, zonas de necrosis y de pleura parietal que evidencia compromiso de proceso granulomatoso crónico necrotizante compatible con tuberculosis, continúa con terapia RIPE. Durante su curso en la unidad, su proceso se ve entorpecido por detrimento neurológico marcado en relación a uremia producto de agudización de enfermedad renal, que ameritó reintubación y ajuste de TRR peritoneal diarias, además cursó con síndrome coronario agudo tipo infarto agudo al miocardio sin elevación del ST, concomitante con choque séptico

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:20:11 p. m.

Admisión: AD715724

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: SOL BEATRIZ GARCIA MARQUEZ

EPICRISIS

requiriente de soporte vasoactivo, ya destetado. Además cursó con bacteriemia por *Serratia Marcescens* multisensible, con hemocultivo control negativo y foco pulmonar con cultivo de secreción traqueal con crecimiento de *enterobacter Cloacae* multisensible/último del 21/03/22 con *Pseudomonas auruginosa* multidrogorresistente recibiendo cobertura antibiotica con quinolóna de acuerdo a perfil de sensibilidad, completando el esquema propuesto. Actualmente en su postoperatorio de taqueostomía vía abierta, procedimiento realizado por servicio de ORL el 28/03/22, y debido imposibilidad de uso de vía oral dado componente neurológico por lo que se realizó gastrostomía endoscópica percutánea, realizado por servicio de gastroenterología el día 05/04/22 sin ninguna complicación.

De momento se encuentra en regulares condiciones generales, bajo ventilación mecánica a través de cánula de traqueostomía, modo AC/V en ventilador de hostal para parte de verificar acople y pruebas pretraslado, conservando adecuados índices de oxigenación al visoscopio, sin uso de sedantes, con estado neurológico estacionario; glasgow 9/15 puntos (AO: 3 RV: 1 RM 5); a nivel hemodinámico frecuencias cardiacas controladas y cifras tensionales limítrofes, a nivel renal anúrica en paciente renal crónica en terapia de reemplazo renal peritoneal, con agudización de la misma; realizándose sesiones diarias por servicio de nefrología, con cinética de azpados en descenso; regular control metabólico requiriente de ajuste de insulina basal y recibiendo alimento con propósitos médicos especiales para paciente diabético tipo glucerna cada 8 horas además de licuados especiales para pacientes con sonda de gastrostomía.

Considero paciente con patologías críticas crónicas, ya realizada traqueostomía y gastrostomía, a la espera de traslado a unidad de cuidados crónicos. De momento conectada a ventilador de hostal para pruebas y acople.

Seguimiento por los servicios de terapia física crítica, terapia ocupacional, fonoaudiología para rehabilitación temprana y precoz de paciente, terapia respiratoria integral, psicología crítica y trabajo social para reintegro al medio y núcleo familiar, soporte nutricional y metabólico críticos.

Debe permanecer en la unidad de cuidados intensivos por tratarse con requerimiento de ventilación mecánica invasiva; además de necesidad de monitoreo continuo, vigilancia estricta de parámetros hemodinámicos, ventilatorios, neurológicos y metabólicos.

Fecha: 11/04/2022: 21:45:49, Historia: Evolucion Clinica UCI, Prestador: JUAN PABLO ORTIZ SALAZAR, Especialidad: CUIDADO DEL PACIENTE EN ESTADO CRITICO

Análisis:

Laboratorios:

Na 127 K 3.1 Cl 93 Mg 1.2 P 4.3

Creat 4.6 BUN 93

Femenina en la séptima década de la vida con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, extabaquista, enfermedad renal crónica en terapia de reemplazo renal a través de cateter peritoneal; que ingresa inicialmente a la unidad debido a falla ventilatoria aguda en relación a derrame pleural masivo que ameritó aseguramiento de la vía aérea, con estudio de líquido pleural con reporte de exudado linfocitario con ada positivo, por lo que ante alta posibilidad de tuberculosis pleural recibía terapia antifimica, fue llevada a intervención quirúrgica por el servicio de cirugía de tórax el día 09/03/22, donde realizaron decorticación pulmonar + pleurectomía parietal + toma de biopsia + pleurodesis por toracosopia, con reporte de biopsia de decorticación que evidencia tejido fibroconectivo comprometido por proceso inflamatorio agudo y crónico, zonas de necrosis y de pleura parietal que evidencia compromiso de proceso granulomatoso crónico necrotizante compatible con tuberculosis, continua con terapia RIPE. Durante su curso en la unidad, su proceso se ve entorpecido por detrimento neurologico marcado en relación a uremia producto de agudización de enfermedad renal, que ameritó reintubación y ajuste de TRR peritoneal diarias, además cursó con síndrome coronario agudo tipo infarto agudo al miocardio sin elevación del ST, concomitante con choque séptico requiriente de soporte vasoactivo, ya destetado. Además cursó con bacteriemia por *Serratia Marcescens* multisensible, con hemocultivo control negativo y foco pulmonar con cultivo de secreción traqueal con crecimiento de *enterobacter Cloacae* multisensible/último del 21/03/22 con *Pseudomonas auruginosa* multidrogorresistente recibiendo cobertura antibiotica con quinolóna de acuerdo a perfil de sensibilidad, completando el esquema propuesto. Actualmente en su postoperatorio de taqueostomía vía abierta, procedimiento realizado por servicio de ORL el 28/03/22, y debido imposibilidad de uso de vía oral dado componente neurológico por lo que se realizó gastrostomía endoscópica percutánea, realizado por servicio de gastroenterología el día 05/04/22 sin ninguna complicación.

En ronda nocturna se encuentra en regulares condiciones generales, bajo ventilación mecánica a través de cánula de traqueostomía, modo AC/V en ventilador de hostal para parte de verificar acople y pruebas pretraslado, conservando adecuados índices de oxigenación al visoscopio, sin uso de sedantes, con estado neurológico estacionario; glasgow 9/15 puntos (AO: 3 RV: 1 RM 5); a nivel hemodinámico frecuencias cardiacas controladas y cifras tensionales limítrofes, a nivel renal anúrica en paciente renal crónica en terapia de reemplazo renal peritoneal, con agudización de la misma; realizándose sesiones diarias por servicio de nefrología, con cinética de azpados en descenso; regular control metabólico requiriente de ajuste de insulina basal y recibiendo alimento con propósitos médicos especiales para paciente diabético tipo glucerna cada 8 horas además de licuados especiales para pacientes con sonda de gastrostomía.

Solicito paraclínicos control que evidencian hipocalemia leve, hiponatremia, hipomagnesemia, hipocloremia, fosforo normal, azpados elevados en contexto de paciente renal cronica. Dada hipocalemia se indica iniciar reposición endovenosa y por gastrostomía, continua líquidos endovenosos con solución salina.

Considero paciente con patologías críticas crónicas, ya realizada traqueostomía y gastrostomía, a la espera de traslado a unidad de cuidados crónicos. De momento conectada a ventilador de hostal para pruebas y acople.

Seguimiento por los servicios de terapia física crítica, terapia ocupacional, fonoaudiología para rehabilitación temprana y precoz de paciente, terapia respiratoria integral, psicología crítica y trabajo social para reintegro al medio y núcleo familiar, soporte nutricional y metabólico críticos.

Debe permanecer en la unidad de cuidados intensivos por tratarse con requerimiento de ventilación mecánica invasiva; además de necesidad de monitoreo continuo, vigilancia estricta de parámetros hemodinámicos, ventilatorios, neurológicos y metabólicos.

Fecha: 12/04/2022: 08:35:49, Historia: Evolucion Clinica UCI, Prestador: DANIEL ENRIQUE ALVARADO CUETO, Especialidad: CUIDADO DEL PACIENTE EN ESTADO CRITICO

Análisis:

Se trata de femenina en la séptima década de la vida con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, extabaquista; con estancia en la unidad de cuidados crítico en marco de insuficiencia respiratoria en paciente en contexto de tuberculosis pleural diagnosticado por biopsia recibiendo esquema ripe; con intervención por servicio de cirugía de tórax: decorticación pulmonar, pleurectomía parietal con pleurodesis por toracosopia.

Desde el punto de vista cardiovascular cursó con síndrome coronario tipo infarto al miocardio actualmente evolucionado; reporta ecocardiograma remodelado concéntrico con FEM conservada 69%, disfunción diastólica tipo I, dilatación auricular izquierda leve, TAPSE 20 mm, sin intervención adicional.

Paciente renal crónica en diálisis peritoneal, con agudización de la misma; valorado por servicio de nefrología quien considera debe continuar con diálisis peritoneales diarias.

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:20:11 p. m.

Admisión: AD715724

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: SOL BEATRIZ GARCIA MARQUEZ

EPICRISIS

Desde el punto de vista infeccioso con cumplimiento de antibióticoterapia, ya resuelta bacteriemia por *Serratia Marcescens* con reporte de hemocultivo control negativo. Cultivo de secreción orotraqueal con crecimiento de *Enterobacter Cloacae* en cultivo previo y *Pseudomona Aeruginosa* en el nuevo, tratada. Paciente con cuadro inflamatorio crónico dado tuberculois pleural actualmente en manejo con esquema ripe desde el día de 01/03/2022.

Se encuentra a paciente con Glasgow 9/15 estacionario, sin sedolagesa; continua bajo soporte ventilatorio invasivo por traqueostomía modo aisto controlado por volumen, acoplada con adecuados índices de oxigenación al visoscopio; manejando frecuencias cardíacas en meta, cifras tensionales limítrofes sin uso de soprotes por lo que se suspende anti hipertensivo; anúrica en paciente renal crónica; con regular control metabólico requirente de ajuste el día de ayer de insulina basal, con indicación de alimento con propósitos médicos especiales para paciente diabético tipo glucerna cada 8 horas además de licuados especiales para pacientes con sonda de gastrostomía. Recibe reposición de potasio parenteral.

Considero paciente con patologías críticas crónicas, ya realizada traqueostomía y gastrostomía, a la espera de traslado a unidad de cuidados crónicos. Se espera ventilador de hostel para pruebas y acople.

Seguimiento por los servicios de terapia física crítica, terapia ocupacional, fonoaudiología para rehabilitación temprana y precoz de paciente, terapia respiratoria integral, psicología crítica y trabajo social para reintegro al medio y núcleo familiar, soporte nutricional y metabólico críticos.

Debe permanecer en la unidad de cuidados intensivos por tratarse con requerimiento de ventilación mecánica invasiva; además de necesidad de monitoreo continuo, vigilancia estricta de parámetros hemodinámicos, ventilatorios, neurológicos y metabólicos.

Fecha: 12/04/2022: 12:16:21, **Historia:** Evolución Clínica General, **Prestador:** EDGARD EDUARDO GUTIERREZ PUENTE, **Especialidad:** CIRUGIA DEL TORAX

Problema:

1. Tb pleural. 2. VENTILACION MECANICA PROLONGADA

Subjetivo:

Paciente bajo soporte ventilatorio.

Objetivo:

Paciente en Regulares condiciones generales, hidratada, sin soporte vasoactivo. Cuello simétrico, móvil sin adenopatías regionales, cánula de traqueostomía funcional conectada a ventilación mecánica. Murmullo vesicular disminuido en ambos campos pulmonares, sin sobreagregados. Abdomen globoso, gastrostomía funcional, sin masas palpables, catéter de diálisis implantado sin signos de infección y funcional. **PATOLOGIA** Necrosis compatible con TBC

Análisis:

Paciente en unidad de cuidados intensivos, bajo soporte ventilatorio mecanico a traves de traqueostomia, gastrostomia funcional. Sin presentar cambios en su condicion cronica, pendiente traslado al hostel para continuar manejo.

Fecha: 12/04/2022: 15:02:58, **Historia:** Evolucion Clinica UCI, **Prestador:** DANIEL ENRIQUE ALVARADO CUETO, **Especialidad:** CUIDADO DEL PACIENTE EN ESTADO CRITICO

Análisis:

Femenina en la séptima década de la vida con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, extabaquista, enfermedad renal crónica en terapia de remplazo renal a través de cateter peritoneal; que ingresa inicialmente a la unidad debido a falla ventilatoria aguda en relación a derrame pleural masivo que ameritó aseguramiento de la vía aérea, con estudio de liquido pleural con reporte de exudado linfocitario con ada positivo, por lo que ante alta posibilidad de tuberculosis pleural recibía terapia antifimica, fue llevada a intervención quirúrgica por el servicio de cirugía de tórax el día 09/03/22, donde realizaron decorticación pulmonar + pleurectomía parietal + toma de biopsia + pleurodesis por toracosopia, con reporte de biopsia de decorticación que evidencia tejido fibroconectivo comprometido por proceso inflamatorio agudo y crónico, zonas de necrosis y de pleura parietal que evidencia compromiso de proceso granulomatoso crónico necrotizante compatible con tuberculosis, continua con terapia RIPE. Durante su curso en la unidad, su proceso se ve entorpecido por detrimento neurologico marcado en relación a uremia producto de agudización de enfermedad renal, que ameritó reintubación y ajuste de TRR peritoneal diarias, ademas cursó con síndrome coronario agudo tipo infarto agudo al miocardio sin elevación del ST, concomitante con choque séptico requirente de soporte vasoactivo, ya destetado. Además cursó con bacteriemia por *Serratia Marcescens* multisensible, con hemocultivo control negativo y foco pulmonar con cultivo de secreción traqueal con crecimiento de *enterobacter Cloacae* multisensible/último del 21/03/22 con *Pseudomonas auruginosa* multidrogorresistente recibiendo cobertura antibiotica con quinolóna de acuerdo a perfil de sensibilidad, completando el esquema propuesto. Actualmente en su postoperatorio de taqueostomia via abierta, procedimiento realizado por servicio de ORL el 28/03/22, y debido imposibilidad de uso de vía oral dado componente neurológico por lo que se realizó gastrostomía endoscópica percutánea, realizado por servicio de gastroenterologia el día 05/04/22 sin ninguna complicación.

De momento se encuentra en regulares condiciones generales, bajo ventilación ventilación mecánica a través de cánula de traqueostomía, modo AC/V en ventilador de hostel para parte de verificar acople y pruebas pretraslado, conservando adecuados índices de oxigenación al visoscopio, sin uso de sedantes, con estado neurologico estacionario; glasgow 9/15 puntos (AO: 3 RV: 1 RM 5); a nivel hemodinamico frecuencias cardíacas controladas y cifras tensionales dentro de parámetros normales, a nivel renal anúrica en paciente renal crónica en terapia de reemplazo renal peritoneal, con agudización de la misma; realizandose sesiones diarias por servicio de nefrologia, con cinética de azpados en descenso; regular control metabólico requirente de ajuste de insulina basal y recibiendo alimento con propósitos médicos especiales para paciente diabético tipo glucerna cada 8 horas además de licuados especiales para pacientes con sonda de gastrostomía.

Considero paciente con patologías críticas crónicas, ya realizada traqueostomía y gastrostomía, a la espera de traslado a unidad de cuidados crónicos. De momento conectada a ventilador de hostel para pruebas y acople.

Seguimiento por los servicios de terapia física crítica, terapia ocupacional, fonoaudiología para rehabilitación temprana y precoz de paciente, terapia respiratoria integral, psicología crítica y trabajo social para reintegro al medio y núcleo familiar, soporte nutricional y metabólico críticos.

Debe permanecer en la unidad de cuidados intensivos por tratarse con requerimiento de ventilación mecánica invasiva; además de necesidad de monitoreo continuo, vigilancia estricta de parámetros hemodinámicos, ventilatorios, neurológicos y metabólicos.

Fecha: 12/04/2022: 20:48:18, **Historia:** Evolucion Clinica UCI, **Prestador:** JAIME SARMIENTO CALDERON, **Especialidad:** MEDICINA INTERNA

Análisis:

emenina en la séptima década de la vida con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, extabaquista, enfermedad renal crónica en terapia de remplazo renal a través de cateter peritoneal; que ingresa inicialmente a la unidad debido a falla ventilatoria aguda en relación a derrame pleural masivo que ameritó aseguramiento de la vía aérea, con estudio de liquido pleural con reporte de exudado linfocitario con ada positivo, por lo que ante alta posibilidad de tuberculosis pleural recibía terapia antifimica, fue llevada a intervención quirúrgica por el servicio de cirugía de tórax el día 09/03/22, donde realizaron decorticación pulmonar + pleurectomía parietal + toma de biopsia + pleurodesis por toracosopia, con reporte de biopsia de decorticación que evidencia tejido fibroconectivo comprometido por proceso inflamatorio agudo y crónico, zonas de necrosis y de pleura parietal que evidencia compromiso de proceso granulomatoso crónico necrotizante compatible con tuberculosis, continua con terapia RIPE. Durante su curso en la unidad, su proceso se ve entorpecido por detrimento neurologico marcado en relación a uremia producto de agudización de enfermedad renal, que ameritó reintubación y ajuste de TRR peritoneal diarias, ademas cursó con síndrome coronario agudo tipo infarto agudo al miocardio sin elevación del ST, concomitante con choque séptico

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:20:11 p. m.

Admisión: AD715724

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: SOL BEATRIZ GARCIA MARQUEZ

EPICRISIS

requiriente de soporte vasoactivo, ya destetado. Además cursó con bacteriemia por *Serratia Marcescens* multisensible, con hemocultivo control negativo y foco pulmonar con cultivo de secreción traqueal con crecimiento de *Enterobacter Cloacae* multisensible/último del 21/03/22 con *Pseudomonas aeruginosa* multidrogorresistente recibiendo cobertura antibiotica con quinolóna de acuerdo a perfil de sensibilidad, completando el esquema propuesto. Actualmente en su postoperatorio de taqueostomía vía abierta, procedimiento realizado por servicio de ORL el 28/03/22, y debido imposibilidad de uso de vía oral dado componente neurológico por lo que se realizó gastrostomía endoscópica percutánea, realizado por servicio de gastroenterología el día 05/04/22 sin ninguna complicación.

Actualmente en regulares condiciones generales, bajo ventilación mecánica a través de cánula de traqueostomía, modo AC/V en ventilador de hospital para parte de verificar acople y pruebas pretraslado, conservando adecuados índices de oxigenación al visoscopio, sin uso de sedantes, con estado neurológico estacionario; a nivel hemodinámico frecuencias cardíacas controladas y cifras tensionales dentro de parámetros normales, a nivel renal anúrica en paciente renal crónica en terapia de reemplazo renal peritoneal, con agudización de la misma; realizándose sesiones diarias por servicio de nefrología, con cinética de azoados en descenso; regular control metabólico requiriente de ajuste de insulina basal y recibiendo alimento con propósitos médicos especiales para paciente diabético tipo glucerna cada 8 horas además de licuados especiales para pacientes con sonda de gastrostomía.

Paciente con patologías críticas crónicas, ya realizada traqueostomía y gastrostomía, a la espera de traslado a unidad de cuidados crónicos. De momento conectada a ventilador de hospital para pruebas y acople. aguardamos a la espera de traslado de la misma por otro lado con reposición por hipokalemia por lo que se solicita ionograma control, resto de ordnes medicas iguales.

Seguimiento por los servicios de terapia física crítica, terapia ocupacional, fonoaudiología para rehabilitación temprana y precoz de paciente, terapia respiratoria integral, psicología crítica y trabajo social para reintegro al medio y núcleo familiar, soporte nutricional y metabólico críticos.

Debe permanecer en la unidad de cuidados intensivos por tratarse con requerimiento de ventilación mecánica invasiva; además de necesidad de monitoreo continuo, vigilancia estricta de parámetros hemodinámicos, ventilatorios, neurológicos y metabólicos.

Fecha: 13/04/2022: 10:09:43, **Historia:** Evolucion Clinica UCI, **Prestador:** DANIEL ENRIQUE ALVARADO CUETO, **Especialidad:** CUIDADO DEL PACIENTE EN ESTADO CRITICO

Análisis:

Se trata de femenina en la séptima década de la vida con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, extabaquista; con estancia en la unidad de cuidados crítico en marco de insuficiencia respiratoria en paciente en contexto de tuberculosis pleural diagnosticado por biopsia recibiendo esquema ripe; con intervención por servicio de cirugía de tórax: decorticación pulmonar, pleurectomía parietal con pleurodesis por toracoscopia.

Desde el punto de vista cardiovascular cursó con síndrome coronario tipo infarto al miocardio actualmente evolucionado; reporta ecocardiograma remodelado concéntrico con FEV conservada 69%, disfunción diastólica tipo I, dilatación auricular izquierda leve, TAPSE 20 mm, sin intervención adicional.

Paciente renal crónica en diálisis peritoneal, con agudización de la misma; valorado por servicio de nefrología quien considera debe continuar con diálisis peritoneales diarias.

Desde el punto de vista infeccioso con cumplimiento de antibioticoterapia, ya resuelta bacteriemia por *Serratia Marcescens* con reporte de hemocultivo control negativo. Cultivo de secreción orotraqueal con crecimiento de *Enterobacter Cloacae* en cultivo previo y *Pseudomonas Aeruginosa* en el nuevo, tratada. Paciente con cuadro inflamatorio crónico dado tuberculois pleural actualmente en manejo con esquema ripe desde el día de 01/03/2022.

Se encuentra a paciente con Glasgow 9/15 estacionario, sin sedolagesa; continua bajo soporte ventilatorio invasivo por traqueostomía modo aisto controlado por volumen, acoplada con adecuados índices de oxigenación al visoscopio; manejando frecuencias cardíacas y cifras tensionales en meta sin uso de soprote; anúrica en paciente renal crónica; con regular control metabólico se suspende insulina basal y se optimiza aporte nutricional con alimento con propósitos médicos especiales para paciente diabético tipo glucerna cada 4 horas.

Considero paciente con patologías críticas crónicas, ya realizada traqueostomía y gastrostomía, a la espera de traslado a unidad de cuidados crónicos. Se encuentra con ventilador de hospital, acoplada. Se suspende reposición de potasio dado corrección de hipokalemia.

Seguimiento por los servicios de terapia física crítica, terapia ocupacional, fonoaudiología para rehabilitación temprana y precoz de paciente, terapia respiratoria integral, psicología crítica y trabajo social para reintegro al medio y núcleo familiar, soporte nutricional y metabólico críticos.

Debe permanecer en la unidad de cuidados intensivos por tratarse con requerimiento de ventilación mecánica invasiva; además de necesidad de monitoreo continuo, vigilancia estricta de parámetros hemodinámicos, ventilatorios, neurológicos y metabólicos.

Fecha: 13/04/2022: 15:20:14, **Historia:** Evolucion Clinica UCI, **Prestador:** LUIS CARLOS JULIO NARVAEZ, **Especialidad:** CUIDADO DEL PACIENTE EN ESTADO CRITICO

Análisis:

Femenina en la séptima década de la vida con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, extabaquista, enfermedad renal crónica en terapia de reemplazo renal a través de cateter peritoneal; que ingresa inicialmente a la unidad debido a falla ventilatoria aguda en relación a derrame pleural masivo que ameritó aseguramiento de la vía aérea, con estudio de liquido pleural con reporte de exudado linfocitario con ada positivo, por lo que ante alta posibilidad de tuberculosis pleural recibía terapia antifimica, fue llevada a intervención quirúrgica por el servicio de cirugía de tórax el día 09/03/22, donde realizaron decorticación pulmonar + pleurectomía parietal + toma de biopsia + pleurodesis por toracoscopia, con reporte de biopsia de decorticación que evidencia tejido fibroconectivo comprometido por proceso inflamatorio agudo y crónico, zonas de necrosis y de pleura parietal que evidencia compromiso de proceso granulomatoso crónico necrotizante compatible con tuberculosis, continua con terapia RIPE. Durante su curso en la unidad, su proceso se ve entorpecido por detrimento neurológico marcado en relación a uremia producto de agudización de enfermedad renal, que ameritó reintubación y ajuste de TRR peritoneal diarias, ademas cursó con síndrome coronario agudo tipo infarto agudo al miocardio sin elevación del ST, concomitante con choque séptico requiriente de soporte vasoactivo, ya destetado. Además cursó con bacteriemia por *Serratia Marcescens* multisensible, con hemocultivo control negativo y foco pulmonar con cultivo de secreción traqueal con crecimiento de *Enterobacter Cloacae* multisensible/último del 21/03/22 con *Pseudomonas aeruginosa* multidrogorresistente recibiendo cobertura antibiotica con quinolóna de acuerdo a perfil de sensibilidad, completando el esquema propuesto. Actualmente en su postoperatorio de taqueostomía vía abierta, procedimiento realizado por servicio de ORL el 28/03/22, y debido imposibilidad de uso de vía oral dado componente neurológico por lo que se realizó gastrostomía endoscópica percutánea, realizado por servicio de gastroenterología el día 05/04/22 sin ninguna complicación.

De momento se encuentra en regulares condiciones generales, bajo ventilación mecánica a través de cánula de traqueostomía, modo AC/V en ventilador de hospital, buen acople, conservando adecuados índices de oxigenación al visoscopio, sin uso de sedantes, con estado neurológico estacionario; glasgow 9/15 puntos (AO: 3 RV: 1 RM: 5); a nivel hemodinámico frecuencias cardíacas controladas y cifras tensionales dentro de parámetros normales, a nivel renal anúrica en paciente renal crónica en terapia de reemplazo renal peritoneal, con agudización de la misma; realizándose sesiones diarias por servicio de

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:20:11 p. m.

Admisión: AD715724

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: SOL BEATRIZ GARCIA MARQUEZ

EPICRISIS

nefrología, con cinética de azoados en descenso; mejor control control metabólico con ajuste de insulina basal y recibiendo alimento con propósitos médicos especiales para paciente diabético tipo glucerna cada 8 horas además de licuados especiales para pacientes con sonda de gastrostomía.

Considero paciente con patologías críticas crónicas, ya realizada traqueostomía y gastrostomía, a la espera de traslado a unidad de cuidados crónicos. De momento conectada a ventilador de hostal, buen acople, ya completó 24 horas en pruebas pretraslado, por lo que se insiste en el mismo.

Seguimiento por los servicios de terapia física crítica, terapia ocupacional, fonoaudiología para rehabilitación temprana y precoz de paciente, terapia respiratoria integral, psicología crítica y trabajo social para reintegro al medio y núcleo familiar, soporte nutricional y metabólico críticos.

Debe permanecer en la unidad de cuidados intensivos por tratarse con requerimiento de ventilación mecánica invasiva; además de necesidad de monitoreo continuo, vigilancia estricta de parámetros hemodinámicos, ventilatorios, neurológicos y metabólicos.

Fecha: 13/04/2022: 18:28:21, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: EDGARD EDUARDO GUTIERREZ PUENTE, Especialidad: CIRUGIA DEL TORAX

Problema:

1. Tb pleural. 2. VENTILACION MECANICA PROLONGADA

Subjetivo:

Paciente bajo soporte ventilatorio.

Objetivo:

Paciente en Regulares condiciones generales, hidratada, sin soporte vasoactivo. Cuello simétrico, móvil sin adenopatías regionales, cánula de traqueostomía funcional conectada a ventilación mecánica. Murmullo vesicular disminuido en ambos campos pulmonares, sin sobreagregados. Abdomen globoso, gastrostomía funcional, sin masas palpables, catéter de diálisis implantado sin signos de infección y funcional. PATOLOGIA Necrosis compatible con TBC

Análisis:

Paciente en unidad de cuidados intensivos, bajo soporte ventilatorio mecanico a traves de traqueostomia, gastrostomia funcional. Sin presentar cambios en su condicion cronica, pendiente traslado al hostal para continuar manejo.

Fecha: 13/04/2022: 21:52:30, Historia: Evolucion Clinica UCI, Prestador: ALVARO ANDRES ZAPATA LEAL, Especialidad: CUIDADO DEL PACIENTE EN ESTADO CRITICO

Análisis:

Femenina en la séptima década de la vida con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, extabaquista, enfermedad renal crónica en terapia de remplazo renal a través de cateter peritoneal; que ingresa inicialmente a la unidad debido a falla ventilatoria aguda en relación a derrame pleural masivo que ameritó aseguramiento de la vía aérea, con estudio de liquido pleural con reporte de exudado linfocitario con ada positivo, por lo que ante alta posibilidad de tuberculosis pleural recibía terapia antifimica, fue llevada a intervención quirúrgica por el servicio de cirugía de tórax el día 09/03/22, donde realizaron decorticación pulmonar + pleurectomía parietal + toma de biopsia + pleurodesis por toracosopia, con reporte de biopsia de decorticación que evidencia tejido fibroconectivo comprometido por proceso inflamatorio agudo y crónico, zonas de necrosis y de pleura parietal que evidencia compromiso de proceso granulomatoso crónico necrotizante compatible con tuberculosis, continua con terapia RIPE. Durante su curso en la unidad, su proceso se ve entorpecido por detrimento neurologico marcado en relación a uremia producto de agudización de enfermedad renal, que ameritó reintubación y ajuste de TRR peritoneal diarias, ademas cursó con síndrome coronario agudo tipo infarto agudo al miocardio sin elevación del ST, concomitante con choque séptico requirente de soporte vasoactivo, ya destetado. Además cursó con bacteriemia por Serratia Marcescens multisensible, con hemocultivo control negativo y foco pulmonar con cultivo de secreción traqueal con crecimiento de enterobacter Cloacae multisensible/último del 21/03/22 con Pseudomonas auruginosa multidrogorresistente recibiendo cobertura antibiotica con quinolóna de acuerdo a perfil de sensibilidad, completando el esquema propuesto. Actualmente en su postoperatorio de taqueostomia via abierta, procedimiento realizado por servicio de ORL el 28/03/22, y debido imposibilidad de uso de vía oral dado componente neurológico por lo que se realizó gastrostomía endoscópica percutánea, realizado por servicio de gastroenterologia el día 05/04/22 sin ninguna complicación.

Actualmente en regulares condiciones generales, bajo ventilación ventilación mecánica a través de cánula de traqueostomia, modo AC/V en ventilador de hostal, desacoplada, desaturada, sin uso de sedantes, con estado neurologico estacionario; glasgow 9/15 puntos (AO: 3 RV: 1 RM: 5); a nivel hemodinamico frecuencias cardiacas controladas y cifras tensionales dentro de parámetros normales, a nivel renal anúrica en paciente renal crónica en terapia de reemplazo renal peritoneal, pendiente nueva sesión, paciente quien tolera soporte nutricional con alimento tipo Glucerna 237 ML por gastrostomia , conservando adecuado control metabolico, afebril no sirs.

Paciente femenina quien evoluciona en marco de diagnosticos descritos de momento con desacople ventilatorio a ventilador de Hostal, por lo que indico paso a ventilador institucional, mejorando acople ventilatorio e indices oximetricos, por otra parte se recibe información de hostal quienes manifiestan no haber procedido a traslado de paciente previamente dado a a que aguardan a confirmación de empresa DAMTA encargada de dialisis de paciente disponibilidad para la continuidad de las dialisis en dicha institución, de momento indico continuidad de manejo medico instaurado y vigilancia estricta de sinos vitales, pronostico sujeto a evolución.

Seguimiento por los servicios de terapia física crítica, terapia ocupacional, fonoaudiología para rehabilitación temprana y precoz de paciente, terapia respiratoria integral, psicología crítica y trabajo social para reintegro al medio y núcleo familiar, soporte nutricional y metabólico críticos.

Debe permanecer en la unidad de cuidados intensivos por tratarse con requerimiento de ventilación mecánica invasiva; además de necesidad de monitoreo continuo, vigilancia estricta de parámetros hemodinámicos, ventilatorios, neurológicos y metabólicos.

Fecha: 14/04/2022: 09:40:24, Historia: Evolucion Clinica UCI, Prestador: DANIEL ENRIQUE ALVARADO CUETO, Especialidad: CUIDADO DEL PACIENTE EN ESTADO CRITICO

Análisis:

Se trata de femenina en la séptima década de la vida con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, extabaquista; con estancia en la unidad de cuidados crítico en marco de insuficiencia respiratoria en paciente en contexto de tuberculosis pleural diagnóstico por biopsia recibiendo esquema ripe; con intervención por servicio de cirugía de tórax: decorticación pulmonar, pleurectomía parietal con pleurodesis por toracosopia.

Desde el punto de vista cardiovascular cursó con síndrome coronario tipo anfrato al miocardio actualmente evolucionado; reporta ecocardiograma remodelado concéntrico con FEM conservada 69%, disfunción diastólica tipo I, dilatación auricular izquierda leve, TAPSE 20 mm, sin intervención adicional.

Paciente renal crónica en diálisis peritoneal, con agudización de la misma; valorado por servicio de nefrología quien cosnidera debe continuar con dialisis peritoneales diarias.

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:20:11 p. m.

Admisión: AD715724

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: SOL BEATRIZ GARCIA MARQUEZ

EPICRISIS

Desde el punto de vista infeccioso con cumplimiento de antibioticoterapia, ya resuelta bacteriemia por *Serratia Marcescens* con reporte de hemocultivo control negativo. Cultivo de secreción orotraqueal con crecimiento de *Enterobacter Cloacae* en cultivo previo y *Pseudomona Aeruginosa* en el nuevo, tratada. Paciente con cuadro inflamatorio crónico dado tuberculois pleural actualmente en manejo con esquema ripe desde el día de 01/03/2022.

Se encuentra a paciente con Glasgow 9/15 estacionario, sin sedonalgias; continua bajo soporte ventilatorio invasivo por traqueostomía modo aisto controlado por volumen, acoplada con adecuados índices de oxigenación al visoscopio; manejando frecuencias cardíacas y cifras tensionales en meta sin uso de soprotes; anúrica en paciente renal crónica; con mejor control metabólico (glucometrías: 90-94-98 mg/dl) recibiendo soporte nutricional con alimento con propósitos médicos especiales para paciente diabético tipo glucerna cada 4 horas.

Considero paciente con patologías críticas crónicas, ya realizada traqueostomía y gastrostomía, a la espera de traslado a unidad de cuidados crónicos. Se encuentra con ventilador de hostal.

Seguimiento por los servicios de terapia física crítica, terapia ocupacional, fonoaudiología para rehabilitación temprana y precoz de paciente, terapia respiratoria integral, psicología crítica y trabajo social para reintegro al medio y núcleo familiar, soporte nutricional y metabólico críticos.

Debe permanecer en la unidad de cuidados intensivos por tratarse con requerimiento de ventilación mecánica invasiva; además de necesidad de monitoreo continuo, vigilancia estricta de parámetros hemodinámicos, ventilatorios, neurológicos y metabólicos.

Fecha: 14/04/2022: 10:32:59, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: EDGARD EDUARDO GUTIERREZ PUENTE, Especialidad: CIRUGIA DEL TORAX

Problema:

1. Tb pleural. 2. VENTILACION MECANICA PROLONGADA

Subjetivo:

Paciente bajo soporte ventilatorio.

Objetivo:

Paciente en Regulares condiciones generales, hidratada, sin soporte vasoactivo. Cuello simétrico, móvil sin adenopatías regionales, cánula de traqueostomía funcional conectada a ventilación mecánica. Murmullo vesicular disminuido en ambos campos pulmonares, sin sobreagregados. Abdomen globoso, gastrostomía funcional, sin masas palpables, catéter de diálisis implantado sin signos de infección y funcional. PATOLOGIA Necrosis compatible con TBC

Análisis:

Paciente en unidad de cuidados intensivos, bajo soporte ventilatorio mecanico a traves de traqueostomia, gastrostomia funcional. Sin presentar cambios en su condicion cronica, pendiente traslado al hostal para continuar manejo

Fecha: 14/04/2022: 13:23:35, Historia: Evolucion Clinica UCI, Prestador: LUIS CARLOS JULIO NARVAEZ, Especialidad: CUIDADO DEL PACIENTE EN ESTADO CRITICO

Análisis:

Femenina en la séptima década de la vida con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, extabaquista, enfermedad renal crónica en terapia de remplazo renal a través de cateter peritoneal; que ingresa inicialmente a la unidad debido a falla ventilatoria aguda en relación a derrame pleural masivo que ameritó aseguramiento de la vía aérea, con estudio de liquido pleural con reporte de exudado linfocitario con ada positivo, por lo que ante alta posibilidad de tuberculosis pleural recibía terapia antifimica, fue llevada a intervención quirúrgica por el servicio de cirugía de tórax el día 09/03/22, donde realizaron decorticación pulmonar + pleurectomía parietal + toma de biopsia + pleurodesis por toracosopia, con reporte de biopsia de decorticación que evidencia tejido fibroconectivo comprometido por proceso inflamatorio agudo y crónico, zonas de necrosis y de pleura parietal que evidencia compromiso de proceso granulomatoso crónico necrotizante compatible con tuberculosis, continua con terapia RIPE. Durante su curso en la unidad, su proceso se ve entorpecido por detrimento neurologico marcado en relación a uremia producto de agudización de enfermedad renal, que ameritó reintubación y ajuste de TRR peritoneal diarias, ademas cursó con síndrome coronario agudo tipo infarto agudo al miocardio sin elevación del ST, actualmente evolucionado; reporta ecocardiograma remodelado concéntrico con FEVI conservada 69%, disfunción diastólica tipo I, dilatación auricular izquierda leve, TAPSE 20 mm, sin intervención adicional. Concomitantemente cursó con choque séptico requirente de soporte vasoactivo, ya resuelto y soporte destetado. Además cursó con bacteriemia por *Serratia Marcescens* multisensible, con hemocultivo control negativo y foco pulmonar con cultivo de secreción traqueal con crecimiento de *enterobacter Cloacae* multisensible/último del 21/03/22 con *Pseudomonas auruginosa* multidrogorresistente recibiendo cobertura antibiotica con quinolóna de acuerdo a perfil de sensibilidad, completando el esquema propuesto. Actualmente en su postoperatorio de taqueostomia via abierta, procedimiento realizado por servicio de ORL el 28/03/22, y debido imposibilidad de uso de vía oral dado componente neurológico por lo que se realizó gastrostomia endoscópica percutánea, realizado por servicio de gastroenterologia el día 05/04/22 sin ninguna complicación.

Actualmente en regulares condiciones generales, bajo ventilación ventilación mecánica a través de cánula de traqueostomia, modo AC/V en ventilador de hostal, normoacoplada, sin uso de sedantes, con estado neurologico estacionario; glasgow 9/15 puntos (AO: 3 RV: 1 RM 5); a nivel hemodinamico frecuencias cardiacas controladas y cifras tensionales dentro de parámetros normales, a nivel renal anúrica en paciente renal crónica en terapia de reemplazo renal peritoneal, pendiente nueva sesión, paciente quien recibiendo soporte nutricional con alimento con propósitos médicos especiales para paciente diabético tipo glucerna cada 4 horas.

Considero paciente con patologías críticas crónicas, ya realizada traqueostomía y gastrostomía, a la espera de traslado a unidad de cuidados crónicos. Se encuentra con ventilador de hostal. En ronfa médica de la tarde no realizo cambios en manejo previamente instaurado.

Seguimiento por los servicios de terapia física crítica, terapia ocupacional, fonoaudiología para rehabilitación temprana y precoz de paciente, terapia respiratoria integral, psicología crítica y trabajo social para reintegro al medio y núcleo familiar, soporte nutricional y metabólico críticos.

Debe permanecer en la unidad de cuidados intensivos por tratarse con requerimiento de ventilación mecánica invasiva; además de necesidad de monitoreo continuo, vigilancia estricta de parámetros hemodinámicos, ventilatorios, neurológicos y metabólicos.

Fecha: 14/04/2022: 21:53:03, Historia: Evolucion Clinica UCI, Prestador: FELIPE HERRERARUIZ, Especialidad: CUIDADO DEL PACIENTE EN ESTADO CRITICO

Análisis:

Se trata de femenina en la séptima década de la vida con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, extabaquista; con estancia en la unidad de cuidados crítico en marco de insuficiencia respiratoria en paciente en contexto de tuberculosis pleural diagnosticado por biopsia recibiendo esquema ripe; con intervención por servicio de cirugía de tórax: decorticación pulmonar, pleurectomía parietal con pleurodesis por toracosopia.

Desde el punto de vista cardiovascular cursó con síndrome coronario tipo anfarto al miocardio actualmente evolucionado; reporta ecocardiograma remodelado concéntrico con FEVI conservada 69%, disfunción diastólica tipo I, dilatación auricular izquierda leve, TAPSE 20 mm, sin intervención adicional.

Paciente renal crónica en diálisis peritoneal, con agudización de la misma; valorado por servicio de nefrologia quien considera debe continuar con dialisis pertioneales diarias.

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:20:11 p. m.

Admisión: AD715724

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: SOL BEATRIZ GARCIA MARQUEZ

EPICRISIS

Desde el punto de vista infeccioso presentó bacteremia resuelta por *Serratia Marcescens*, por lo que cumplió cubrimiento antibiótico y cuenta con hemocultivo control negativo. Cultivo de secreción orotraqueal con crecimiento de *Enterobacter Cloacae* en cultivo previo y *Pseudomona Aeruginosa* en el nuevo, tratada. Paciente con cuadro inflamatorio crónico dado tuberculois pleural actualmente en manejo con esquema ripe desde el día de 01/03/2022.

Se encuentra a paciente con estado neurológico estacionario, sin sedoanalgesia, continua bajo soporte ventilatorio invasivo por traqueostomía modo aisto controlado por volumen, acoplada con oximetrías de pulso en metas, frecuencia cardíaca y cifras tensionales en meta sin uso de soprotes; anúrica en paciente renal crónica; tolerando soportenutricional enteral con alimento con propósitos médicos especiales para paciente diabético tipo glucerna cada 4 horas, control metabólico aceptable.

Considero paciente con patologías críticas crónicas, ya realizada traqueostomía y gastrostomía, a la espera de traslado a unidad de cuidados crónicos. Se encuentra conecta a ventilador de unidad de destino, continua manejo médico.

Seguimiento por los servicios de terapia física crítica, terapia ocupacional, fonoaudiología para rehabilitación temprana y precoz de paciente, terapia respiratoria integral, psicología crítica y trabajo social para reintegro al medio y núcleo familiar, soporte nutricional y metabólico críticos.

Debe permanecer en la unidad de cuidados intensivos por tratarse con requerimiento de ventilación mecánica invasiva; además de necesidad de monitoreo continuo, vigilancia estricta de parámetros hemodinámicos, ventilatorios, neurológicos y metabólicos.

Fecha: 15/04/2022: 08:12:43, Historia: Evolucion Clinica UCI, Prestador: ALVARO ANDRES ZAPATA LEAL, Especialidad: CUIDADO DEL PACIENTE EN ESTADO CRITICO

Análisis:

Se trata de femenina en la séptima década de la vida con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, extabaquista; con estancia en la unidad de cuidados crítico en marco de insuficiencia respiratoria en paciente en contexto de tuberculosis pleural diagnosticado por biopsia recibiendo esquema ripe; con intervención por servicio de cirugía de tórax: decorticación pulmonar, pleurectomía parietal con pleurodesis por toracoscopia.

Desde el punto de vista cardiovascular cursó con síndrome coronario tipo anftarto al miocardio actualmente evolucionado; reporta ecocardiograma remodelado concéntrico con FEV conservada 69%, disfunción diastólica tipo I, dilatación auricular izquierda leve, TAPSE 20 mm, sin intervención adicional.

Paciente renal crónica en diálisis peritoneal, con agudización de la misma; valorado por servicio de nefrología quien cosnidera debe continuar con dialisis pertioneales diarias.

Desde el punto de vista infeccioso con cumplimiento de antibioticoterapia, ya resuelta bacteriemia por *Serratia Marcescens* con reporte de hemocultivo control negativo. Cultivo de secreción orotraqueal con crecimiento de *Enterobacter Cloacae* en cultivo previo y *Pseudomona Aeruginosa* en el nuevo, tratada. Paciente con cuadro inflamatorio crónico dado tuberculois pleural actualmente en manejo con esquema ripe desde el día de 01/03/2022.

Se encuentra a paciente con Glasgow 9/15 estacionario, sin sedonalagesa; continua bajo soporte ventilatorio invasivo por traqueostomía modo aisto controlado por volumen, acoplada con adecuados índices de oxigenación al visoscopio; manejando frecuencias cardíacas y cifras tensionales en meta sin uso de soprotes; anúrica en paciente renal crónica; con mal control metabólico (glucometrias: 9273-110-391 mg/dl) recibiendo soporte nutricional con alimento con propósitos médicos especiales para paciente diabético tipo glucerna cada 4 horas.

Considero paciente con patologías críticas crónicas, ya realizada traqueostomía y gastrostomía, a la espera de traslado a unidad de cuidados crónicos. Se encuentra con ventilador de hostal.

Seguimiento por los servicios de terapia física crítica, terapia ocupacional, fonoaudiología para rehabilitación temprana y precoz de paciente, terapia respiratoria integral, psicología crítica y trabajo social para reintegro al medio y núcleo familiar, soporte nutricional y metabólico críticos.

Debe permanecer en la unidad de cuidados intensivos por tratarse con requerimiento de ventilación mecánica invasiva; además de necesidad de monitoreo continuo, vigilancia estricta de parámetros hemodinámicos, ventilatorios, neurológicos y metabólicos.

Fecha: 15/04/2022: 12:07:27, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: EDGARD EDUARDO GUTIERREZ PUENTE, Especialidad: CIRUGIA DEL TORAX

Problema:

1. Tb pleural. 2. VENTILACION MECANICA PROLONGADA

Subjetivo:

Paciente bajo soporte ventilatorio.

Objetivo:

Paciente en Regulares condiciones generales, hidratada, sin soporte vasoactivo. Cuello simétrico, móvil sin adenopatías regionales, cánula de traqueostomía funcional conectada a ventilación mecánica. Murmullo vesicular disminuido en ambos campos pulmonares, sin sobreagregados. Abdomen globoso, gastrostomía funcional, sin masas palpables, catéter de diálisis implantado sin signos de infección y funcional. PATOLOGIA Necrosis compatible con TBC

Análisis:

Paciente en unidad de cuidados intensivos, bajo soporte ventilatorio mecanico a traves de traqueostomia, gastrostomia funcional. Sin presentar cambios en su condicion cronica, pendiente traslado al hostal para continuar manejo, se encuentra con ventilador de transporte, bien acoplada.

Fecha: 15/04/2022: 16:52:44, Historia: Evolucion Clinica UCI, Prestador: ALVARO ANDRES ZAPATA LEAL, Especialidad: CUIDADO DEL PACIENTE EN ESTADO CRITICO

Análisis:

Femenina en la séptima década de la vida con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, extabaquista, enfermedad renal crónica en terapia de remplazo renal a través de cateter peritoneal; que ingresa inicialmente a la unidad debido a falla ventilatoria aguda en relación a derrame pleural masivo que ameritó aseguramiento de la vía aérea, con estudio de liquido pleural con reporte de exudado linfocitario con ada positivo, por lo que ante alta posibilidad de tuberculosis pleural recibía terapia antifimica, fue llevada a intervención quirúrgica por el servicio de cirugía de tórax el día 09/03/22, donde realizaron decorticación pulmonar + pleurectomía parietal + toma de biopsia + pleurodesis por toracoscopia, con reporte de biopsia de decorticación que evidencia tejido fibroconectivo comprometido por proceso inflamatorio agudo y crónico, zonas de necrosis y de pleura parietal que evidencia compromiso de proceso granulomatoso crónico necrotizante compatible con tuberculosis, continua con terapia RIPE. Durante su curso en la unidad, su proceso se ve entorpecido por detrimento neurologico marcado en relación a uremia producto de agudización de enfermedad renal, que ameritó reintubación y ajuste de TRR peritoneal diarias, ademas cursó con síndrome coronario agudo tipo infarto agudo al miocardio sin elevación del ST, actualmente evolucionado; reporta ecocardiograma remodelado concéntrico con FEV conservada 69%, disfunción diastólica tipo I, dilatación auricular izquierda leve, TAPSE 20 mm, sin

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:20:11 p. m.

Admisión: AD715724

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: SOL BEATRIZ GARCIA MARQUEZ

EPICRISIS

intervención adicional. Concomitantemente cursó con choque séptico requirente de soporte vasoactivo, ya resuelto y soporte destetado. Además cursó con bacteriemia por *Serratia Marcescens* multisensible, con hemocultivo control negativo y foco pulmonar con cultivo de secreción traqueal con crecimiento de *enterobacter Cloacae* multisensible/último del 21/03/22 con *Pseudomonas auruginosa* multidrogorresistente recibiendo cobertura antibiotica con quinolóna de acuerdo a perfil de sensibilidad, completando el esquema propuesto. Actualmente en su postoperatorio de taqueostomía vía abierta, procedimiento realizado por servicio de ORL el 28/03/22, y debido imposibilidad de uso de vía oral dado componente neurológico por lo que se realizó gastrostomía endoscópica percutánea, realizado por servicio de gastroenterología el día 05/04/22 sin ninguna complicación.

Actualmente en regulares condiciones generales, bajo ventilación mecánica a través de cánula de traqueostomía, modo AC/V en ventilador de hostal, de momento desacoplada, desaturada, sin uso de sedantes, con estado neurológico estacionario; glasgow 9/15 puntos (AO: 3 RV: 1 RM: 5); a nivel hemodinámico frecuencias cardíacas con tendencia a la bradicardia y cifras tensionales dentro de parámetros normales, a nivel renal anúrica en paciente renal crónica en terapia de reemplazo renal peritoneal, pendiente nueva sesión, paciente quien tolera soporte nutricional con alimento tipo Glucerna 237 ML por gastrostomía, regular control metabólico, de momento distendida por lo que indico diferir en el momento e instaurar aporte calórico con dextrosados.

Paciente femenina quien evoluciona en marco de diagnósticos descritos de momento con desacople ventilatorio a ventilador de Hostal, por lo que indico paso a ventilador institucional, se indica 150 mcg de derivado opiáceo dosis única, para facilitar acople ventilatorio e índices oximétricos, de momento en sesión de diálisis convencional dicha institución, de momento indico continuidad de manejo médico instaurado y vigilancia estricta de signos vitales, pronóstico sujeto a evolución.

Seguimiento por los servicios de terapia física crítica, terapia ocupacional, fonoaudiología para rehabilitación temprana y precoz de paciente, terapia respiratoria integral, psicología crítica y trabajo social para reintegro al medio y núcleo familiar, soporte nutricional y metabólico críticos.

Debe permanecer en la unidad de cuidados intensivos por tratarse con requerimiento de ventilación mecánica invasiva; además de necesidad de monitoreo continuo, vigilancia estricta de parámetros hemodinámicos, ventilatorios, neurológicos y metabólicos.

Fecha: 15/04/2022: 20:16:18, Historia: Evolucion Clínica UCI, Prestador: JUAN PABLO ORTIZ SALAZAR, Especialidad: CUIDADO DEL PACIENTE EN ESTADO CRÍTICO

Análisis:

Femenina en la séptima década de la vida con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, exabiquista, enfermedad renal crónica en terapia de reemplazo renal a través de catéter peritoneal; que ingresa inicialmente a la unidad debido a falla ventilatoria aguda en relación a derrame pleural masivo que ameritó aseguramiento de la vía aérea, con estudio de líquido pleural con reporte de exudado linfocitario con ADA positivo, por lo que ante alta posibilidad de tuberculosis pleural recibía terapia antifúngica, fue llevada a intervención quirúrgica por el servicio de cirugía de tórax el día 09/03/22, donde realizaron decorticación pulmonar + pleurectomía parietal + toma de biopsia + pleurodesis por toracoscopia, con reporte de biopsia de decorticación que evidencia tejido fibroconectivo comprometido por proceso inflamatorio agudo y crónico, zonas de necrosis y de pleura parietal que evidencia compromiso de proceso granulomatoso crónico necrotizante compatible con tuberculosis, continúa con terapia RIPE. Durante su curso en la unidad, su proceso se ve entorpecido por detrimento neurológico marcado en relación a uremia producto de agudización de enfermedad renal, que ameritó reintubación y ajuste de TRR peritoneal diarias, además cursó con síndrome coronario agudo tipo infarto agudo al miocardio sin elevación del ST, actualmente evolucionado; reporta ecocardiograma remodelado concéntrico con FEM conservada 69%, disfunción diastólica tipo I, dilatación auricular izquierda leve, TAPSE 20 mm, sin intervención adicional. Concomitantemente cursó con choque séptico requirente de soporte vasoactivo, ya resuelto y soporte destetado. Además cursó con bacteriemia por *Serratia Marcescens* multisensible, con hemocultivo control negativo y foco pulmonar con cultivo de secreción traqueal con crecimiento de *enterobacter Cloacae* multisensible/último del 21/03/22 con *Pseudomonas auruginosa* multidrogorresistente recibiendo cobertura antibiotica con quinolóna de acuerdo a perfil de sensibilidad, completando el esquema propuesto. Actualmente en su postoperatorio de taqueostomía vía abierta, procedimiento realizado por servicio de ORL el 28/03/22, y debido imposibilidad de uso de vía oral dado componente neurológico por lo que se realizó gastrostomía endoscópica percutánea, realizado por servicio de gastroenterología el día 05/04/22 sin ninguna complicación.

En ronda de la noche encuentro a paciente en regulares condiciones generales, bajo ventilación mecánica a través de cánula de traqueostomía, modo AC/V en ventilador institucional, sin uso de sedantes, con estado neurológico estacionario; glasgow 9/15 puntos (AO: 3 RV: 1 RM: 5); a nivel hemodinámico frecuencias cardíacas y cifras tensionales dentro de parámetros normales, a nivel renal anúrica en paciente renal crónica en terapia de reemplazo renal peritoneal diaria, paciente recibiendo aporte calórico con dextrosados dada distensión abdominal, regular control metabólico.

Paciente femenina quien evoluciona en marco de diagnósticos descritos de momento acoplada ventilatoriamente a ventilador institucional, sin nuevos episodios de asincronía ni desacople. Indico reiniciar soporte nutricional con alimento tipo glucerna por gastrostomía e inicio de procinético para mejorar tránsito intestinal, indico suspender aporte de dextrosados una vez reiniciada la alimentación. En ronda nocturna indico continuar manejo médico instaurado y vigilancia estricta de signos vitales, pronóstico sujeto a evolución.

Seguimiento por los servicios de terapia física crítica, terapia ocupacional, fonoaudiología para rehabilitación temprana y precoz de paciente, terapia respiratoria integral, psicología crítica y trabajo social para reintegro al medio y núcleo familiar, soporte nutricional y metabólico críticos.

Debe permanecer en la unidad de cuidados intensivos por tratarse con requerimiento de ventilación mecánica invasiva; además de necesidad de monitoreo continuo, vigilancia estricta de parámetros hemodinámicos, ventilatorios, neurológicos y metabólicos.

Fecha: 15/04/2022: 22:05:03, Historia: Evolucion Clínica UCI, Prestador: JUAN PABLO ORTIZ SALAZAR, Especialidad: CUIDADO DEL PACIENTE EN ESTADO CRÍTICO

Análisis:

NOTA RETROSPECTIVA

SE RECIBE LLAMADO DE ENFERMERIA DADO DESCENSO DE FRECUENCIA CARDÍACA CON BRADICARDIA EXTREMA, HIPOTENSION Y EPISODIO DE DESATURACION MARCADA. SE INGRESA A SALA PARA REVISIÓN DE PACIENTE EN DONDE SE EVIDENCIA BRADICARDIA EXTREMA CON FRECUENCIA CARDÍACA EN 31 LPM, DESATURACION DE 74% AL VISOSCOPIO, HIPOTENSION, SIN RESPUESTA AL LLAMADO. PACIENTE QUIEN POSTERIOR A ESTO, ENTRA PARADA CARDIORRESPIRATORIA CON RITMO DE ASISTOLIA.

DADO CONDICION BASE DE LA PACIENTE CON MAL PRONOSTICO A CORTO PLAZO. SE CONSIDERA NO SE BENEFICIA DE MANIOBRAS DE REANIMACION CARDIOPULMONAR POR LO QUE SE AJUSTA MANEJO DE FIN DE VIDA. SE DECLARA PACIENTE FALLECIDA A LAS 21:45 HORAS. SE INFORMA A FAMILIARES. SE LLENARUAF.

Procedimientos Realizados y Ordenados:

Medicamentos Ordenados y Administrados:

Medidas Generales Ordenadas:

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:20:11 p. m.

Admisión: AD715724

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: SOL BEATRIZ GARCIA MARQUEZ

EPICRISIS

Justificación de indicaciones Terapéuticas:

Complicaciones:

BRADICARDIA EXTREMA
PARADA CARDIORRESPIRATORIA RITMO ASISTOLIA
MUERTE

Servicio de Egreso: 09|Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)

Fecha de Egreso: 15/04/2022 22:28

Motivo de Salida: Muerte

Estado a la Salida:

Muerto

DIAGNÓSTICOS DE SALIDA:

Diagnóstico Principal: R001 : BRADICARDIA, NO ESPECIFICADA

Diagnóstico Relacionado 1: J961 : INSUFICIENCIA RESPIRATORIA CRONICA

Diagnóstico Relacionado 2: A152 : TUBERCULOSIS DEL PULMON, CONFIRMADA HISTOLOGICAMENTE

PLAN ATENCIÓN INTEGRAL POR
MEDICINA:

Tratamiento Farmacológico:

BRADICARDIA EXTREMA
PARADA CARDIORRESPIRATORIA RITMO ASISTOLIA
MUERTE

Recomendaciones Adicionales:

BRADICARDIA EXTREMA
PARADA CARDIORRESPIRATORIA RITMO ASISTOLIA
MUERTE

Aplica Cuidados de Enfermería: No



JUAN PABLO ORTIZ SALAZAR
CUIDADO DEL PACIENTE EN ESTADO
CRÍTICO
CC.79691950 - RM.73086-02